

Buku Referensi
**KEPERAWATAN
GERONTIK**

Dan Tantangan Penuaan Populasi Di Indonesia

Ni Made Riasmini • Fenti Hasnani • Iskim Luthfa
Donny Hendra • Mela Hayani



BUKU REFERENSI : KEPERAWATAN GERONTIK DAN TANTANGAN PENUAAN POPULASI DI INDONESIA

Penulis

Dr. Ni Made Riasmini, S.Kp., M.Kes., Sp.Kom.

Fenti Hasnani, S.Kep., Ners., M.A.Kes.

Dr. Iskim Luthfa, S.Kep., Ns., M.Kep.

Dr. Donny Hendra, S.Kep., Ns., M.Kep.

Ns. Mela Hayani, S.Kep., M.Kep.



**Optimal
Untuk
Negeri**

Buku Referensi : Keperawatan Gerontik Dan Tantangan Penuaan Populasi Di Indonesia

Penulis:

Dr. Ni Made Riasmini, S.Kp., M.Kes., Sp.Kom.

Fenti Hasnani, S.Kep., Ners., MA.Kes.

Dr. Iskim Luthfa, S.Kep., Ns., M.Kep.

Dr. Donny Hendra, S.Kep., Ns., M.Kep.

Ns. Mela Hayani, S.Kep., M.Kep.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Khoirul Anam

ISBN: 978-634-7556-98-1

Cetakan Pertama: Mei, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku referensi *Keperawatan Gerontik dan Tantangan Penuaan Populasi di Indonesia*. Buku ini disusun sebagai respons akademik dan profesional terhadap fenomena penuaan penduduk yang semakin nyata di Indonesia serta implikasinya terhadap sistem pelayanan kesehatan, khususnya praktik keperawatan gerontik.

Perubahan struktur demografi yang ditandai dengan meningkatnya angka harapan hidup dan proporsi penduduk lanjut usia membawa konsekuensi yang kompleks. Lansia tidak hanya menghadapi proses penuaan fisiologis, tetapi juga berbagai permasalahan kesehatan seperti penyakit kronis ganda (multimorbiditas), gangguan kognitif, hingga kebutuhan perawatan paliatif. Kondisi tersebut menuntut kesiapan tenaga kesehatan, terutama perawat, dalam memberikan asuhan yang komprehensif, holistik, berkesinambungan, dan berorientasi pada kualitas hidup.

Buku ini diawali dengan pembahasan mengenai demografi penuaan di Indonesia, yang memberikan gambaran tren dan proyeksi populasi lansia serta dampaknya terhadap sistem kesehatan dan sosial. Selanjutnya, konsep healthy aging diuraikan sebagai landasan filosofis dan praktis dalam mendorong lansia tetap aktif, mandiri, dan produktif melalui pendekatan promotif dan preventif.

Pada bagian klinis, buku ini mengkaji asuhan keperawatan pada lansia dengan multimorbiditas, yang menekankan pentingnya pendekatan individual, manajemen penyakit kronis terpadu, serta koordinasi interprofesional. Pembahasan mengenai gangguan kognitif dan demensia disajikan untuk meningkatkan pemahaman tentang deteksi dini, intervensi keperawatan, serta dukungan psikososial bagi pasien dan keluarga.

Lebih lanjut, buku ini membahas perawatan paliatif dan end-of-life care sebagai bagian integral dari pelayanan gerontik, dengan menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, manajemen gejala, komunikasi terapeutik, serta pengambilan keputusan yang beretika. Aspek dukungan keluarga dan caregiver burden turut diangkat sebagai isu penting, mengingat peran keluarga dalam budaya Indonesia sangat dominan dalam merawat lansia. Beban fisik, emosional, dan sosial yang dialami caregiver perlu mendapat perhatian melalui intervensi edukatif dan sistem dukungan yang memadai.

Sebagai penutup, buku ini menguraikan model pelayanan gerontik berbasis komunitas, yang menekankan pendekatan promotif-preventif, pemberdayaan masyarakat, serta integrasi layanan primer dalam mendukung lansia tetap tinggal di komunitas dengan kualitas hidup yang optimal.

Buku referensi ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi mahasiswa keperawatan, dosen, praktisi kesehatan, peneliti, serta pemangku kebijakan dalam memahami dan mengembangkan praktik keperawatan gerontik yang responsif terhadap tantangan penuaan populasi di Indonesia. Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Semoga buku ini memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas asuhan keperawatan bagi lansia serta mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang sehat, bermartabat, dan inklusif bagi seluruh kelompok usia.

Mei, 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 DEMOGRAFI PENUAAN DI INDONESIA.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Jumlah Penduduk Lanjut Usia	1
C. Aging Population.....	2
D. Demografi Penyebaran Penduduk Lansia.....	4
E. Demografi Lansia Di Rumah Tangga	5
F. Demografi Lansia Berdasarkan Gender dan Tempat Tinggal	6
G. Demografi Lansia Berdasarkan Angka Harapan Hidup.....	8
H. Demografi Lansia Berdasarkan Kesejahteraan Lansia.....	9
I. Penutup.....	12
Referensi	13
Glosarium.....	16
BAB 2 KONSEP HEALTHY AGING.....	17
A. Pendahuluan.....	17
B. Definisi dan Terminologi Healthy Aging	18
C. Determinan Healthy Aging.....	21
D. Dimensi Healthy Aging	23
E. Indikator dan Pengukuran Healthy Aging	25
F. Strategi Mewujudkan Healthy Aging.....	27
G. Peran Keperawatan dalam Healthy Aging	29
H. Tantangan dan Isu dalam Healthy Aging.....	31
I. Penutup.....	33
Referensi	35
Glosarium.....	36
BAB 3 PERAWATAN PALIATIF DAN END-OF-LIFE-CARE.....	38
A. Pendahuluan.....	38
B. Perawatan Paliatif	39
C. Ruang Lingkup Keperawatan Paliatif.....	44
D. Peran Perawat dalam Keperawatan Paliatif Sebagai Care Provider.....	48
E. Perawatan Paliatif Pada Lansia.....	50
F. Perawatan Akhir Kehidupan (End of Life Care)	55

G. Penutup	62
Referensi	63
Glosarium	66

BAB 4 DUKUNGAN KELUARGA DAN CAREGIVER BURDEN DALAM

KEPERAWATAN GERONTIK	72
A. Pendahuluan.....	72
B. Konsep Peran Keluarga dalam Keperawatan keluarga	73
C. Konsep Caregiver Burden dalam Perawatan Lansia	75
D. Faktor yang Mempengaruhi Caregiver Burden.....	77
E. Dukungan Keluarga Sebagai Strategi Mengurangi Caregiver Burden	79
F. Peran Perawat dalam Mendukung Keluarga dan Caregiver	81
G. Strategi Adaptif dalam Mengatasi Caregiver Burden.....	83
H. Penutup	86
Referensi	87

BAB 5 MODEL PELAYANAN GERONTIK BERBASIS KOMUNITAS

A. Pendahuluan.....	89
B. Konsep Pelayanan Gerontik Berbasis Komunitas.....	89
C. Community-Based Elderly Care	92
D. Integrated Care for Older People (ICOPE)	94
E. Chronic Care Model	96
F. Home-Based Care Model.....	99
G. Intergenerational Care Model	101
H. Analisis Kelebihan dan Keterbatasan Model.....	102
I. Implikasi bagi Pengembangan Pelayanan Lansia di Indonesia.....	104
J. Penutup	106
Referensi	107
Glosarium	110

PROFIL PENULIS

BAB 1

DEMOGRAFI PENUAAN DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Kependudukan merupakan modal dasar dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Fenomena penuaan penduduk atau *aging population* menjadi isu penting yang dihadapi berbagai negara, termasuk Indonesia. Meningkatnya angka harapan hidup dan menurunnya tingkat fertilitas telah mendorong bertambahnya proporsi penduduk lanjut usia dari tahun ke tahun. Kondisi ini berdampak luas terhadap aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan, sehingga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat. Di Indonesia, upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak lansia diatur melalui Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yang menekankan pada peningkatan kualitas hidup, kemandirian, serta peran aktif lansia dalam Pembangunan (BPHN, 1998). Kehadiran regulasi tersebut menjadi dasar hukum penting untuk memastikan bahwa kesejahteraan lanjut usia tidak hanya dilihat dari aspek pemeliharaan kesehatan, tetapi juga dari dukungan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang layak.

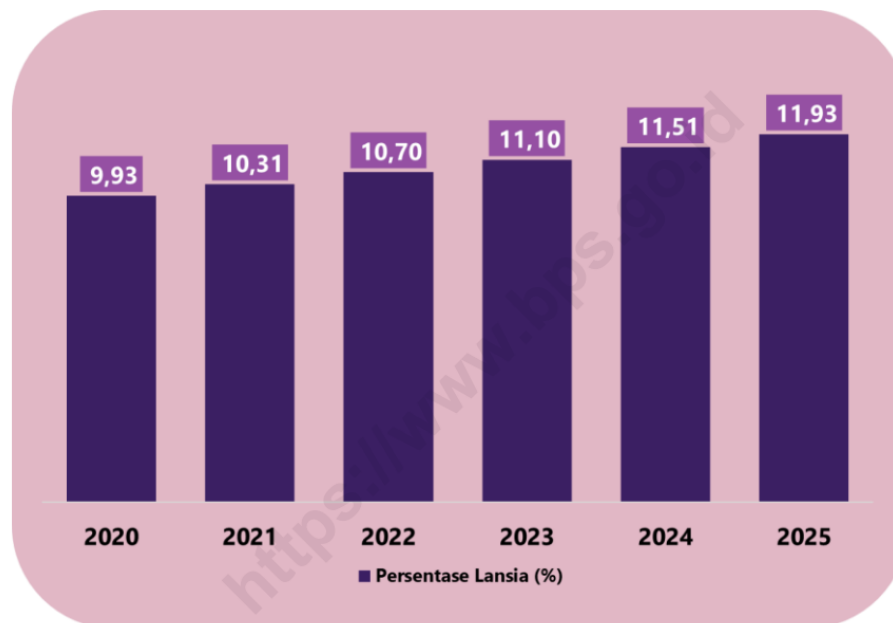
Kebijakan yang responsif terhadap penduduk lansia diperlukan agar proses penuaan penduduk tidak menjadi beban, melainkan dapat menjadi potensi dalam pembangunan berkelanjutan. Data kelanjut-usiaan memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar pemetaan dan pengembangan strategi kebijakan yang tepat guna mencapai kesejahteraan lansia secara menyeluruh.

B. Jumlah Penduduk Lanjut Usia

Pada tahun 2030, diperkirakan setidaknya 1 dari 6 orang di dunia akan berusia 60 tahun atau lebih. Saat ini, proporsi penduduk berusia 60 tahun ke atas meningkat dari 1 miliar pada tahun 2020 menjadi 1,4 miliar di tahun 2024. Berdasarkan hasil proyeksi, jumlah populasi penduduk berusia 60 tahun ke atas di dunia kembali mengalami peningkatan dua kali lipat (2,1 miliar) pada tahun 2050. Selain jumlah dan proporsi lansia secara keseluruhan yang mengalami peningkatan, seiring dengan meningkatnya umur harapan hidup, proporsi lansia tua (80 tahun ke atas) juga mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu 2020 sampai 2050 jumlahnya diperkirakan meningkat tiga kali lipat hingga mencapai 426 juta jiwa. Dari data tersebut juga diperkirakan bahwa pada tahun 2050, dua pertiga penduduk dunia

yang berusia di atas 60 tahun akan tinggal di negaranegara berpendapatan rendah dan menengah (WHO, 2025).

Pertumbuhan penduduk yang semakin cepat sangat berpengaruh besar terhadap komposisi, distribusi dan tingkat perkembangan penduduk. Selama lima tahun terakhir (2020–2025) persentase lansia Indonesia mengalami peningkatan yang konsisten dari 9,93 persen pada tahun 2020 menjadi 11,93 persen pada tahun 2025 (Badan Pusat Statistik, 2025).



Gambar 1. 1 Presentase Lansia

Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia hasil Sensus Penduduk 2020
Gambar 1.1 Persentase Lansia Indonesia, 2020–2025.

C. Aging Population

Sejak tahun 2021, Indonesia telah memasuki fase struktur penduduk tua (*aging population*) atau penuaan penduduk, di mana sekitar 1 dari 10 penduduk adalah lanjut usia (lansia). *Aging population* diartikan sebagai proses transisi demografi, yang merupakan hasil dari perubahan jumlah kelahiran dan kematian yang tinggi menjadi kelahiran dan kematian yang rendah (Yonatan, 2025).

Fenomena *aging population* menjadi salah satu isu demografi penting yang dihadapi hampir semua negara di dunia. Fenomena ini bisa menjadi bonus demografi kedua, yaitu ketika proporsi lansia semakin banyak tetapi masih produktif dan dapat memberikan sumbangan bagi perekonomian negara, namun sekaligus dapat menjadi tantangan pembangunan ketika tidak produktif dan menjadi bagian dari penduduk rentan.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan periode 2021–2030 sebagai *Decade of Healthy Ageing* PBB dan menunjuk WHO untuk memimpin pelaksanaannya. *Decade of Healthy Ageing* PBB merupakan kolaborasi global yang mempertemukan pemerintah, masyarakat sipil, lembaga internasional, tenaga profesional, akademisi, media, dan sektor swasta dalam aksi bersama selama 10 tahun yang bersifat terarah, katalitik, dan kolaboratif untuk mendorong kehidupan yang lebih panjang dan lebih sehat (WHO, 2025).

Dekade ini dibangun berdasarkan Strategi Global dan Rencana Aksi WHO serta Rencana Aksi Internasional Madrid tentang Penuaan dari PBB, serta mendukung pencapaian Agenda 2030 PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (WHO, 2025).

Decade of Healthy Ageing PBB (2021–2030) bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup lansia, keluarga mereka, serta komunitas melalui aksi kolektif dalam empat bidang utama: mengubah cara kita berpikir, merasakan, dan bertindak terhadap usia serta diskriminasi usia (ageisme); mengembangkan komunitas yang mendukung kemampuan lansia; menyediakan layanan kesehatan terpadu yang berpusat pada individu serta layanan kesehatan primer yang responsif terhadap kebutuhan lansia; dan memastikan lansia yang membutuhkan mendapatkan akses terhadap perawatan jangka panjang yang berkualitas (WHO, 2025).

Peningkatan harapan hidup akibat kemajuan di bidang kesehatan, gizi, dan teknologi, serta penurunan angka kelahiran secara global, menyebabkan proporsi penduduk lanjut usia terus bertambah. Data WHO mencatat bahwa Jumlah penduduk berusia 60 tahun ke atas di seluruh dunia diproyeksikan meningkat dari 1,1 miliar pada tahun 2023 menjadi 1,4 miliar pada tahun 2030. Jumlah penduduk berusia di atas 60 tahun telah meningkat lebih dari dua kali lipat dalam tiga dekade terakhir, mencapai 1,2 miliar jiwa. Pada tahun 2050, 900 juta lansia lainnya akan menjadi bagian dari keluarga (WHO, 2025). Ini adalah sebuah pergeseran demografis yang mendalam, dengan implikasi luas bagi perekonomian, sistem kesehatan, dan kohesi sosial (WHO, 2025).

Fenomena aging population sebenarnya dapat berpotensi menjadi bonus demografi kedua apabila penduduk lansia masih dalam kondisi produktif dan dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian negara, salah satunya dengan mencapai penuaan aktif (*active ageing*). Penuaan aktif (*active ageing*) merupakan kerangka kerja yang digunakan oleh WHO, yang memandang usia tua sebagai kesempatan untuk menjadi sehat, berpartisipasi di masyarakat, dan aman (termasuk aman secara ekonomi) (Amir 2022). Konsep *active ageing* diharapkan dapat memaksimalkan potensi lansia yang bertujuan menciptakan lansia yang mandiri baik secara fisik

maupun finansial dan pada akhirnya meningkatkan jumlah lansia produktif di masa depan. Dorongan untuk menjaga produktivitas lansia sesuai dengan kapasitasnya, terutama melalui integrasi teknologi dan kebijakan demografi, diharapkan dapat menghindarkan penduduk lansia dari menjadi beban keluarga dan masyarakat dan sebaliknya justru dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Profil Penduduk Lansia.

D. Demografi Penyebaran Penduduk Lansia.

Sejak tahun 2021, Indonesia Jika dilihat berdasarkan penyebarannya pada level provinsi, setidaknya ada 16 provinsi yang telah memasuki fase struktur penduduk tua karena persentase penduduk lansia yang sudah di atas 10 persen. Provinsi DI Yogyakarta menempati posisi teratas dengan persentase lansia sebesar 17,78 persen. Jawa Timur menyusul dengan persentase lansia sebesar 15,40 persen, diikuti oleh Bali dengan persentase lansia sekitar 15,03 persen. Sedangkan provinsi dengan proporsi penduduk lansia terendah yakni Provinsi Papua Tengah sebesar 6,69 persen (Badan Pusat Statistik, 2025).



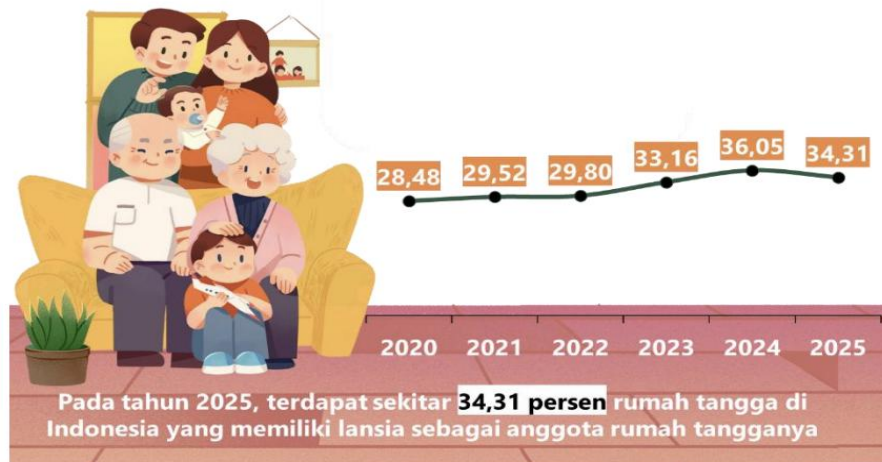
Gambar 1. 2 Persentase Lansia Menurut Provinsi, 2025

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia hasil Sensus Penduduk 2020

Peningkatan jumlah lansia merata di berbagai wilayah, seringkali terkait dengan peningkatan usia harapan hidup, yang mencapai 74,15 tahun pada awal 2025.

E. Demografi Lansia Di Rumah Tangga

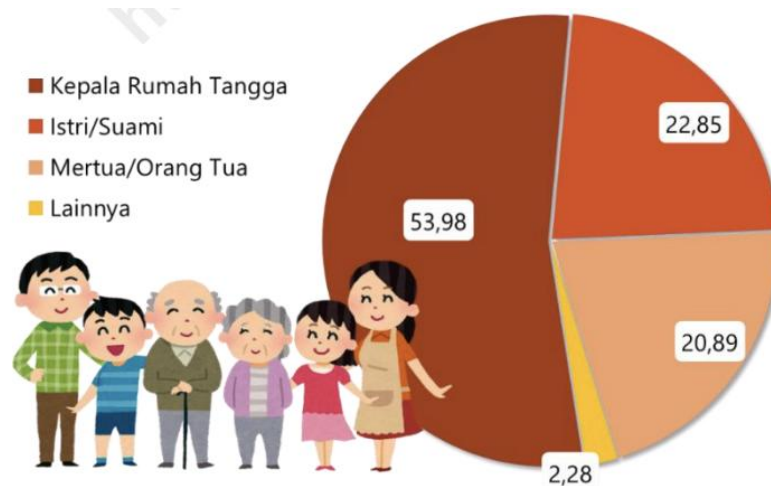
Berdasarkan data demografi lansia Rumah tangga lansia adalah rumah tangga yang memiliki penduduk lanjut usia sebagai anggota keluarganya, baik sebagai kepala rumah tangga, atau sebagai anggota rumah tangga. Gambar 2.5 menunjukkan bahwa persentase rumah tangga lansia meningkat secara konsisten dari tahun 2020 (28,48 persen) hingga mencapai puncaknya pada tahun 2024 (36,05 persen). Pada tahun 2025, terjadi sedikit penurunan menjadi 34,31 persen. Angka ini masih belum bisa menggambarkan bagaimana kondisi rumah tangga lansia, apa peran lansia dalam rumah tangga tersebut, dan dengan siapa para lansia ini tinggal dalam rumah tangga tersebut. Analisa-analisa tersebut terjelaskan berikutnya.



Gambar 1. 3 Tren Persentase Rumah Tangga Lansia, 2020–2025

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020–2025

Peranan di dalam rumah tangga dengan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga (KRT) yang sangat besar dari sisi psikologis maupun ekonomis, ternyata masih banyak diemban oleh penduduk lansia yang seharusnya menikmati hari tua tanpa beban berat. Pada tahun 2025, sekitar 53,98 persen lansia merupakan kepala rumah tangga (KRT). Sementara itu, sisanya merupakan anggota rumah tangga yang meliputi pasangan KRT, mertua/orang tua dari KRT, dan anggota rumah tangga lainnya (Badan Pusat Statistik, 2025).



Gambar 1. 4 Persentase Lansia Menurut Status Keanggotaan Rumah Tangga, 2025.

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Namun, jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, terjadi ketimpangan yang sangat signifikan, dimana lansia laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga jauh lebih besar dibanding lansia perempuan (85,86 persen berbanding 24,69 persen). Selanjutnya, berdasarkan kelompok umur, semakin tua umur seorang lansia, maka peluangnya untuk menjadi kepala rumah tangga semakin kecil (Badan Pusat Statistik, 2025).

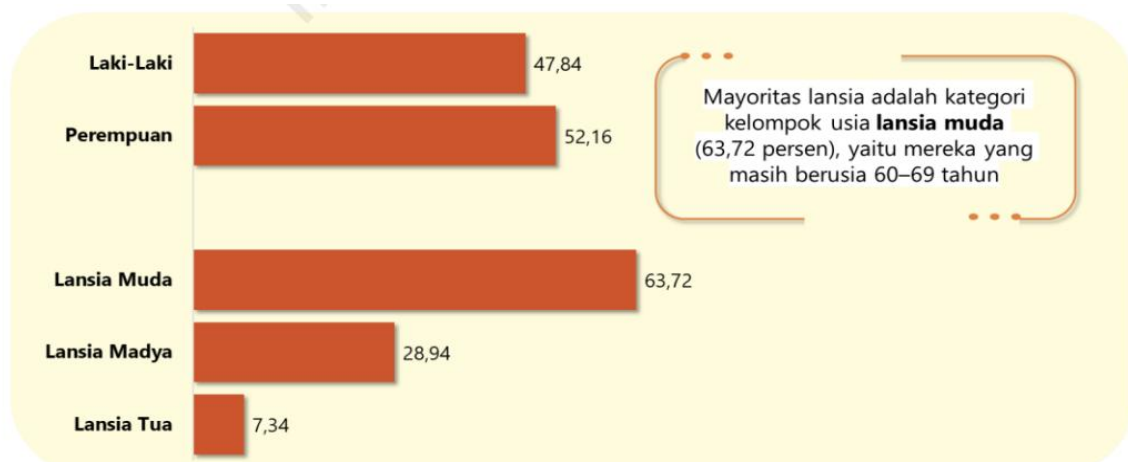


Gambar 1. 5 Persentase Lansia Menurut Keanggotaan di Rumah Tangga, 2025.

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

F. Demografi Lansia Berdasarkan Gender dan Tempat Tinggal

Berdasarkan aspek demografi, Lansia lebih banyak berjenis kelamin perempuan dan tergolong lansia muda (60–69 tahun). Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi dengan proporsi lansia terbesar yaitu 17,78 persen. Mayoritas lansia tinggal dalam rumah tangga yang berisi tiga generasi (33,44 persen) dan bersama keluarga inti (36,08 persen) (Badan Pusat Statistik, 2025).



Gambar 1. 6 Persentase Lansia Menurut Karakteristik, 2025

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia hasil Sensus Penduduk 2020

Pada tahun 2025, mayoritas lansia tinggal di rumah dengan status milik sendiri atau milik anggota rumah tangga yang lain (93,15 persen), sisanya tinggal di rumah bebas sewa (5,09 persen), dan kontrak atau sewa (1,63 persen). Selain dukungan ekonomi, lansia membutuhkan dukungan sosial untuk menjaga kualitas hidupnya. Sekitar 53,98 persen lansia sebagai kepala rumah tangga. Sebanyak 67,15 persen lansia masih memiliki pasangan (Badan Pusat Statistik, 2025).

Jika dilihat menurut jenis kelamin, lansia yang berstatus kawin didominasi oleh lansia laki-laki (86,18 persen) dibandingkan lansia perempuan (49,66 persen), sedangkan lansia yang berstatus cerai mati didominasi oleh lansia perempuan (46,71 persen) dibandingkan lansia laki-laki (12,15 persen) (Badan Pusat Statistik, 2025).

Besarnya proporsi lansia perempuan daripada lansia laki-laki ini menunjukkan bahwa angka harapan hidup perempuan yang lebih tinggi. Lansia mengalami *ageism* yaitu stereotipe negatif atau positif, prasangka dan/atau diskriminasi terhadap orang tua berdasarkan usia kronologis mereka. Atas dasar persepsi mereka sebagai "tua" "renta" atau "uzur", lansia dianggap tidak lagi produktif. Komnas Perempuan mencatat 191 kasus kekerasan terhadap perempuan lansia, 158 di ranah personal, 30 di ranah publik, dan 3 lainnya di ranah negara. Kekerasan berbasis usia dan gender dapat mengakibatkan memburuknya kondisi kesehatan lansia. (KOMNAS PEREMPUAN, 2024).

G. Demografi Lansia Berdasarkan Angka Harapan Hidup

Berdasarkan data BPS tahun 2024, Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan Indonesia konsisten lebih panjang (74,21 tahun) dibandingkan laki-laki (70,23 tahun). Pada tahun 2023, 52,28% lansia di Indonesia adalah perempuan, sementara 47,72% adalah laki-laki (Badan Pusat Statistik, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa perempuan cenderung memiliki umur harapan hidup lebih panjang. Peningkatan AHH ini merupakan indikator positif, namun sekaligus menandakan bahwa Indonesia akan menghadapi tantangan yang semakin besar dalam memastikan lansia dapat hidup secara sehat, mandiri, dan bermartabat (Badan Pusat Statistik, 2025).

Tabel 1. 1 Persentase Umur Haran Hidup Lansia, 2025

Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (Tahun 2024)

38 Provinsi	Laki-laki	Perempuan
ACEH	68,52	72,45
SUMATERA UTARA	68,36	72,3
SUMATERA BARAT	68,41	72,35
RIAU	70,56	74,58
JAMBI	70,09	74,09
SUMATERA SELATAN	69	72,95
BENGKULU	68,21	72,15
LAMPUNG	69,56	73,54
KEP. BANGKA BELITUNG	69,55	73,52
KEP. RIAU	69,3	73,27
DKI JAKARTA	72,08	76,28
JAWA BARAT	72,26	76,56
JAWA TENGAH	73,21	76,99
DI YOGYAKARTA	73,66	77,4
JAWA TIMUR	70,39	74,4
BANTEN	69,09	73,04
BALI	71,19	75,49
NUSA TENGGARA BARAT	65,79	69,77
NUSA TENGGARA TIMUR	66,04	70,03
KALIMANTAN BARAT	69,61	73,59
KALIMANTAN TENGAH	68,51	72,44
KALIMANTAN SELATAN	67,72	71,67
KALIMANTAN TIMUR	73,21	76,9
KALIMANTAN UTARA	70,76	74,79
SULAWESI UTARA	70,73	74,76
SULAWESI TENGAH	67,49	71,44
SULAWESI SELATAN	69,49	73,47
SULAWESI TENGGARA	69,66	73,64

GORONTALO	67,16	71,12
SULAWESI BARAT	64,37	68,27
MALUKU	65,05	68,96
MALUKU UTARA	67,28	71,36
PAPUA BARAT	65,13	69,07
PAPUA BARAT DAYA	65,88	69,82
PAPUA	66,76	70,79
PAPUA SELATAN	64,53	68,42
PAPUA TENGAH	65,05	68,97
PAPUA PEGUNUNGAN	62,83	66,68
INDONESIA	70,32	74,21

Sumber: BPS, 2024

Umur harapan hidup juga meningkat dari 70,78 tahun pada 2015 menjadi 72,39 tahun pada 2024. Hal ini berarti, setiap penduduk yang lahir pada 2024 setidaknya mempunyai kesempatan untuk hidup hingga usia 72 tahun (Badan Pusat Statistik, 2024).

Data menunjukkan bahwa satu dari lima lansia mengalami keluhan kesehatan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Meskipun angka harapan hidup (*life expectancy*) di Indonesia mencapai 71,85 tahun, namun harapan hidup sehat (*Healthy Life Expectancy/HALE*) hanya sekitar 62,8 tahun. Artinya, rata-rata penduduk Indonesia menghabiskan sekitar sembilan tahun dalam kondisi tidak sehat pada usia tua (Kemenko PMK, 2025).

Tantangan yang dihadapi lansia di Indonesia cukup signifikan, terutama terkait dengan kemandirian dan kesehatan. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi tingkat ketergantungan pada penduduk umur ≥ 60 tahun menunjukkan bahwa 95% lanjut usia mandiri; 2,1% dengan ketergantungan ringan, dan 2,9% mengalami ketergantungan sedang hingga total dan memerlukan bantuan dalam aktivitas sehari-hari (Kemenkes RI, 2026).

H. Demografi Lansia Berdasarkan Kesejahteraan Lansia

Peningkatan harapan hidup lansia memiliki dampak luas pada masyarakat, keluarga, dan negara. Meningkatkan kesejahteraan lansia menjadi penting dalam mencapai tujuan SDGs ke-3. Namun, kesan selama ini bahwa lansia lebih dipandang sebagai beban daripada potensi sumber daya manusia bagi pembangunan. Warga lansia ini dianggap sebagai warga yang tidak produktif dan hidupnya perlu ditopang oleh generasi yang lebih muda. Lansia yang masih bekerja, dianggap produktivitasnya sudah menurun, sehingga pada umumnya pendapatan mereka lebih rendah dibandingkan yang diterima oleh penduduk usia muda.

Salah satu permasalahan dari peningkatan jumlah lansia adalah peningkatan rasio ketergantungan lansia. Banyak yang beranggapan bahwa lansia merupakan beban tanggungan bagi anggota rumah tangga yang masih produktif secara ekonomi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia mendefinisikan lanjut usia (lansia) sebagai seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Undang-Undang ini mengatur mengenai upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia yang mencakup pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan, kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum, serta perlindungan sosial. Pemerintah, masyarakat, dan keluarga memiliki tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia. Selain itu, diatur pula pembentukan lembaga dan koordinasi antarinstansi untuk pelaksanaan program kesejahteraan lanjut usia secara terarah dan berkelanjutan (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2026).

Tantangan yang dihadapi lansia di Indonesia cukup signifikan, terutama terkait dengan kemandirian dan kesehatan. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi tingkat ketergantungan pada penduduk umur ≥ 60 tahun menunjukkan bahwa 95% lanjut usia mandiri; 2,1% dengan ketergantungan ringan, dan 2,9% mengalami ketergantungan sedang hingga total dan memerlukan bantuan dalam aktivitas sehari-hari (Kemenkes RI, 2026).



Gambar 1. 7 Tren Persentase Lansia dan Rasio Ketergantungan Lansia, 2020– 2025

Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia hasil Sensus Penduduk 2020

Grafik 1.8 menunjukkan bahwa seiring dengan peningkatan persentase lansia, rasio ketergantungan lansia juga mengalami peningkatan. Ketergantungan lansia ini juga menandakan bahwa bertambahnya jumlah penduduk lansia akan menambah beban ekonomi penduduk usia produktif. Pada tahun 2025, rasio ketergantungan lansia sebesar 11,00. Angka tersebut memiliki arti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif (usia 15–59 tahun) harus menanggung setidaknya 11 penduduk lansia. Kondisi ini mengalami peningkatan sekitar 0,46 poin jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 (Badan Pusat Statistik, 2025).

Sebanyak 83,74% lansia bergantung pada keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hanya sedikit yang bergantung pada dana pensiun dan investasi (Yonatan, 2025).

Menurut laporan Badan Pusat Statistik, 2024, sebanyak 83,74% lansia menggantungkan kebutuhan hidupnya dari penghasilan anggota rumah tangga yang bekerja. Sementara itu, 10,97% bergantung pada kiriman dari pihak lain, 5,01% dari uang pensiun, dan sedikit yang bergantung pada investasi yang dimiliki. Selain itu, mayoritas lansia berada pada rumah tangga dengan distribusi pengeluaran 40% terbawah, yakni mencapai 41,87%. Sisanya sebanyak 37,67% lansia hidup di rumah tangga dengan pengeluaran 40% menengah dan 20,45% pada rumah tangga dengan distribusi pengeluaran 20% teratas (BPS, 2024).

Pada tahun 2024, sebanyak 12% penduduk Indonesia adalah lansia dengan rasio ketergantungan lansia sebesar 17,08. Dalam 1 dekade terakhir dari 2015, proporsi lansia Indonesia meningkat sekitar 4% (BPS, 2024) jumlah ini meningkat berdasarkan aspek demografi, sebesar 11,93 persen penduduk Indonesia pada tahun 2025 adalah lansia dengan rasio ketergantungan lansia sebesar 11,00 (Badan Pusat Statistik, 2025).

Baru-baru ini, pemerintah menaikkan batas usia pensiun menjadi 59 tahun yang mulai berlaku pada Januari 2025 ini. Hal ini berarti, mereka yang tahun ini berusia 58 tahun masih belum bisa pensiun, padahal pada tahun sebelumnya, batas usia pensiun adalah sebesar 58 tahun. Kenaikan ini ditetapkan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Khusus, di mana usia pensiun di Indonesia akan naik 1 tahun setiap 3 tahun sekali hingga maksimal mencapai 65 tahun (BPJS Ketenagakerjaan, 2015). Dengan demikian, pada 2028 mendatang, usia pensiun pekerja Indonesia akan naik menjadi 60 tahun. Kenaikan ini salah satunya bertujuan untuk memberi kesempatan lebih bagi warga Indonesia untuk bekerja dan mengumpulkan tabungan pensiun nanti. Hal ini sejalan dengan temuan BPS yang mengungkapkan bahwa kebanyakan lansia Indonesia masih bergantung secara finansial pada keluarga dan kiriman uang. Hanya segelintir yang masih bisa bergantung mandiri pada uang pensiun dan investasi pribadi.

Tidak semua lansia akan berhenti bekerja atau berhenti dari aktivitas ekonomi. Tuntutan untuk tetap bertahan hidup maupun pemenuhan kebutuhan keluarga menjadikan mereka terpaksa harus tetap bekerja, khususnya mereka yang sebagian besar atau sekitar 78 persen bekerja di sektor informal. Hal ini dikarenakan ketiadaan jaminan sosial seperti dana pensiun dan asuransi sosial bagi lansia, sehingga mereka tetap terjun dalam pasar kerja. Meskipun sebenarnya jenis pekerjaan yang mereka tekuni tidaklah sesuai dengan umur mereka.

Di samping itu, penduduk yang telah memasuki usia lansia biasanya akan diikuti dengan menurunnya produktivitas mereka. Tidak bekerja lagi karena usia lanjut atau pensiun merupakan “momok” psikologis yang dapat berdampak hilangnya kreativitas mereka. Kebijakan pemerintah dalam menyikapi masalah ini dapat diwujudkan melalui beberapa langkah strategis, diantaranya adalah memperluas lapangan pekerjaan khususnya bagi lansia yang berkesesuaian. Namun jenis pekerjaan tersebut hendaknya disesuaikan dengan kondisi fisik mereka (Sjafii, 2025).

I. Penutup

Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia menciptakan berbagai tantangan pada setiap aspek kehidupan. Program pembangunan kelanjutusiaan seyogyanya berangkat dari data konkret dan komprehensif yang menggambarkan kondisi dan potensi penduduk lanjut usia. Jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia terus meningkat. Selain jumlah, persentase penduduk lansia juga mengalami peningkatan yang signifikan. Lonjakan ini dipicu oleh menurunnya angka kelahiran dan kematian, serta kemajuan di bidang kesehatan yang memperpanjang umur harapan hidup. Semua kondisi ini menandai transisi demografi menuju struktur penduduk tua. Tingginya jumlah lansia akan menjadi tantangan pembangunan karena dapat memberi dampak positif, tetapi bisa juga berdampak negatif. Jika penduduk lansia sehat dan produktif, maka hal tersebut bisa menjadi bonus demografi yang kedua bagi Indonesia. Oleh karena itu, jumlah penduduk lansia yang besar itu harus disikapi secara bijak untuk memastikan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka.

Lansia adalah agen perubahan yang berdayaguna tinggi. Suara lansia harus didengarkan dalam perumusan kebijakan, penghentian diskriminasi berbasis usia, dan pembangunan masyarakat yang inklusif. Rasio dukungan pekerja terhadap lansia menurun dari 9 pada 2025 menjadi 6 pada 2045, dan diperkirakan menjadi 3 pada 2050. Penuaan penduduk merupakan suatu proses alamiah yang saat ini menjadi isu global, termasuk di Indonesia. Untuk itu, pemerintah dan pemangku kebijakan harus memberikan perhatian khusus kepada warga lansia mengingat penduduk lansia di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Tantangan ke depan tentunya tidak mudah terutama dalam mempersiapkan agar para lansia tidak menjadi beban, namun harus menjadi potensi yang berkontribusi. Oleh karena itu, kebijakan yang tepat sebagai antisipasi dini diperlukan agar lansia tetap sehat, mandiri, dan produktif di usia senja mereka. Semua kalangan masyarakat dan kelompok usia dapat mengambil manfaat dari kebijaksanaan para lansia. Mereka dapat mengajarkan banyak hal tentang cara menghadapi ketidakpastian, menyelesaikan konflik, dan membangun solidaritas lintas generasi.

Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2025, Desember 12). *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2025*. Retrieved April 2026, from Statistik Penduduk Lanjut Usia 2025: <https://web-api.bps.go.id/download.php?f=ifvDkpamC076eRfpblydWnB5cEh6R0UxaXFMMjZGdGY1SFpDc0tUMTd3UjVPWFZkQzc0b2pRWGJNWUUh3NVFXQS8xVVgySS9xcWtIZzhpWW5xZIE3VklvcTF3VGkwRTBEM3F6bThMbWpLNUVWZUhBc2phMm5WcUJ6VTfDdUZrTHh6ZFZ6MDNyL2NnYXJ5SzcVM01qRTB1WEdkb1Z5bHJFaV>
- BPHN. (1998). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA*. Retrieved from UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA: <https://bphn.go.id/data/documents/98uu013.pdf>
- WHO. (2025, Oktober 1). *Hari Lanjut Usia Internasional 2025 - Pesan Sekretaris Jenderal, António Guterres*. Retrieved April 2026, from Hari Lanjut Usia Internasional 2025 - Pesan Sekretaris Jenderal, António Guterres: <https://indonesia.un.org/id/302037-hari-lanjut-usia-internasional-2025-pesan-sekretaris-jenderal-ant%C3%B3nio-guterres>
- WHO. (2025, Oktober 1). *Hari Lanjut Usia Internasional 2025 - Pesan Sekretaris Jenderal, António Guterres*. Retrieved April 2026, from Hari Lanjut Usia Internasional 2025 - Pesan Sekretaris Jenderal, António Guterres: <https://indonesia.un.org/id/302037-hari-lanjut-usia-internasional-2025-pesan-sekretaris-jenderal-ant%C3%B3nio-guterres>
- JY, A. (2025, Januari). *Penduduk Indonesia Semakin Menua*. Retrieved April 2026, from Penduduk Indonesia Semakin Menua: <https://data.goodstats.id/statistic/penduduk-indonesia-semakin-menua-2Nn8D>
- Yonatan, A. J. (2025, Januari). *Penduduk Indonesia Semakin Menua*. Retrieved April 2026, from Penduduk Indonesia Semakin Menua: <https://data.goodstats.id/statistic/penduduk-indonesia-semakin-menua-2Nn8D>
- WHO. (2024). *Data WHO*. Retrieved April 2026, from Data WHO: <https://data.who.int/countries/360>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *STATISTIK INDONESIA 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Retrieved from STATISTIK INDONESIA 2024: <https://web-api.bps.go.id/download.php?f=jEk7T9MMcAncAb10LJ69mFBadGlnbFIJR0VTdUVjQUhsTGhscy9ISzd0ZjZCWHgyWGtvQmlxZ3FOU0JNN3ovZkdFS>

E5JbmhiZE5sQIZBU1IpY1I2Sy9HM2dIVFpnWGdmTSt3c0JLRTVCWmV1Q
nNsdKpQWWozRnJZYXlnOUgrcE9ucGNoT2dNc2hOZHBmb1ArNS90VzJ
GZ24yQ2ZaT0NnT3

Yonatan, A. J. (2025). *83% Lansia RI Bergantung Secara Finansial pada Keluarga*. Retrieved April 2026, from 83% Lansia RI Bergantung Secara Finansial pada Keluarga: https://goodstats.id/article/83-lansia-ri-bergantung-secara-finansial-pada-keluarga-D4shP?_gl=1*w533v6*_ga*MzIwNjQ5OTcuMTc3NjkyNzUxMw..*_ga_L397ZYDVTX*czE3NzcxNzM5MzkkbzMkZzAkdDE3NzcxNzM5MzkkajYwJGwWJGgw

Yonatan, A. J. (2025). *83% Lansia RI Bergantung Secara Finansial pada Keluarga*. Retrieved April 2026, from https://goodstats.id/article/83-lansia-ri-bergantung-secara-finansial-pada-keluarga-D4shP?_gl=1*w533v6*_ga*MzIwNjQ5OTcuMTc3NjkyNzUxMw..*_ga_L397ZYDVTX*czE3NzcxNzM5MzkkbzMkZzAkdDE3NzcxNzM5MzkkajYwJGwWJGgw

Badan Pusat Statistik. (2024). *STATISTIK PENDUDUK LANJUT USIA 2024*. Retrieved April 2026, from <https://web-api.bps.go.id/download.php?f=kCdbC2AtGDcoXDrEN2g1nCtLMnBLeUdmYVlyM1pGSldRZzYxMEFDYSs1czdPN0tPUWY1aVdXYXIVbys4ZW53NkJXN3N4bGdVSkpIZlo0dIVkSEpxOVFCVlhtSmtQaWRiRWUxcU5Ud0tMQ1FKSyt4cHRJcnVueUJpSjRBVGw4OGh0UkdYbGY2MEd2VldnbDQ5SjNSczR6aXRQcktzODMxRD>

BPS. (2024). *STATISTIK PENDUDUK LANJUT USIA 2024*. Jakarta: BPS.

BPJS Ketenagakerjaan. (2015). *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PENSUN*. Retrieved April 2026, from https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/assets/uploads/peraturan/15122015_104556_PP%2045%20Tahun%202015.pdf

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2026). *undang-undang nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia*. Retrieved April 2026, from <https://dev-jdihn.bphn.go.id/doc/1325414>

Kemenkes RI. (2026). *Hari Lanjut Usia Nasional*. Retrieved from <https://ayosehat.kemkes.go.id/hari-lanjut-usia-nasional>

PEREMPUAN, K. (2024). *Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Lanjut Usia Nasional 29 Mei 2024*. Retrieved April 2026, from <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-lanjut-usia-nasional-29-mei-2024>

KOMNAS PEREMPUAN. (2024). *"Cegah Diskriminasi dan Kekerasan Berlapis terhadap Perempuan Lansia"*. Retrieved from

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-lanjut-usia-nasional-29-mei-2024>

WHO. (2025). *Ageing and health*. Retrieved 2026, from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health>

Sjafii, A. (2025). *Menuju Lansia Mandiri*. Retrieved 2026, from <https://unair.ac.id/menuju-lansia-mandiri/>

Kemenko PMK. (2025). *Kolaborasi Lintas Sektor untuk Memperkuat Mobilitas Penduduk Lanjut Usia*. Retrieved from <https://www.kemenkopmk.go.id/kolaborasi-lintas-sektor-untuk-memperkuat-mobilitas-penduduk-lanjut-usia>

Glosarium

A

Ageing/Aging (Penuaan)

Proses alami yang ditandai dengan perubahan fisik, psikologis, dan sosial seiring bertambahnya usia.

Ageism (Diskriminasi Usia)

Sikap, stereotip, atau perlakuan diskriminatif terhadap seseorang berdasarkan usianya, terutama pada lansia.

D

Demografi Penuaan

Kajian tentang perubahan struktur penduduk yang ditandai dengan meningkatnya jumlah lansia.

K

Kemandirian Lansia

Kemampuan lansia untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bantuan orang lain.

Ketergantungan

Kondisi di mana lansia membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan dasar.

L

Lansia (Lanjut Usia)

Individu yang berusia 60 tahun ke atas.

P

Penuaan Sehat (Healthy Ageing)

Proses mengembangkan dan mempertahankan kemampuan fungsional yang memungkinkan kesejahteraan di usia tua.

BAB 2

KONSEP *HEALTHY AGING*

A. Pendahuluan

Penuaan populasi merupakan fenomena global yang terjadi sebagai konsekuensi dari peningkatan angka harapan hidup dan penurunan angka kelahiran. Kondisi ini juga dialami oleh Indonesia, yang saat ini memasuki era struktur penduduk menua (*ageing population*). Perubahan demografi tersebut membawa implikasi yang luas, baik dalam aspek kesehatan, sosial, maupun ekonomi, sehingga memerlukan perhatian serius dari berbagai sektor, khususnya dalam pelayanan kesehatan.

Seiring dengan meningkatnya jumlah lansia, terjadi pula pergeseran pola penyakit dari penyakit infeksi ke penyakit tidak menular yang bersifat kronis dan degeneratif. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas hidup lansia apabila tidak dikelola secara optimal. Oleh karena itu, paradigma pelayanan kesehatan tidak lagi berfokus pada upaya kuratif semata, tetapi juga mengedepankan pendekatan promotif dan preventif yang berkelanjutan sepanjang siklus kehidupan.

Konsep *healthy aging* menjadi salah satu pendekatan utama dalam menjawab tantangan tersebut. World Health Organization mendefinisikan *healthy aging* sebagai proses pengembangan dan pemeliharaan kemampuan fungsional yang memungkinkan kesejahteraan pada usia lanjut (Rudnicka et al., 2020). Konsep ini menekankan bahwa lansia tidak hanya bebas dari penyakit, tetapi juga mampu mempertahankan kemandirian, berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, serta mencapai kesejahteraan secara fisik, psikologis, sosial, dan spiritual.

Dalam konteks keperawatan gerontik, *healthy aging* menjadi landasan penting dalam merancang intervensi yang komprehensif dan berpusat pada individu. Pendekatan ini tidak hanya memperhatikan kondisi biologis lansia, tetapi juga mempertimbangkan faktor psikososial, lingkungan, serta dukungan keluarga dan komunitas. Dengan demikian, peran perawat menjadi sangat strategis dalam memfasilitasi lansia agar dapat mencapai penuaan yang sehat dan bermakna.

Di Indonesia, implementasi konsep *healthy aging* menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses layanan kesehatan, rendahnya literasi kesehatan, serta perubahan struktur keluarga yang memengaruhi sistem dukungan bagi lansia. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara tenaga kesehatan,

keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung penuaan sehat.

Bab ini akan membahas secara komprehensif mengenai konsep *healthy aging*, termasuk definisi, teori, determinan, dimensi, serta strategi implementasinya dalam praktik keperawatan gerontik, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia.

B. Definisi dan Terminologi *Healthy Aging*

Konsep *healthy aging* berkembang seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap kualitas hidup lansia, tidak hanya dari aspek kesehatan fisik, tetapi juga mencakup dimensi psikologis, sosial, dan spiritual. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan proses penuaan yang optimal, di mana individu tetap mampu mempertahankan fungsi, kemandirian, serta keterlibatan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut World Health Organization, *healthy aging* didefinisikan sebagai proses pengembangan dan pemeliharaan kemampuan fungsional (*functional ability*) yang memungkinkan kesejahteraan pada usia lanjut. Kemampuan fungsional tersebut dipengaruhi oleh interaksi antara kapasitas intrinsik (*intrinsic capacity*), seperti kondisi fisik dan mental individu, dengan lingkungan tempat individu tersebut hidup (Rudnicka et al., 2020). Definisi ini menegaskan bahwa penuaan sehat tidak hanya ditentukan oleh ketiadaan penyakit, tetapi juga oleh kemampuan individu untuk beradaptasi dan menjalani kehidupan secara bermakna.

Dalam literatur gerontologi, terdapat beberapa istilah yang sering digunakan secara bergantian dengan *healthy aging*, namun memiliki perbedaan konseptual yang penting untuk dipahami, yaitu *active aging* (Marzo et al., 2023), *successful aging* (Urtamo et al., 2019), dan *productive aging* (Hernæs et al., 2023).

Istilah *active aging* juga diperkenalkan oleh World Health Organization dan menekankan pada optimalisasi peluang kesehatan, partisipasi, dan keamanan untuk meningkatkan kualitas hidup seiring bertambahnya usia. Fokus utama dari konsep ini adalah keterlibatan aktif lansia dalam kegiatan sosial, ekonomi, budaya, dan spiritual.

Sementara itu, *successful aging* lebih menitikberatkan pada pencapaian kondisi ideal dalam penuaan, yang ditandai dengan rendahnya risiko penyakit dan disabilitas, fungsi kognitif dan fisik yang optimal, serta keterlibatan aktif dalam kehidupan. Konsep ini sering dikaitkan dengan model yang dikembangkan oleh John W. Rowe dan Robert L. Kahn, yang menekankan tiga komponen utama tersebut.

Adapun *productive aging* berfokus pada kontribusi lansia dalam aktivitas yang bernilai, baik dalam bentuk pekerjaan, kegiatan sukarela, maupun peran dalam keluarga dan masyarakat. Konsep ini menempatkan lansia sebagai individu yang tetap produktif dan memiliki peran penting dalam pembangunan sosial.

Perkembangan terminologi ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam memandang lansia, dari kelompok yang identik dengan ketergantungan menjadi kelompok yang memiliki potensi untuk tetap sehat, mandiri, dan berkontribusi. Dalam konteks ini, *healthy aging* dapat dipahami sebagai konsep yang lebih komprehensif dan integratif, karena mencakup berbagai dimensi kehidupan lansia serta mempertimbangkan interaksi antara individu dan lingkungannya.

Dengan memahami perbedaan dan keterkaitan antar istilah tersebut, tenaga kesehatan, khususnya perawat, dapat merancang intervensi yang lebih tepat dan kontekstual dalam mendukung proses penuaan yang sehat. Pendekatan ini menjadi penting dalam praktik keperawatan gerontik, terutama dalam menghadapi tantangan peningkatan jumlah lansia di Indonesia.

Tabel 2. 1 Perbandingan Konsep *Healthy Aging*, *Active Aging*, *Successful Aging*, dan *Productive Aging*

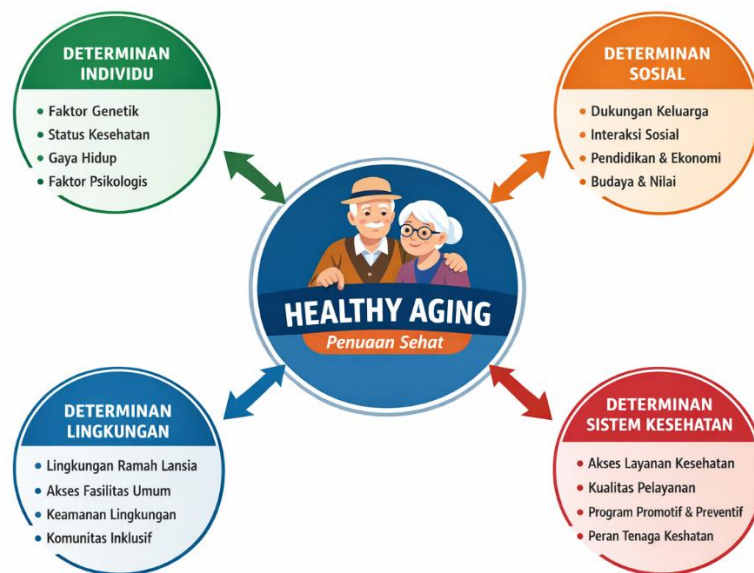
Aspek	<i>Healthy Aging</i>	<i>Active Aging</i>	<i>Successful Aging</i>	<i>Productive Aging</i>
Definisi utama	Proses pengembangan dan pemeliharaan kemampuan fungsional untuk mencapai kesejahteraan lansia	Proses optimalisasi peluang kesehatan, partisipasi, dan keamanan	Kondisi ideal penuaan dengan fungsi optimal dan minim penyakit	Proses penuaan dengan tetap berkontribusi secara sosial dan ekonomi
Tokoh/Pengembang	World Health Organization	World Health Organization	John W. Rowe & Robert L. Kahn	Dikembangkan dalam kajian gerontologi sosial

Fokus utama	Kemampuan fungsional (functional ability)	Partisipasi aktif dalam kehidupan	Fungsi fisik dan kognitif optimal	Kontribusi dan produktivitas lansia
Dimensi yang ditekankan	Fisik, psikologis, sosial, lingkungan, spiritual	Kesehatan, partisipasi, keamanan	Fisik, kognitif, sosial	Sosial, ekonomi
Orientasi pendekatan	Holistik dan integratif	Partisipatif	Ideal/selektif	Utilitarian (berbasis kontribusi)
Pandangan terhadap lansia	Individu yang adaptif dan memiliki potensi	Individu aktif dan terlibat	Individu dengan kondisi optimal	Individu yang produktif dan bernilai
Kelebihan	Komprehensif dan realistis	Mendorong keterlibatan sosial	Memberikan standar penuaan ideal	Menekankan peran sosial lansia
Keterbatasan	Implementasi kompleks	Tidak semua lansia mampu aktif	Terlalu ideal dan eksklusif	Berpotensi mengabaikan lansia dengan keterbatasan
Implikasi keperawatan	Pendekatan holistik berbasis kebutuhan lansia	Mendorong aktivitas dan partisipasi	Fokus pada pencegahan penurunan fungsi	Mendorong pemberdayaan dan peran sosial

Tabel ini menunjukkan bahwa *healthy aging* merupakan konsep yang paling komprehensif karena mengintegrasikan berbagai dimensi kehidupan lansia serta mempertimbangkan interaksi antara individu dan lingkungan. Oleh karena itu, dalam praktik keperawatan gerontik, pendekatan *healthy aging* lebih relevan digunakan sebagai kerangka utama dalam merancang intervensi yang berpusat pada lansia.

C. Determinan *Healthy Aging*

Healthy aging merupakan hasil dari interaksi kompleks berbagai faktor yang memengaruhi kondisi kesehatan dan kesejahteraan lansia sepanjang siklus kehidupan. Determinan tersebut tidak hanya berasal dari individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, lingkungan, serta sistem pelayanan kesehatan. World Health Organization menekankan bahwa kemampuan fungsional lansia terbentuk melalui interaksi antara kapasitas intrinsik dan lingkungan, sehingga pendekatan dalam memahami *healthy aging* harus bersifat multidimensional meliputi determinan individu, sosial, lingkungan dan system kesehatan (Kim, 2023; Tan et al., 2026).



Gambar 2. 1 Determinan *Healthy Aging*

1. Determinan Individu

Determinan individu mencakup faktor-faktor internal yang berasal dari dalam diri lansia, antara lain:

a. Faktor genetic

Faktor genetik berperan dalam menentukan kerentanan terhadap penyakit tertentu, proses penuaan biologis, serta respons terhadap intervensi kesehatan.

b. Status Kesehatan

Kondisi kesehatan yang meliputi keberadaan penyakit kronis, status nutrisi, serta fungsi fisik dan kognitif sangat memengaruhi kualitas hidup lansia.

c. Gaya hidup

Gaya hidup sehat seperti aktivitas fisik teratur, pola makan seimbang, istirahat yang cukup, serta pengelolaan stres merupakan faktor penting dalam mendukung penuaan yang sehat.

d. Faktor psikologis

Kondisi mental seperti kemampuan adaptasi, koping, serta kesejahteraan emosional turut berperan dalam mempertahankan kualitas hidup lansia.

2. Determinan Sosial

Faktor sosial memiliki pengaruh besar terhadap proses penuaan, terutama dalam konteks interaksi dan dukungan yang diterima lansia, meliputi:

a. Dukungan keluarga

Keterlibatan keluarga dalam perawatan dan pengambilan keputusan kesehatan dapat meningkatkan kesejahteraan lansia.

b. Interaksi sosial

Hubungan sosial yang baik dapat mencegah isolasi sosial dan depresi pada lansia.

c. Status pendidikan dan ekonomi

Tingkat pendidikan memengaruhi literasi kesehatan, sedangkan kondisi ekonomi menentukan akses terhadap layanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar.

d. Budaya dan nilai sosial

Norma dan nilai dalam masyarakat memengaruhi cara pandang terhadap lansia serta bentuk dukungan yang diberikan.

3. Determinan Lingkungan

Lingkungan fisik dan sosial tempat lansia tinggal sangat berperan dalam mendukung atau menghambat *healthy aging*, antara lain:

a. Lingkungan tempat tinggal

Hunian yang aman, nyaman, dan ramah lansia dapat meningkatkan kemandirian dan mobilitas.

b. Akses terhadap fasilitas umum

Ketersediaan transportasi, ruang publik, dan fasilitas kesehatan memudahkan lansia dalam beraktivitas.

c. Keamanan lingkungan

Lingkungan yang aman dari risiko kecelakaan dan kekerasan mendukung kualitas hidup lansia.

d. Lingkungan sosial komunitas

Komunitas yang inklusif dan suportif dapat meningkatkan partisipasi sosial lansia.

4. Determinan Sistem Pelayanan Kesehatan

Sistem pelayanan kesehatan merupakan faktor penting dalam mendukung *healthy aging*, yang meliputi:

a. Akses terhadap layanan Kesehatan

Ketersediaan dan keterjangkauan layanan kesehatan primer hingga rujukan sangat menentukan deteksi dini dan penanganan masalah kesehatan lansia.

b. Kualitas pelayanan Kesehatan

Pelayanan yang komprehensif, berkelanjutan, dan berpusat pada pasien akan meningkatkan hasil kesehatan lansia.

c. Program promotif dan preventif

Program seperti skrining kesehatan, edukasi, dan promosi gaya hidup sehat berperan dalam mencegah penurunan fungsi.

d. Peran tenaga kesehatan, khususnya perawat

Perawat memiliki peran strategis dalam memberikan asuhan keperawatan, edukasi, serta pemberdayaan lansia dan keluarga dalam mencapai penuaan sehat.

Keempat determinan tersebut saling berinteraksi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebagai contoh, lansia dengan kondisi kesehatan yang baik (determinasi individu) tetap membutuhkan dukungan keluarga (determinasi sosial) dan lingkungan yang ramah lansia (determinasi lingkungan) agar dapat mempertahankan kemandiriannya. Selain itu, sistem pelayanan kesehatan yang responsif akan memperkuat upaya promotif dan preventif dalam mendukung *healthy aging*.

Dengan memahami determinan *healthy aging* secara komprehensif, perawat dapat merancang intervensi yang lebih efektif, kontekstual, dan berkelanjutan, terutama dalam praktik keperawatan komunitas dan keluarga.

D. Dimensi *Healthy Aging*

Konsep *healthy aging* mencerminkan pendekatan yang holistik dalam memahami proses penuaan, yang tidak hanya berfokus pada kondisi fisik, tetapi juga mencakup aspek psikologis, sosial, dan spiritual. World Health Organization menekankan bahwa kesejahteraan lansia ditentukan oleh kemampuan fungsional yang terbentuk dari interaksi berbagai dimensi kehidupan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dimensi *healthy aging* menjadi penting sebagai dasar dalam merancang intervensi keperawatan yang komprehensif.



Gambar 2. 2 Dimensi *Healthy Aging*

Gambar 2 menggambarkan model konseptual *healthy aging* yang menekankan pendekatan holistik dalam memahami proses penuaan. Model ini terdiri dari empat dimensi utama, yaitu dimensi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual, yang saling berinteraksi secara dinamis dengan *healthy aging* sebagai pusatnya (Menassa et al., 2023).

1. Dimensi Fisik

Dimensi fisik berkaitan dengan kondisi biologis dan fungsi tubuh lansia. Seiring bertambahnya usia, terjadi penurunan fungsi organ, peningkatan risiko penyakit kronis, serta keterbatasan mobilitas. Namun demikian, kondisi fisik yang optimal masih dapat dipertahankan melalui penerapan gaya hidup sehat, seperti aktivitas fisik teratur, nutrisi seimbang, serta pengelolaan penyakit kronis yang baik.

Indikator pada dimensi ini meliputi kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari (*Activity of Daily Living/ADL*), status kesehatan umum, serta tingkat kemandirian lansia. Pemeliharaan dimensi fisik menjadi dasar penting dalam mendukung dimensi lainnya.

2. Dimensi Psikologis

Dimensi psikologis mencakup kesehatan mental dan emosional lansia, termasuk kemampuan kognitif, adaptasi terhadap perubahan, serta kesejahteraan emosional. Lansia sering menghadapi berbagai perubahan, seperti kehilangan pasangan, pensiun, atau penurunan fungsi fisik, yang dapat memengaruhi kondisi psikologis.

Kesehatan psikologis yang baik ditandai dengan kemampuan mengelola stres, memiliki coping yang adaptif, serta mempertahankan fungsi kognitif. Gangguan seperti depresi dan demensia perlu diantisipasi melalui deteksi dini dan intervensi yang tepat.

3. Dimensi Sosial

Dimensi sosial berkaitan dengan hubungan interpersonal, partisipasi dalam masyarakat, serta dukungan sosial yang diterima oleh lansia. Interaksi sosial yang baik dapat meningkatkan rasa memiliki, mengurangi kesepian, serta meningkatkan kualitas hidup.

Partisipasi dalam kegiatan sosial, keterlibatan dalam komunitas, serta dukungan dari keluarga merupakan indikator penting dalam dimensi ini. Lansia yang memiliki jejaring sosial yang kuat cenderung memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik dibandingkan dengan lansia yang mengalami isolasi sosial.

4. Dimensi Spiritual

Dimensi spiritual merupakan aspek penting dalam *healthy aging*, terutama dalam memberikan makna dan tujuan hidup pada lansia. Spiritualitas tidak hanya berkaitan dengan praktik keagamaan, tetapi juga mencakup nilai, keyakinan, serta hubungan individu dengan diri sendiri, orang lain, dan Tuhan.

Kesejahteraan spiritual dapat membantu lansia dalam menghadapi berbagai perubahan dan keterbatasan yang terjadi selama proses penuaan. Lansia dengan tingkat spiritualitas yang baik cenderung memiliki penerimaan diri yang lebih tinggi, serta mampu menjalani kehidupan dengan lebih tenang dan bermakna.

Keempat dimensi tersebut saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Penurunan pada satu dimensi dapat memengaruhi dimensi lainnya. Sebagai contoh, keterbatasan fisik dapat menyebabkan penurunan partisipasi sosial, yang pada akhirnya berdampak pada kondisi psikologis lansia. Sebaliknya, dukungan sosial yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis dan spiritual.

Dalam praktik keperawatan gerontik, pendekatan yang mengintegrasikan seluruh dimensi ini sangat diperlukan untuk mencapai *healthy aging* secara optimal. Perawat tidak hanya berperan dalam menjaga kesehatan fisik, tetapi juga dalam mendukung kesejahteraan psikologis, sosial, dan spiritual lansia melalui intervensi yang holistik dan berpusat pada individu.

E. Indikator dan Pengukuran *Healthy Aging*

Konsep *healthy aging* menekankan pada kemampuan individu untuk mempertahankan fungsi optimal sepanjang proses penuaan, yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, pengukuran *healthy aging* tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus menggunakan pendekatan multidimensional yang komprehensif. Pengukuran ini bertujuan untuk menilai

tingkat keberhasilan lansia dalam mencapai kondisi penuaan yang sehat, serta sebagai dasar dalam perencanaan dan evaluasi intervensi keperawatan.

Indikator *healthy aging* merupakan parameter yang digunakan untuk menilai kondisi lansia pada setiap dimensi kehidupan (Abud et al., 2022). Pada dimensi fisik, indikator yang digunakan antara lain kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari (*Activity of Daily Living/ADL*), tingkat mobilitas, status nutrisi, serta fungsi sensorik seperti penglihatan dan pendengaran. Lansia yang menunjukkan kemandirian dalam aktivitas sehari-hari, memiliki mobilitas yang baik, serta status kesehatan yang terkontrol dapat dikategorikan memiliki kondisi fisik yang optimal dalam konteks *healthy aging*.

Pada dimensi psikologis, indikator meliputi kondisi emosional dan fungsi kognitif. Tingkat depresi, kecemasan, kepuasan hidup, serta kemampuan kognitif seperti memori dan orientasi menjadi aspek penting dalam menilai kesejahteraan psikologis lansia. Lansia yang mampu beradaptasi dengan perubahan, memiliki keseimbangan emosi, serta mempertahankan fungsi kognitif yang baik menunjukkan capaian *healthy aging* pada dimensi ini.

Selanjutnya, dimensi sosial diukur melalui indikator yang berkaitan dengan hubungan interpersonal dan keterlibatan dalam kehidupan sosial. Dukungan sosial dari keluarga dan masyarakat, partisipasi dalam kegiatan sosial, serta tingkat interaksi yang bermakna menjadi faktor penting. Lansia yang tetap aktif dalam kehidupan sosial dan tidak mengalami isolasi sosial cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

Adapun pada dimensi spiritual, indikator yang digunakan mencakup tingkat kesejahteraan spiritual, rasa makna dan tujuan hidup, serta keterlibatan dalam aktivitas keagamaan atau spiritual. Dimensi ini menjadi semakin penting pada lansia karena berkaitan dengan penerimaan terhadap proses penuaan dan kesiapan menghadapi fase akhir kehidupan. Lansia yang memiliki kedamaian batin dan makna hidup yang kuat umumnya menunjukkan kondisi *healthy aging* yang lebih baik.

Dalam praktiknya, pengukuran *healthy aging* dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen yang telah terstandar dan tervalidasi. Pada dimensi fisik, alat ukur seperti *Barthel Index* dan *Katz Index* digunakan untuk menilai kemandirian dalam aktivitas sehari-hari, sementara *Timed Up and Go Test (TUG)* digunakan untuk mengukur mobilitas dan risiko jatuh, serta *Mini Nutritional Assessment (MNA)* untuk menilai status nutrisi. Pada dimensi psikologis, *Geriatric Depression Scale (GDS)* digunakan untuk mengidentifikasi depresi, sedangkan *Mini Mental State Examination (MMSE)* digunakan untuk menilai fungsi kognitif. Selain itu, *WHO-5*

Well-Being Index dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan psikologis secara umum.

Pada dimensi sosial, pengukuran dapat dilakukan menggunakan *Lubben Social Network Scale (LSNS)* untuk menilai jaringan sosial lansia, *Duke Social Support Index (DSSI)* untuk mengukur dukungan sosial, serta *UCLA Loneliness Scale* untuk menilai tingkat kesepian. Sementara itu, pada dimensi spiritual, instrumen seperti *Spiritual Well-Being Scale (SWBS)* dan *Functional Assessment of Chronic Illness Therapy–Spiritual Well-Being (FACIT-Sp)* digunakan untuk menilai kesejahteraan spiritual dan makna hidup lansia.

Pengukuran yang komprehensif terhadap *healthy aging* umumnya dilakukan melalui pendekatan *Comprehensive Geriatric Assessment (CGA)*, yaitu suatu metode pengkajian menyeluruh yang mencakup aspek medis, psikologis, sosial, dan fungsional. Pendekatan ini memungkinkan tenaga kesehatan untuk mengidentifikasi masalah secara lebih akurat serta merancang intervensi yang tepat sesuai dengan kebutuhan individu lansia.

Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan dalam pengukuran *healthy aging*, antara lain heterogenitas kondisi lansia, keterbatasan instrumen yang sesuai dengan konteks budaya lokal, serta adanya hambatan komunikasi akibat gangguan sensorik atau kognitif. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan klinis dan sensitivitas budaya dari tenaga kesehatan dalam melakukan pengkajian.

Dengan demikian, indikator dan pengukuran *healthy aging* memiliki peran yang sangat penting dalam praktik keperawatan gerontik. Pengukuran yang tepat tidak hanya membantu dalam menentukan status kesehatan lansia, tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan klinis, penyusunan intervensi, serta evaluasi keberhasilan program kesehatan. Pendekatan yang holistik dan berkesinambungan menjadi kunci dalam mendukung tercapainya penuaan yang sehat dan berkualitas.

F. Strategi Mewujudkan *Healthy Aging*

Upaya mewujudkan *healthy aging* memerlukan pendekatan yang komprehensif, berkelanjutan, dan berbasis siklus kehidupan (*life-course approach*). Strategi ini tidak hanya berfokus pada lansia sebagai individu, tetapi juga melibatkan keluarga, masyarakat, serta sistem pelayanan kesehatan. Setiap strategi saling melengkapi dan berkontribusi dalam mempertahankan kemampuan fungsional lansia. Dengan demikian, keberhasilan *healthy aging* sangat ditentukan oleh sinergi berbagai pihak dalam menciptakan kondisi yang mendukung penuaan yang sehat dan bermakna. World Health Organization menekankan bahwa penuaan sehat dapat dicapai

melalui optimalisasi kapasitas intrinsik dan penciptaan lingkungan yang mendukung kemampuan fungsional lansia (Cocchi et al., 2025; Kim et al., 2021).

1. Promosi Kesehatan Sepanjang Hayat

Promosi kesehatan merupakan strategi utama dalam mendukung *healthy aging*. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup sehat sejak usia dini hingga lanjut usia. Edukasi mengenai pola makan seimbang, aktivitas fisik teratur, manajemen stres, serta kebiasaan hidup bersih dan sehat menjadi kunci dalam mencegah penurunan fungsi pada lansia. Dalam konteks keperawatan, perawat berperan sebagai edukator yang memberikan informasi dan motivasi kepada individu dan keluarga.

2. Pencegahan Penyakit dan Deteksi Dini

Strategi preventif bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya penyakit kronis dan komplikasi yang dapat menurunkan kualitas hidup lansia. Kegiatan seperti skrining kesehatan secara berkala, imunisasi, serta deteksi dini gangguan kesehatan menjadi bagian penting dalam upaya ini. Pendekatan ini memungkinkan intervensi dilakukan lebih awal sehingga dapat mencegah terjadinya penurunan fungsi yang lebih berat.

3. Manajemen Penyakit Kronis

Seiring dengan meningkatnya usia, lansia cenderung mengalami penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Oleh karena itu, diperlukan strategi manajemen penyakit yang efektif, termasuk pengelolaan terapi, pemantauan kondisi kesehatan, serta peningkatan kepatuhan terhadap pengobatan. Pendekatan *self-management* menjadi penting agar lansia dapat berperan aktif dalam menjaga kesehatannya.

4. Peningkatan Aktivitas Fisik dan Kemandirian

Aktivitas fisik yang teratur terbukti dapat meningkatkan kebugaran, menjaga fungsi otot dan tulang, serta mengurangi risiko penyakit kronis. Selain itu, latihan fisik juga berkontribusi terhadap kesehatan mental dan sosial lansia. Upaya mempertahankan kemandirian dalam aktivitas sehari-hari perlu didukung melalui latihan fungsional, rehabilitasi, serta lingkungan yang aman dan ramah lansia.

5. Dukungan Psikososial dan Kesehatan Mental

Kesehatan mental merupakan bagian integral dari *healthy aging*. Dukungan psikososial dari keluarga dan lingkungan sekitar sangat penting dalam mencegah depresi, kecemasan, serta isolasi sosial pada lansia. Intervensi seperti konseling, terapi kelompok, serta kegiatan sosial dapat membantu meningkatkan kesejahteraan psikologis dan memperkuat hubungan sosial lansia.

6. Penguatan Dimensi Spiritual

Pendekatan spiritual menjadi salah satu strategi penting dalam mendukung penuaan yang sehat, terutama dalam membantu lansia menemukan makna hidup dan menerima perubahan yang terjadi. Kegiatan keagamaan, refleksi diri, serta dukungan spiritual dari keluarga dan tenaga kesehatan dapat meningkatkan ketenangan batin dan kualitas hidup lansia. Dalam praktik keperawatan, aspek spiritual perlu diintegrasikan sebagai bagian dari asuhan yang holistik.

7. Pemberdayaan Lansia dan Keluarga

Pemberdayaan lansia bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan partisipasi aktif dalam kehidupan sehari-hari. Lansia didorong untuk tetap terlibat dalam aktivitas sosial, ekonomi, maupun budaya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Selain itu, keluarga sebagai sistem pendukung utama perlu diberikan edukasi dan keterampilan dalam merawat lansia secara optimal.

8. Pengembangan Lingkungan Ramah Lansia

Lingkungan yang mendukung merupakan faktor penting dalam mewujudkan *healthy aging*. Lingkungan fisik yang aman, akses terhadap fasilitas kesehatan, serta komunitas yang inklusif akan memudahkan lansia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Konsep *age-friendly environment* menjadi salah satu pendekatan yang dapat diterapkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kemandirian lansia.

9. Penguatan Sistem Pelayanan Kesehatan

Sistem pelayanan kesehatan perlu dirancang secara komprehensif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan lansia. Pelayanan kesehatan primer yang terintegrasi, program promotif dan preventif, serta kolaborasi antarprofesi menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Perawat memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan pelayanan, melakukan pengkajian, serta memberikan intervensi yang berpusat pada lansia.

G. Peran Keperawatan dalam *Healthy Aging*

Perawat memiliki peran strategis dalam mewujudkan *healthy aging* melalui pendekatan yang holistik, komprehensif, dan berkesinambungan. Dalam konteks ini, perawat tidak hanya berfokus pada aspek biologis, tetapi juga mencakup dimensi psikologis, sosial, dan spiritual lansia. Keberhasilan perawat dalam menjalankan peran tersebut sangat ditentukan oleh kompetensi profesional, kemampuan komunikasi, serta sensitivitas terhadap kebutuhan lansia. Dengan demikian, perawat menjadi aktor kunci dalam mendukung lansia untuk mencapai kehidupan yang sehat, mandiri, dan bermakna di usia lanjut.

1. Peran sebagai Pemberi Asuhan (Care Provider)

Perawat bertanggung jawab dalam memberikan asuhan keperawatan yang berpusat pada lansia (*patient-centered care*). Asuhan ini meliputi pengkajian komprehensif, penetapan diagnosis keperawatan, perencanaan intervensi, implementasi, serta evaluasi. Dalam praktiknya, perawat perlu mempertimbangkan kondisi fisik, status mental, kemampuan fungsional, serta kebutuhan spiritual lansia untuk mencapai hasil yang optimal.

2. Peran sebagai Edukator

Sebagai edukator, perawat berperan dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran lansia serta keluarganya mengenai pentingnya perilaku hidup sehat. Edukasi mencakup pola makan sehat, aktivitas fisik, kepatuhan pengobatan, serta pencegahan komplikasi penyakit. Selain itu, perawat juga memberikan informasi terkait perawatan mandiri (*self-care*) guna meningkatkan kemandirian lansia.

3. Peran sebagai Promotor Kesehatan

Perawat berperan aktif dalam kegiatan promosi kesehatan melalui pendekatan preventif dan promotif. Upaya ini dilakukan dengan menginisiasi program kesehatan di masyarakat, seperti penyuluhan kesehatan, skrining kesehatan, dan kegiatan berbasis komunitas (misalnya posyandu lansia). Peran ini penting dalam mencegah penurunan fungsi dan meningkatkan kualitas hidup lansia.

4. Peran sebagai Koordinator dan Kolaborator

Dalam mewujudkan *healthy aging*, perawat tidak bekerja sendiri, melainkan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain, keluarga, serta komunitas. Perawat berfungsi sebagai koordinator dalam mengintegrasikan berbagai layanan kesehatan agar lansia mendapatkan pelayanan yang optimal dan berkesinambungan. Kolaborasi interprofesional ini mencakup dokter, fisioterapis, ahli gizi, pekerja sosial, dan tenaga kesehatan lainnya.

5. Peran sebagai Advokat

Perawat berperan sebagai advokat yang memperjuangkan hak-hak lansia dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Hal ini mencakup perlindungan terhadap lansia dari diskriminasi, kekerasan, serta pengabaian. Perawat juga membantu lansia dalam mengambil keputusan terkait kesehatan dengan mempertimbangkan nilai, preferensi, dan kebutuhan individu.

6. Peran sebagai Konselor

Perawat memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada lansia yang menghadapi berbagai perubahan dalam hidupnya, seperti penurunan fungsi, kehilangan pasangan, atau isolasi sosial. Melalui konseling, perawat membantu

lansia dalam mengelola stres, kecemasan, dan depresi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan kualitas hidup.

7. Peran dalam Pemenuhan Kebutuhan Spiritual

Pendekatan spiritual menjadi bagian penting dalam asuhan keperawatan pada lansia. Perawat berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan spiritual, memberikan dukungan, serta memfasilitasi lansia dalam menjalankan praktik keagamaan sesuai keyakinannya. Pemenuhan kebutuhan spiritual ini dapat meningkatkan ketenangan batin dan membantu lansia menghadapi proses penuaan secara lebih adaptif.

8. Peran sebagai Peneliti dan Pengembang Praktik

Perawat juga memiliki peran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan melalui penelitian yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup lansia. Hasil penelitian tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam pengembangan model asuhan keperawatan, inovasi intervensi, serta kebijakan kesehatan yang mendukung *healthy aging*. Peran ini sangat penting dalam memastikan praktik keperawatan berbasis bukti (*evidence-based practice*).

9. Peran sebagai Agen Perubahan (Change Agent)

Perawat berperan sebagai agen perubahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan lansia. Perawat dapat menginisiasi inovasi program, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendorong perubahan perilaku individu dan masyarakat menuju pola hidup yang lebih sehat. Peran ini juga mencakup advokasi terhadap kebijakan yang mendukung kesejahteraan lansia.

H. Tantangan dan Isu dalam *Healthy Aging*

Penuaan penduduk merupakan fenomena global yang membawa implikasi luas terhadap sistem kesehatan, sosial, dan ekonomi. Meskipun konsep *healthy aging* bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia, implementasinya di berbagai negara, termasuk Indonesia, masih menghadapi berbagai tantangan dan isu yang kompleks. World Health Organization menegaskan bahwa keberhasilan *healthy aging* sangat dipengaruhi oleh interaksi antara kapasitas individu dan dukungan lingkungan yang tersedia.

1. Peningkatan Prevalensi Penyakit Kronis

Salah satu tantangan utama dalam *healthy aging* adalah meningkatnya prevalensi penyakit kronis pada lansia, seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, dan gangguan muskuloskeletal. Kondisi ini seringkali bersifat multipatologi (*multimorbidity*), sehingga memerlukan penanganan yang

kompleks dan berkelanjutan. Selain itu, penyakit kronis dapat berdampak pada penurunan kemampuan fungsional dan kualitas hidup lansia.

2. Penurunan Kapasitas Fungsional

Seiring bertambahnya usia, lansia mengalami penurunan kapasitas fisik dan kognitif yang dapat menghambat kemandirian dalam aktivitas sehari-hari. Penurunan ini mencakup kelemahan otot, gangguan mobilitas, penurunan fungsi sensorik, serta gangguan memori. Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi ini dapat meningkatkan ketergantungan lansia terhadap orang lain.

3. Masalah Kesehatan Mental dan Sosial

Isu kesehatan mental, seperti depresi, kecemasan, dan kesepian, menjadi tantangan yang signifikan dalam *healthy aging*. Lansia yang mengalami isolasi sosial atau kehilangan peran dalam keluarga dan masyarakat cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih rendah. Selain itu, stigma terhadap gangguan mental seringkali menghambat lansia untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan.

4. Ketimpangan Akses Pelayanan Kesehatan

Akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas masih menjadi permasalahan, terutama di daerah terpencil atau dengan keterbatasan sumber daya. Ketimpangan ini mencakup keterbatasan tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan, serta biaya pelayanan yang tidak terjangkau. Hal ini berdampak pada keterlambatan diagnosis dan penanganan masalah kesehatan pada lansia.

5. Beban Keluarga dalam Perawatan Lansia

Keluarga sebagai caregiver utama seringkali menghadapi beban fisik, emosional, dan finansial dalam merawat lansia. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam perawatan lansia dapat memperburuk kondisi ini. Beban yang tinggi pada caregiver juga berpotensi menimbulkan stres dan menurunkan kualitas perawatan yang diberikan.

6. Perubahan Struktur Keluarga dan Sosial

Perubahan struktur keluarga, seperti meningkatnya keluarga inti dan urbanisasi, menyebabkan berkurangnya dukungan sosial bagi lansia. Lansia yang hidup sendiri atau jauh dari keluarga memiliki risiko lebih tinggi mengalami kesepian dan kurang mendapatkan perawatan yang memadai.

7. Keterbatasan Literasi Kesehatan Lansia

Rendahnya literasi kesehatan pada lansia menjadi hambatan dalam memahami informasi kesehatan, mengikuti anjuran medis, serta mengelola penyakit secara mandiri. Hal ini dapat berdampak pada rendahnya kepatuhan terhadap pengobatan dan perilaku hidup sehat.

8. Tantangan dalam Integrasi Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan untuk lansia seringkali masih terfragmentasi dan belum terintegrasi secara optimal. Kurangnya koordinasi antar layanan kesehatan menyebabkan ketidakefektifan dalam penanganan masalah kesehatan lansia, terutama pada kasus dengan kondisi kompleks.

9. Isu Etik dan Hak Lansia

Dalam praktik pelayanan kesehatan, lansia sering menghadapi isu etik, seperti pengambilan keputusan terkait perawatan, otonomi pasien, serta perlindungan terhadap kekerasan dan pengabaian. Penting untuk memastikan bahwa hak-hak lansia tetap dihormati dan dilindungi dalam setiap aspek pelayanan.

10. Kesiapan Sistem Kesehatan dan Kebijakan

Sistem kesehatan di banyak negara masih belum sepenuhnya siap menghadapi peningkatan jumlah lansia. Hal ini mencakup keterbatasan kebijakan yang mendukung, kurangnya program khusus lansia, serta minimnya alokasi sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mendukung *healthy aging*.

I. Penutup

Penuaan merupakan proses alamiah yang tidak dapat dihindari, namun kualitas proses tersebut sangat dapat dioptimalkan melalui pendekatan *healthy aging*. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga dan meningkatkan kemampuan fungsional lansia agar tetap mandiri, produktif, dan memiliki kualitas hidup yang baik. Sejalan dengan pandangan World Health Organization, *healthy aging* tidak hanya ditentukan oleh kondisi kesehatan fisik, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek psikologis, sosial, dan spiritual yang saling berinteraksi secara dinamis.

Pembahasan dalam bab ini telah menguraikan secara komprehensif mengenai determinan, dimensi, indikator, strategi, serta peran keperawatan dalam mewujudkan *healthy aging*. Keempat dimensi utama—fisik, psikologis, sosial, dan spiritual—menjadi landasan penting dalam memahami kebutuhan lansia secara holistik. Selain itu, berbagai strategi yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa upaya mewujudkan *healthy aging* memerlukan pendekatan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari individu, keluarga, masyarakat, hingga sistem pelayanan kesehatan.

Perawat sebagai tenaga kesehatan memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendukung *healthy aging*. Melalui peran sebagai pemberi asuhan, edukator, advokat, konselor, serta agen perubahan, perawat dapat berkontribusi secara nyata dalam meningkatkan kualitas hidup lansia. Pendekatan keperawatan yang berbasis

bukti (*evidence-based practice*) serta berorientasi pada kebutuhan individu menjadi kunci dalam memberikan pelayanan yang optimal.

Namun demikian, berbagai tantangan dan isu yang telah diidentifikasi menunjukkan bahwa implementasi *healthy aging* masih menghadapi hambatan yang kompleks, baik dari aspek individu maupun sistem. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama serta inovasi berkelanjutan dalam mengembangkan program dan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan lansia.

Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa *healthy aging* bukan sekadar tujuan, melainkan suatu proses yang harus diupayakan secara terus-menerus sepanjang rentang kehidupan. Dengan sinergi antara ilmu pengetahuan, praktik keperawatan, serta dukungan lintas sektor, diharapkan lansia dapat menjalani kehidupan yang sehat, mandiri, bermakna, dan bermartabat.

Referensi

- Abud, T., Kounidas, G., Martin, K. R., Werth, M., Cooper, K., & Kyaw, P. (2022). Determinants of healthy ageing : a systematic review of contemporary literature. *Aging Clinical and Experimental Research*, 34(6), 1215–1223. <https://doi.org/10.1007/s40520-021-02049-w>
- Cocchi, C., Beatrice, M., Levati, E., Calvani, R., & Onder, G. (2025). European Journal of Internal Medicine How to promote healthy aging across the life cycle. *European Journal of Internal Medicine*, 135(January), 5–13. <https://doi.org/10.1016/j.ejim.2025.03.003>
- Hernæs, E., Kornstad, T., Markussen, S., & Røed, K. (2023). *Ageing and labor productivity*. 82(March). <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2023.102347>
- Kim, B. (2023). Individual and environmental factors associated with successful aging among Korean older adults: Multilevel analysis of cross-sectional nationwide survey data. *Archives of Gerontology and Geriatrics*, 113(February), 105062. <https://doi.org/10.1016/j.archger.2023.105062>
- Kim, E. S., Tkatch, R., Martin, D., Macleod, S., Sandy, L., & Yeh, C. (2021). *Resilient Aging : Psychological Well-Being and Social Well-Being as Targets for the Promotion of Healthy Aging*. <https://doi.org/10.1177/23337214211002951>
- Marzo, R. R., Khanal, P., Shrestha, S., Mohan, D., Myint, P. K., & Su, T. T. (2023). Determinants of active aging and quality of life among older adults : systematic review. *Frontiers in Public Health*, 11:1193789(doi: 10.3389/fpubh.2023.1193789).
- Menassa, M., Stronks, K., Khatami, F., Roa, M., Espinola, P., & Gamba, M. (2023). Review Concepts and de fi nitions of healthy ageing : a systematic review and synthesis of theoretical models. *EClinicalMedicine*, 56, 101821. <https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2022.101821>
- Rudnicka, E., Napiera, P., Pod, A., Smolarczyk, R., & Grymowicz, M. (2020). The World Health Organization (WHO) approach to healthy ageing. *Maturitas*, 139(May), 6–11. <https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2020.05.018>
- Tan, X., Li, J., Xu, X., Shen, W., Sun, Y., & Fu, Y. (2026). Social determinants of health , accelerated biological aging , and long-term health outcomes. *Nature Communication*, 17(900), 1–12.
- Urtamo, A., Jyväkorpi, S. K., & Strandberg, T. E. (2019). Definitions of successful ageing : A brief review of a multidimensional concept. *Acta Biomed*, 90(18), 359–363. <https://doi.org/10.23750/abm.v90i2.8376>

Glosarium

A

Aktivitas Fisik adalah Setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran energi dan berperan dalam menjaga kebugaran serta fungsi tubuh lansia.

Aging (Penuaan) adalah Proses alami yang ditandai dengan perubahan biologis, psikologis, dan sosial seiring bertambahnya usia.

Autonomi Lansia: Kemampuan lansia dalam mengambil keputusan secara mandiri terkait kehidupannya.

B

Beban Caregiver adalah Tekanan fisik, emosional, dan sosial yang dialami oleh individu yang merawat lansia.

C

Caregiver adalah Individu yang memberikan perawatan kepada lansia, baik anggota keluarga maupun tenaga profesional.

Chronic Disease (Penyakit Kronis) adalah Penyakit yang berlangsung lama dan memerlukan pengelolaan berkelanjutan, seperti hipertensi dan diabetes.

D

Determinasi Kesehatan adalah Faktor-faktor yang memengaruhi status kesehatan individu, baik internal maupun eksternal.

Dimensi Healthy Aging adalah Aspek utama dalam *healthy aging* yang meliputi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual.

F

Fungsi Kognitif adalah Kemampuan mental yang mencakup berpikir, mengingat, memahami, dan mengambil keputusan.

Fungsi Sosial adalah Kemampuan individu dalam berinteraksi dan menjalankan peran dalam masyarakat.

H

Healthy Aging adalah Proses pengembangan dan pemeliharaan kemampuan fungsional yang memungkinkan kesejahteraan pada usia lanjut.

I

Independensi (Kemandirian) adalah Kemampuan lansia untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bantuan orang lain.

Intervensi Keperawatan adalah Tindakan yang dilakukan perawat untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pasien.

K

Kapasitas Fungsional adalah Kemampuan individu untuk melakukan aktivitas yang penting bagi kehidupan sehari-hari.

Kesehatan Mental adalah Kondisi kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial seseorang.

L

Lansia (Lanjut Usia) adalah Individu yang berusia 60 tahun ke atas.

M

Multimorbiditas adalah Kondisi adanya dua atau lebih penyakit kronis yang dialami secara bersamaan.

P

Promosi Kesehatan adalah Upaya untuk meningkatkan kemampuan individu dalam mengendalikan dan meningkatkan kesehatannya.

S

Self-care adalah Kemampuan individu dalam merawat diri sendiri untuk mempertahankan kesehatan.

Spiritual Well-being adalah Kondisi kesejahteraan yang berkaitan dengan makna hidup, nilai, dan keyakinan individu.

T

Transisi Demografi adalah Perubahan struktur penduduk yang ditandai dengan meningkatnya proporsi lansia dalam populasi.

BAB 3

PERAWATAN PALIATIF DAN *END-OF-LIFE-CARE*

A. Pendahuluan

Perawatan paliatif merupakan perawatan medis yang diberikan terutama untuk mereka yang memiliki penyakit parah ataupun penyakit jangka panjang (menahun) diharapkan dapat meringankan beban yang dirasakan oleh pasien akibat penyakitnya di saat banyak dari pasien tersebut yang masih berupaya mengatasi masalah medisnya (Riyadi et al, 2025). Perawatan paliatif pada End-of-Life Care dimana terapi pengobatan (penyembuhan) tidak lagi menjadi pilihan pengobatan, melainkan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pada mereka yang berada pada kondisi sekarat ataupun menjelang kematiannya, perawatan dan pengobatan diberikan dengan tujuan dapat membantu meringankan gejala yang menyakitkan atau mengganggu (Kabak, 2025).

Penanganan gejala di akhir hayat pada pasien lanjut usia berbeda dengan kelompok usia yang lebih muda karena terdapat perubahan respons terhadap pengobatan, ketakutan untuk minum obat, dan kebutuhan perawatan yang intensif bagi lansia (Langitan et al, 2024). Pasien lanjut usia tahap akhir harus dapat menerima perawatan paliatif yang terampil dan ahli, berarti bahwa tim medis harus memiliki pengetahuan tentang proses penuaan terkait perubahan fisiologis yang normal dan dampak penyakit progresif pada sistem tubuh yang sudah lemah (Manurung, 2020). Lansia dapat mengalami tiga gejala umum saat dalam kondisi kritis yaitu nyeri, gangguan pernapasan, dan delirium, maka untuk dapat meringankan gejala-gejala ini merupakan prioritas dasar dalam perawatan pasien lanjut usia (Palliative Nursing, 2020).

Perawatan paliatif merupakan pendekatan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga dalam menghadapi penyakit yang mengancam jiwa, dengan cara meringankan penderitaan terhadap rasa sakit dan memberikan dukungan fisik, psikososial dan spiritual yang dimulai sejak tegaknya diagnosa hingga akhir kehidupan pasien (Setyowati et al, 2021). Penerapan perawatan paliatif memastikan bahwa setiap keputusan selaras dengan keinginan dan martabat pasien. Dengan demikian, diakhir hayatnya lansia tetap mendapatkan ketenangan, penghargaan, kasih sayang yang dibutuhkan dalam menghadapi Penyakit (Hasrima et al, 2022).

Dalam konteks pelayanan kesehatan modern, keperawatan paliatif tidak lagi dipandang sebagai layanan tambahan, tetapi telah menjadi bagian integral dari sistem kesehatan yang berorientasi pada pendekatan holistik (Jerant et al, 2004). Hal ini sejalan dengan rekomendasi International Association for Hospice and Palliative Care (IAHPC) yang menyatakan bahwa seluruh tenaga kesehatan harus mampu menghadirkan pelayanan paliatif dalam berbagai setting mulai dari rumah sakit, komunitas, hingga layanan berbasis rumah (ANA, 2020). Dengan demikian, kehadiran perawatan paliatif mampu mencegah penderitaan yang tidak perlu, mengurangi hospitalisasi berulang, serta menciptakan proses akhir kehidupan yang lebih bermakna bagi pasien dan keluarganya (Fahmi et al, 2025).

Integrasi perawatan paliatif sejak awal gejala dapat membantu pasien dan keluarga dalam merencanakan, mengambil keputusan dan melanjutkan terapi /pengobatan dari anggota keluarga yang sakit berat, dimana diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup pasien dan mengoptimalkan sumber daya kesehatan secara wajar. Hal ini sesuai dengan laporan Global Atlas of Palliative Care (2020) yang menyebutkan bahwa kebutuhan layanan paliatif meningkat lebih dari 25% dalam satu dekade terakhir, terutama karena prevalensi penyakit kronis yang terus bertambah. Kondisi ini menuntut tenaga kesehatan, terutama perawat, untuk memahami konsep paliatif secara lebih mendalam sehingga dapat memberikan intervensi yang sesuai dengan kompleksitas penyakit modern (Taher et al, 2023).

B. Perawatan Paliatif

Keperawatan paliatif merupakan pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga dengan cara mengurangi gejala yang dialami pasien sejak didiagnosa penyakit kronis maupun terminal sampai fase berduka. Kata paliatif mulanya berasal dari bahasa latin kuno yaitu *pallium* yang artinya jubah. Oleh karena itu paliatif diartikan memiliki fungsi yang sama dengan jubah yaitu melindungi, memberikan kenyamanan, menyembunyikan atau mengurangi keburukan bagi yang mengenakannya (WHO, 2022). Perawatan paliatif juga merupakan suatu pendekatan dalam perawatan pasien yang terintegrasi dengan terapi pengobatan untuk mengoptimalkan kualitas hidup pasien dengan penyakit kronis atau mengancam jiwa.

Prinsip pelayanan perawatan paliatif yaitu menghilangkan nyeri dan mencegah gejala serta keluhan fisik lainnya, penanganan nyeri, menghargai kehidupan dan menganggap kematian sebagai proses normal, tidak bertujuan mempercepat atau menghambat kematian, memberikan dukungan psikologis, sosial dan spiritual, agar pasien dapat hidup seaktif mungkin, juga memberikan dukungan kepada keluarga

sampai masa duka cita, serta menggunakan pendekatan tim untuk mengatasi kebutuhan pasien dan keluarganya.

Perawatan paliatif juga menempatkan keluarga sebagai bagian sentral dalam proses asuhan, karena keluarga memiliki peran besar dalam pengambilan keputusan dan pendampingan pasien pada tahap kehidupan yang paling rentan. Keterlibatan keluarga dapat meningkatkan keberhasilan rencana perawatan, namun di sisi lain keluarga pun dapat mengalami beban psikologis yang cukup berat. Penelitian O'Connor & Weir (2021) menunjukkan bahwa dukungan keluarga dalam perawatan paliatif membutuhkan edukasi dan pendampingan berkelanjutan, karena sebagian besar keluarga mengalami kebingungan mengenai informasi penyakit, perubahan perilaku pasien, dan perawatan sehari-hari. Oleh sebab itu, perawat dituntut untuk memberikan edukasi komprehensif, bimbingan teknis, serta dukungan emosional bagi keluarga agar mampu beradaptasi dan menjalankan perannya secara optimal. Tujuan dan prinsip dasar keperawatan paliatif, antara lain;

1. Meningkatkan Kualitas Hidup Pasien .

Meningkatkan kualitas hidup pasien dengan penyakit yang membatasi kehidupan melalui pendekatan holistik yang meliputi aspek fisik, emosional, sosial, dan spiritual. Kualitas hidup tidak hanya dilihat dari ketiadaan gejala penyakit, tetapi juga kemampuan pasien untuk merasakan kenyamanan, martabat, dan makna dalam hidupnya. Dalam konteks ini, perawat paliatif bertugas menilai seluruh dimensi tersebut untuk memastikan bahwa kebutuhan pasien terpenuhi secara menyeluruh. Kualitas hidup dalam palliatif sangat dipengaruhi oleh tingkat kontrol gejala, hubungan interpersonal, serta dukungan spiritual yang diterima pasien. Oleh karena itu, intervensi perawat harus mempertimbangkan preferensi, nilai, dan tujuan hidup pasien sebagai bagian dari proses Perawatan.

2. Holistik Mengurangi dan Mengendalikan Gejala.

Pengendalian gejala merupakan tujuan fundamental dalam pelayanan paliatif, terutama gejala seperti nyeri, sesak napas, mual, insomnia, dan kecemasan yang sering dialami pasien penyakit kronis stadium lanjut. Pengendalian gejala tidak hanya bertujuan untuk mengurangi penderitaan fisik, tetapi juga membantu pasien mempertahankan fungsi kehidupan sehari-hari. Perawat paliatif menggunakan berbagai pendekatan, mulai dari farmakologis hingga terapi komplementer yang terbukti efektif meningkatkan kenyamanan pasien. Selain pendekatan medis, pengendalian gejala membutuhkan komunikasi efektif antara pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan untuk memperoleh data akurat mengenai intensitas gejala, efek samping obat, dan respons terhadap terapi (Hearn & Higginson, 2021).

3. Pendekatan Holistik dalam Upaya Preventif.

Membantu pasien mempertahankan kemandirian dalam aktivitas harian, seperti makan, mandi, dan mobilitas, meskipun berada dalam kondisi penyakit kronis. Keberfungsian fisik merupakan salah satu indikator kualitas hidup yang paling berdampak, sehingga intervensi paliatif perlu mengintegrasikan dukungan rehabilitative, karena banyak pasien mengalami penurunan kemampuan fisik yang signifikan seiring perkembangan penyakit (Kaasa & Loge, 2021). Dukungan aktivitas harian tidak hanya bertujuan mempertahankan kemampuan fisik pasien, namun juga memelihara harga diri, otonomi, dan kepuasan hidup. Penelitian oleh Hudson et al. (2020) menunjukkan bahwa pasien yang tetap memiliki kendali atas aktivitas sehari-hari melaporkan tingkat kecemasan dan depresi yang lebih rendah dibandingkan pasien yang sepenuhnya bergantung pada orang lain. Karena itu, program keperawatan paliatif harus menilai kemampuan fungsional secara rutin dan menyesuaikan intervensi sesuai perkembangannya

4. Holistik.

Pemberian dukungan emosional merupakan tujuan esensial dalam keperawatan paliatif karena pasien penyakit kronis sering mengalami kecemasan, depresi, ketakutan akan kematian, dan tekanan psikologis lainnya. Kehadiran perawat sebagai pendamping emosional membantu menumbuhkan rasa aman dan mengurangi beban psikologis selama proses Penyakit, karena dukungan tersebut turut menentukan kesiapan pasien dalam menjalani perawatan dan menghadapi akhir kehidupan (Puchalski et al., 2020). Selain dukungan emosional, aspek spiritual juga penting dalam perawatan paliatif, terutama bagi pasien yang mulai memaknai kembali hubungan mereka dengan kehidupan, kebermaknaan, dan transendensi. Sebagaimana dijelaskan oleh Ferrell & Paice (2020), kebutuhan spiritual dapat berupa doa, ritual keagamaan, rekonsiliasi, atau sekadar kehadiran seseorang yang dapat mendengarkan.

5. Memberdayakan Keluarga Dalam Perawatan

Strategi ini berfokus pada perubahan perilaku hidup sehat, seperti peningkatan aktivitas fisik, pola makan seimbang, berhenti merokok, dan manajemen stres. Kombinasi antara edukasi perilaku, dukungan psikologis, dan pemantauan digital mampu menurunkan risiko penyakit tidak menular secara signifikan (Zheng et al. 2023). Keperawatan paliatif tidak hanya berfokus pada pasien, tetapi juga pada keluarga sebagai sistem pendukung utama, tujuannya adalah memberdayakan keluarga agar mampu memberikan perawatan di rumah, memahami perubahan klinis pasien, dan membuat keputusan yang tepat. Keluarga yang dilibatkan dalam proses perawatan menunjukkan tingkat kesiapan lebih baik dalam menghadapi perubahan kondisi pasien dan transisi menuju

perawatan akhir kehidupan (Hudson & Payne, 2020). Tujuan keperawatan paliatif juga mencakup pemberian edukasi, konseling, dan dukungan sosial kepada keluarga karena keluarga sering mengalami beban fisik, emosional, dan ekonomi akibat perawatan jangka panjang. Penelitian oleh Kent et al. (2021) menunjukkan bahwa intervensi edukasi yang berkelanjutan dapat mengurangi stres keluarga dan meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan perawatan berbasis kebutuhan pasien.

Komponen inti dari perawatan paliatif meliputi penilaian dan pengobatan gejala fisik dan psikologis, identifikasi dan dukungan untuk tekanan spiritual, komunikasi ahli untuk menetapkan tujuan perawatan dan membantu pengambilan keputusan medis yang kompleks, dan koordinasi perawatan (Taher et al, 2023):

1. Gejala Fisik dan Psikologis. Penilaian gejala komprehensif rutin dengan penggunaan instrumen yang tervalidasi diindikasikan dalam konteks penyakit lanjut. Dibandingkan dengan perawatan rutin, yang mencakup riwayat klinis standar dan tinjauan sistem, penilaian gejala formal dengan penggunaan instrumen yang tervalidasi dapat meningkatkan identifikasi gejala yang mengganggu dan menghasilkan kenyamanan serta hasil yang lebih baik.
2. Spiritual. Pasien yang memiliki masalah spiritual yang tidak terpenuhi lebih mungkin memiliki kualitas hidup psikologis yang jauh lebih buruk daripada mereka yang masalah spiritualnya ditangani. Pasien yang kebutuhan spiritualnya didukung, menerima lebih banyak perawatan rumah sakit, cenderung tidak mengalami intervensi yang memberatkan dan tidak bermanfaat menjelang akhir hayat daripada mereka yang kebutuhannya tidak terpenuhi dan, lebih jauh lagi, bahwa dukungan spiritual dari tim medis atau tokoh agama dikaitkan dengan skor kualitas hidup yang lebih tinggi.
3. Komunikasi. Berdasarkan pendekatan berbasis konsensus untuk melakukan percakapan yang sulit (misalnya, "menyampaikan berita buruk, komunikasi umum mungkin melibatkan penyampaian berita serius, membahas ketidakpastian prognostik, menetapkan tujuan perawatan, dan memilih opsi perawatan. Berbagai upaya telah mengasah peta jalan kognitif untuk skenario klinis spesifik ini seperti singkatan SPIKES (setting up the interview, assessing the patient's perception, obtaining the patient's invitation, giving knowledge and information, responding to emotion, and summarizing the discussion), dan telah mengidentifikasi keterampilan inti untuk komunikasi yang efektif, seperti mengekspresikan empati.

Model perawatan paliatif;

1. Rumah Sakit. Di dalam rumah sakit, model utama pemberian perawatan adalah tim konsultasi interdisipliner. Rumah sakit besar dan program yang mencakup unit rawat inap khusus, model pemberian layanan dan inovasi baru mencakup tim ICU khusus, model manajemen bersama, di mana spesialis perawatan paliatif bergabung dengan tim spesialis yang ada (misalnya, onkologi), serta pemicu untuk rujukan perawatan paliatif otomatis. Beberapa uji coba terkontrol acak dan beberapa studi observasional yang membandingkan hasil pada pasien sakit parah yang dirujuk ke tim perawatan paliatif berbasis rumah sakit dengan hasil pada pasien yang menerima perawatan biasa telah menunjukkan berkurangnya tekanan gejala peningkatan kualitas hidup dan berkurangnya tekanan spiritual di antara pasien yang dirujuk ke perawatan paliatif.
2. Komunitas. Model perawatan paliatif berbasis komunitas telah dikembangkan untuk melayani orang-orang yang sakit parah yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perawatan paliatif. Program-program ini menggunakan tim perawatan paliatif interdisipliner untuk menetapkan tujuan perawatan yang jelas, meningkatkan manajemen gejala dan dukungan pengasuh di lingkungan rumah, mengoordinasikan perawatan, dan memberikan lapisan dukungan ekstra kepada dokter yang merawat.
3. Perawatan Jangka Panjang. Banyak panti jompo yang membuat kontrak dengan lembaga hospice untuk layanan, dan persentase orang di panti jompo yang menerima layanan hospice sebelum mereka meninggal semakin meningkat. Penggunaan hospice di panti jompo dikaitkan dengan tingkat terapi invasif dan rawat inap yang lebih rendah, peningkatan pengelolaan nyeri dan gejala, dan kepuasan keluarga yang lebih tinggi terhadap perawatan.

Tim perawatan paliatif bertujuan untuk menggunakan pendekatan holistik yang menangani semua kebutuhan, bukan hanya kondisi medis spesifik. Tim biasanya bekerja sama dengan berbagai profesional untuk mencapai yang terbaik bagi setiap pasien tertentu karena kebutuhannya bervariasi, kompleks, dan bersifat fisik dan psikososial. Di negara-negara dengan sumber daya yang baik, tim tersebut dapat mencakup konsultan, spesialis perawat klinis, pekerja sosial, konselor, pemuka agama, dan berbagai terapis dari Terapis Okupasi (OT), fisioterapis, seni, serta musik. Perawatan paliatif yang diberikan dapat mencakup perawatan medis spesialis untuk mengelola gejala fisik, menawarkan dukungan psikologis atau spiritual serta dukungan dan saran praktis (Jerant et al, 2024).

Berikut ini merupakan beberapa contoh fokus perawatan paliatif yang seringkali dilakukan oleh tim perawatan paliatif dalam meningkatkan kualitas hidup pasien pada kondisi terminal;

1. Bantu kendalikan gejala fisik, seperti nyeri, sesak napas, mual, dan kelelahan menggunakan metode farmakologis dan nonfarmakologis.
2. Membantu seseorang mengatasi tekanan emosional, kecemasan, panik, depresi, dan keputusasaan; serta tekanan spiritual yang terkait dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Membantu seseorang merencanakan masa depan, misalnya, menyesuaikan diri dengan perubahan hidup atau mendiskusikan bagaimana dan di mana perawatan dapat diberikan.
4. Membantu seseorang membuat keputusan terkait keinginan dan preferensi di akhir hayat, preferensi perawatan, serta keputusan lanjutan tentang bagaimana dan di mana seseorang ingin meninggal dan apa yang penting bagi mereka.
5. Memberikan saran tentang kebutuhan perawatan dan peralatan, atau dukungan kesejahteraan.
6. Mendukung keluarga dan teman Anda untuk mengatasi dan mendukung mereka dalam masa duka.
7. Memberikan pendidikan, dukungan, saran, dan sering kali konsultasi kepada profesional perawatan kesehatan terkait hal-hal di atas.

C. Ruang Lingkup Keperawatan Paliatif

1. Dukungan Psikologis dan Emosional.

Dukungan psikologis merupakan aspek penting dalam ruang lingkup keperawatan paliatif karena pasien dengan penyakit terminal sering mengalami kecemasan, depresi, ketakutan, dan rasa tidak berdaya. Kondisi emosional pasien sangat berpengaruh terhadap persepsi gejala fisik dan kualitas hidup keseluruhan. Perawat harus mampu melakukan penilaian kondisi mental pasien secara berkala dan memberikan intervensi seperti komunikasi terapeutik, konseling pendek, serta teknik relaksasi untuk membantu pasien mengelola emosinya.

Pendampingan spiritual juga merupakan bagian dari dukungan psikologis yang tidak dapat dipisahkan dalam keperawatan paliatif. Spiritualitas berkaitan dengan makna hidup, harapan, dan penerimaan, yang sering kali menjadi sumber kekuatan bagi pasien dalam menghadapi penyakit terminal. Menurut Puchalski et al. (2020), integrasi spiritual care dalam pelayanan paliatif terbukti meningkatkan kesejahteraan emosional dan memperbaiki kualitas hidup pasien. Perawat perlu

mampu mengidentifikasi kebutuhan spiritual pasien dan memberikan dukungan sesuai keyakinan atau nilai yang dianut pasien

Selain itu, kehadiran perawat dalam memberikan kenyamanan emosional sangat penting ketika pasien mengalami krisis psikologis. Kehadiran yang penuh empati dan pemberian waktu untuk mendengarkan keluhan pasien dapat menurunkan intensitas distress secara signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa hubungan terapeutik antara perawat dan pasien dapat membangun rasa aman dan percaya, sehingga pasien lebih mudah mengungkapkan emosinya. Oleh karena itu, perawat harus memiliki kemampuan komunikasi interpersonal yang baik untuk memberikan dukungan emosional yang efektif (Cherny et al., 2020).

2. Dukungan Keluarga dan Caregiver.

Keperawatan paliatif, dukungan terhadap keluarga memiliki peran yang sangat besar karena keluarga merupakan unit utama dalam pengambilan keputusan dan perawatan pasien di rumah. Menurut O'Connor & Weir (2021), keluarga sering mengalami beban emosional dan fisik akibat perubahan kondisi pasien yang cepat dan tidak terduga. Oleh karena itu, perawat perlu memberikan edukasi dan pendampingan intensif kepada keluarga agar mereka dapat memahami perkembangan penyakit, cara merawat, serta strategi menghadapi perubahan emosional pasien

Keluarga juga membutuhkan dukungan psikososial karena mereka dapat mengalami stres, kecemasan, hingga kelelahan akibat proses caregiving yang berkepanjangan. Penelitian dari *Global Atlas of Palliative Care* (2020) menunjukkan bahwa caregiver fatigue adalah kondisi umum yang dialami keluarga pasien dengan penyakit kronis atau terminal. Perawat dapat membantu keluarga mengidentifikasi tanda-tanda kelelahan dan memberikan arahan mengenai strategi koping adaptif serta akses ke layanan dukungan formal seperti konseling atau kelompok dukungan.

Selain dukungan emosional, perawat juga perlu memberikan pelatihan teknis terkait perawatan di rumah, seperti manajemen luka, pemberian obat, teknik mobilisasi, dan perawatan kebersihan. Ferrell & Paice (2019) menekankan bahwa edukasi teknis membantu keluarga merasa lebih percaya diri sehingga dapat mendukung proses perawatan pasien secara efektif. Dengan demikian, keluarga tidak hanya menjadi pendamping, tetapi juga mitra aktif dalam penyelenggaraan pelayanan paliatif.

3. Etika, Legalitas, dan Keselamatan Pasien

Keperawatan paliatif juga mencakup aspek etika dan legalitas dalam praktik klinis. Isu seperti persetujuan tindakan, kerahasiaan informasi, penolakan terapi, dan penghentian ventilator mekanik sering menjadi dilema bagi tenaga

kesehatan. Menurut American Nurses Association (2020), perawat harus memegang prinsip etika seperti otonomi, beneficence, non-maleficence, dan justice dalam memberikan asuhan. Dalam konteks paliatif, perawat sering dihadapkan pada keputusan sulit sehingga pemahaman etika menjadi sangat penting. Keselamatan pasien juga merupakan bagian penting dari ruang lingkup keperawatan paliatif karena pasien dengan penyakit kronis memiliki risiko tinggi terhadap cedera, infeksi, atau komplikasi lain. Perawat harus memastikan prosedur yang dilakukan aman, higienis, dan sesuai standar.

Menurut WHO (2022), penguatan budaya keselamatan pasien dapat mengurangi risiko kesalahan medis secara signifikan. Oleh karena itu, perawat harus terus meningkatkan kompetensinya terkait praktik keselamatan. Selain keselamatan fisik, keselamatan psikologis pasien dan keluarga juga menjadi perhatian. Cherny et al. (2020) menyatakan bahwa komunikasi buruk dapat menyebabkan distress emosional yang cukup besar. Oleh karena itu, perawat perlu memastikan bahwa interaksi dengan pasien dilakukan secara sensitif, menghargai martabat, dan tidak menimbulkan kecemasan tambahan.

Salah satu ruang lingkup penting lainnya dalam keperawatan paliatif adalah dukungan sosial yang diberikan kepada pasien dan keluarga. Dukungan sosial meliputi bantuan untuk mengakses sumber daya seperti layanan kesehatan rumah, bantuan keuangan, komunitas dukungan spiritual, dan fasilitas bantuan sosial. Dukungan sosial berperan besar dalam mengurangi isolasi sosial dan meningkatkan kemampuan pasien menjalani perawatan dengan lebih bermakna. Perawat sebagai penghubung antara pasien dan layanan sosial memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya tersedia dan dapat diakses sesuai kebutuhan pasien (Payne et al, 2020),

Selain dukungan sosial, rehabilitasi paliatif juga menjadi bagian penting dalam ruang lingkup layanan, terutama pada pasien dengan keterbatasan mobilitas atau gangguan fungsional akibat penyakit kronis seperti kanker, gagal jantung, atau penyakit neurodegeneratif. Rehabilitasi paliatif bertujuan mempertahankan fungsi tubuh, meningkatkan kemandirian, serta mendukung aktivitas sehari-hari. Menurut Kaasa & Loge (2021), pendekatan rehabilitatif dalam konteks paliatif terbukti mampu meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi beban fisik pasien. Kolaborasi dengan fisioterapis, okupasi terapis, dan tenaga profesional lainnya sangat penting untuk keberhasilan perawatan ini.

Ruang lingkup lainnya adalah dukungan spiritual transkultural, yang menekankan perlunya memahami keberagaman nilai, budaya, serta kepercayaan pasien. Palliative care tidak bisa dilepaskan dari konteks budaya, karena persepsi tentang sakit, kematian, dan perawatan akhir kehidupan sangat dipengaruhi oleh

nilai budaya masing-masing individu. Menurut Puchalski & Ferrell (2020), perawatan paliatif harus sensitif budaya, menghargai ritual, dan keyakinan spiritual pasien agar menciptakan rasa aman, dihargai, dan didukung secara utuh. Oleh karena itu, perawat harus memiliki kompetensi budaya sebagai bagian dari praktik profesional.

Ruang lingkup lainnya adalah pendidikan pasien dan keluarga, yang berfungsi untuk memberikan pemahaman mengenai perkembangan penyakit, pilihan terapi, manajemen gejala, serta persiapan akhir kehidupan. Edukasi ini menjadi dasar dalam mendorong keterlibatan aktif keluarga dan pasien dalam proses pengambilan keputusan. Edukasi yang diberikan secara berkelanjutan mampu meningkatkan kemampuan keluarga dalam menghadapi perubahan kondisi pasien serta mengurangi kecemasan dan trauma emosional yang berkepanjangan. Oleh sebab itu, perawat harus mampu menyampaikan informasi secara jelas, empatik, dan sesuai literasi kesehatan pasien.

Kontinuitas perawatan (*continuity of care*) yang memastikan pasien menerima layanan secara konsisten dan terpadu sejak diagnosis hingga tahap akhir kehidupan. Kontinuitas ini mencakup transfer informasi yang tepat dari satu fasilitas ke fasilitas lain, serta koordinasi dalam perawatan rumah, pelayanan kesehatan primer dan fasilitas rawat inap. Ketidakselarasan dalam kontinuitas perawatan dapat meningkatkan risiko komplikasi, rawat inap ulang, dan ketidakpuasan pasien maupun keluarga. Perawat berperan penting dalam menjaga kesinambungan informasi dan memantau perubahan kondisi pasien secara holistik (Fahmi et al, 2025).

Ruang lingkup keperawatan paliatif juga mencakup dukungan duka cita (*bereavement support*) kepada keluarga setelah pasien meninggal. Kehilangan orang terdekat dapat menyebabkan trauma emosional, depresi, dan gangguan adaptasi, terutama pada keluarga yang merawat pasien dalam jangka panjang. Dukungan duka cita membantu keluarga melewati fase kehilangan dengan lebih sehat secara emosional. Intervensi ini dapat berupa konseling, kunjungan tindak lanjut, hingga rujukan ke layanan psikolog apabila diperlukan. Perawat memiliki peran sebagai figur yang dipercaya oleh keluarga karena keterlibatan mereka selama proses perawatan.

D. Peran Perawat dalam Keperawatan Paliatif Sebagai Care Provider

Keperawatan paliatif memegang peran fundamental karena mereka merupakan tenaga kesehatan yang paling sering berada di sisi pasien. Dalam konteks penyakit kronis dan terminal, kebutuhan pasien tidak hanya bersifat fisik tetapi juga emosional, sosial, dan spiritual. Perawat memiliki posisi strategis dalam memastikan asuhan yang komprehensif karena berada pada garis depan pelayanan dan mampu mengobservasi perubahan kondisi pasien secara berkelanjutan. Peran ini mengharuskan perawat untuk mampu memberikan intervensi yang berorientasi pada kualitas hidup, bukan hanya perawatan penyakit dan kehadiran perawat menjadi elemen sentral dalam keberhasilan layanan paliatif (Ferrell & Paice, 2019).

Dalam menjalankan perannya sebagai pemberi asuhan, perawat bertanggung jawab melakukan pengkajian holistik yang meliputi kondisi fisik, fungsi tubuh, status emosional, persepsi spiritual, serta kebutuhan sosial pasien dan keluarga. Pengkajian ini penting karena kebutuhan pasien paliatif sangat kompleks dan dapat berubah dalam waktu singkat. Pengkajian yang komprehensif memungkinkan perawat menetapkan prioritas intervensi yang relevan dengan kondisi pasien saat itu (Kaasa & Loge, 2021).

Pengendalian nyeri merupakan bagian besar dari peran perawat sebagai *care provider*. Nyeri kronis dan gejala lain seperti sesak napas, mual, dan kelelahan sering dialami pasien yang berada pada tahap akhir penyakit. Perawat berperan dalam menilai intensitas nyeri, pola nyeri, faktor pencetus, serta strategi penanganan yang efektif. Pengelolaan nyeri adalah pilar utama dalam perawatan paliatif dan harus dilaksanakan melalui pendekatan multidisiplin yang melibatkan perawat dalam setiap tahap pengambilan keputusan. Perawat juga memonitor efektivitas analgesik serta efek sampingnya, sehingga terapi dapat dioptimalkan secara individual.

Selain nyeri, kontrol gejala (*symptom management*) menjadi komponen penting yang dilakukan perawat. Gejala seperti anoreksia, delirium, depresi, edema, atau gangguan tidur dapat mengganggu kenyamanan pasien dan menurunkan kemampuan mereka berinteraksi dengan keluarga. Perawat harus mampu memahami mekanisme munculnya gejala dan merancang intervensi nonfarmakologis maupun farmakologis yang sesuai. Upaya ini tidak hanya membantu pasien mencapai kenyamanan, tetapi juga meningkatkan rasa kontrol mereka terhadap kondisi penyakit.

Peran perawat dalam memberikan asuhan paliatif mencakup pula dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar pasien seperti nutrisi, hidrasi, kebersihan diri, dan mobilisasi. Meskipun kebutuhan ini tampak sederhana, kebutuhan dasar memiliki dampak besar pada martabat dan harga diri pasien. Menjaga pemenuhan

kebutuhan dasar merupakan bentuk intervensi paling manusiawi dan dapat memperkuat hubungan kepercayaan antara pasien dan tenaga kesehatan. Perawat memastikan bahwa pasien tetap merasa dihargai meskipun berada dalam kondisi lemah atau tidak berdaya.

Dalam konteks kondisi kritis dan menjelang akhir kehidupan, perawat memberikan intervensi khusus berbasis kenyamanan seperti comfort measures, reposisi, manajemen sekresi, serta menjaga kebersihan kulit untuk mencegah luka tekan. Intervensi ini penting karena pada fase terminal pasien sering mengalami penurunan kemampuan motorik dan kesadaran. Tindakan paliatif yang berfokus pada kenyamanan dapat mengurangi penderitaan fisik sekaligus memberi ketenangan bagi pasien dan keluarga. Perawat juga bertugas menciptakan suasana lingkungan yang tenang dan mendukung proses alami akhir kehidupan.

Perawat sebagai care provider juga memiliki tanggung jawab memberikan dukungan emosional, khususnya ketika pasien mengalami kecemasan, ketakutan, atau keputusasaan. Banyak pasien terminal merasakan kehilangan kontrol terhadap hidupnya, sehingga kehadiran perawat yang empatik menjadi bentuk pengobatan psikologis. Perawat harus mampu menggunakan komunikasi terapeutik untuk membantu pasien mengekspresikan perasaannya sehingga tekanan emosional dapat berkurang.

Dalam memberikan asuhan langsung, perawat perlu memahami nilai-nilai budaya, kepercayaan, serta preferensi pasien dan keluarga. Perawatan paliatif tidak dapat dipisahkan dari aspek spiritual dan budaya karena hal tersebut memengaruhi cara pasien memandang sakit, penderitaan, dan kematian. Perawat harus mampu mengintegrasikan aspek budaya dalam intervensi agar pasien merasa dihormati sebagai individu, mengkaji sensitivitas budaya dapat membantu meminimalkan konflik perawatan dan meningkatkan kualitas hubungan terapeutik. Perawat juga bertugas mengedukasi keluarga mengenai cara merawat pasien di rumah, terutama bagi pasien yang memilih perawatan berbasis komunitas, yaitu mencakup teknik repositioning, manajemen obat, pengawasan gejala, serta tanda-tanda klinis yang harus diwaspadai.

Sebagai pemberi asuhan, perawat memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menjaga martabat pasien selama proses perawatan. Pada situasi menjelang kematian, pasien sangat rentan secara fisik maupun emosional. Perawat harus menjunjung tinggi nilai etika seperti *beneficence*, *non-maleficence*, *autonomy*, dan *justice* dalam setiap tindakan. Dengan memberikan perawatan yang penuh empati, perawat memastikan bahwa pasien tetap memiliki martabat hingga akhir kehidupannya. Peran ini menjadikan perawat sebagai pilar utama dalam memberikan pengalaman akhir kehidupan yang bermartabat.

E. Perawatan Paliatif Pada Lansia

Pada pasien lansia, perawatan paliatif dalam meningkatkan kualitas hidup dengan penyakit kronis, degeneratif, atau kondisi terminal melalui upaya pencegahan dan pengurangan gejala fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual. Perawatan paliatif dapat dimulai segera setelah diagnosis penyakit serius, seperti kanker stadium lanjut, gagal jantung, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), demensia, atau penyakit ginjal kronis.

Perawatan paliatif dapat diberikan bersamaan dengan perawatan kuratif (pengobatan untuk menyembuhkan penyakit) dengan melibatkan tim multidisiplin seperti dokter (spesialis paliatif, dokter penyakit dalam, dan lain-lain), perawat, pekerja sosial medis, rohaniwan atau konselor spiritual, ahli gizi, terapis fisik atau okupasi dan psikolog. Perawatan paliatif dapat diberikan di berbagai tempat, termasuk rumah sakit, panti jompo atau fasilitas perawatan jangka panjang dan di rumah pasien sendiri (perawatan paliatif rawat rumah).

Tujuan perawatan paliatif pada lansia sebagai berikut;

1. Mempertahankan kualitas hidup pasien
2. Mengurangi gejala fisik seperti nyeri, sesak napas, mual, kelelahan, atau gangguan tidur.
3. Membantu pasien dan keluarga dalam pengambilan keputusan akhir kehidupan
4. Menyediakan dukungan emosional dan spiritual sesuai nilai dan keyakinan pasien, keluarga atau caregiver menghadapi kondisi pasien dan proses berduka.
5. Memfasilitasi komunikasi dan keputusan etis terkait perawatan akhir hayat.

Komponen perawatan paliatif pada lansia secara umum terdapat empat komponen utama, yaitu;

1. Aspek Fisik.
 - a. Kontrol gejala nyeri (analgesik, terapi nonfarmakologis).
 - b. Mengatasi keluhan sesak napas, mual, anoreksia, insomnia, konstipasi, dan delirium.
 - c. Pemantauan perubahan kondisi lansia secara berkala.
 - d. Mencegah komplikasi (dekubitus, infeksi, malnutrisi).
2. Aspek Psikologis.
 - a. Mengelola gejala psikologis seperti kecemasan, depresi, kebingungan, rasa takut.
 - b. Dukungan untuk menghadapi keterbatasan dan kehilangan fungsi.
 - c. Konseling dan terapi sesuai kebutuhan.

3. Aspek Sosial.
 - a. Evaluasi dukungan keluarga dan caregiver.
 - b. Pengaturan lingkungan yang aman dan nyaman.
 - c. Membantu perencanaan keuangan dan perawatan jangka panjang.
 - d. Memfasilitasi komunikasi antara lansia dan keluarga.
4. Aspek Spiritual.
 - a. Memberikan kesempatan kepada pasien lansia mengekspresikan keyakinan, harapan, atau kekhawatiran.
 - b. Dukungan dari pembimbing rohani.
 - c. Menghormati nilai dan ritual keagamaan.
5. Perencanaan Perawatan Paliatif Pada Lansia

Layanan perawatan paliatif di Indonesia dapat diakses melalui berbagai fasilitas kesehatan seperti rumah sakit besar, klinik spesialis, dan layanan home care.

Langkah-langkah perencanaan perawatan paliatif pada lansia terdiri dari:

 - a. Menilai tingkat keparahan penyakit yang didokumentasikan oleh studi pencitraan dan data laboratorium.
 - b. Menilai gejala, termasuk prevalensi, keparahan, dan dampaknya pada fungsi.
 - c. Mengidentifikasi strategi koping dan gejala psikologis, termasuk adanya kecemasan, depresi, dan kecenderungan bunuh diri.
 - d. Mengevaluasi keyakinan agama dan spiritual.
 - e. Menilai kualitas hidup dan kesejahteraan secara keseluruhan. Apakah pasien merasa yakin bahwa semua yang dapat dilakukan untuk mereka telah dilakukan? Apakah pasien puas dengan tingkat pengendalian gejala saat ini?
 - f. Menentukan beban keluarga. Apakah perhatian diberikan kepada pengasuh agar tidak terjadi kelelahan? Jika pasangan atau pengasuh lansia, apakah ia mampu memenuhi tuntutan fisik dalam merawat pasien
 - g. Menentukan tingkat perawatan yang dibutuhkan di rumah jika pasien sekarat.
 - h. Menilai beban keuangan pasien dan pengasuh. Apakah terdapat pengeluaran yang tidak wajar untuk pasien dan apakah akan tersedianya ketentuan yang memadai bagi pengasuh lansia ketika pasien meninggal?
 - i. Mengidentifikasi adanya permintaan ACP. Apakah keinginan dan preferensi pasien untuk resusitasi, pemberian makanan buatan, dan hidrasi telah didiskusikan? Apakah pasien telah mengidentifikasi pengambil keputusan pengganti yang mengetahui keinginan mereka? Apakah terdapat dokumentasi mengenai arahan lanjutan?
 - j. Mengidentifikasi tujuan perawatan pasien, keluarga, dan tim layanan kesehatan

Manajemen gejala menjadi bagian integral dari keseluruhan rangkaian terapi, fokus intensif pada paliatif bagi penghuni panti jompo lansia biasanya merupakan indikasi bahwa akhir hayat semakin dekat (Riyadi et al, 2025). Keputusan ini seringkali dibuat oleh pasien lansia atau lebih sering oleh keluarga pasien dan tim perawatan. Isu-isu yang dihadapi staf meliputi pertanyaan seputar kapasitas pengambilan keputusan pasien, cara terbaik untuk memajukan kepentingan pasien, dan perbedaan dalam tujuan dan rencana perawatan. Ketika konflik klinis ini terjadi, konsultasi bioetika dapat sangat membantu mengklarifikasi masalah dan menentukan tujuan perawatan.

Beberapa sumber hambatan yang dapat muncul selama memberikan perawatan paliatif pada lansia di panti jompo, yaitu (Sinulingga, 2021):

1. Keadaan institusi.
 - a. Keterlibatan dokter yang terbatas dalam perawatan, penilaian mingguan atau bulanan
 - b. Tidak ditemukan apotek di tempat
 - c. Keterlibatan perawat yang terbatas dalam perawatan; rasio staf perawat-pasien tidak memadai
 - d. Perawatan primer dikelola oleh staf perawat nonprofesional
 - e. Layanan radiologi dan diagnostik terbatas,
 - f. Masalah terkait mahal nya biaya pengobatan
2. Kondisi pasien.
 - a. Perubahan fisiologis penuaan, yang memengaruhi distribusi, metabolisme, dan eliminasi obat
 - b. Beberapa penyakit kronis
 - c. Polifarmasi
 - d. Gangguan status kognitif dan demensia tipe Alzheimer, yang menghambat penilaian
 - e. Nyeri yang tidak dilaporkan karena takut kecanduan
 - f. Kurangnya pengetahuan, takut dipindahkan
 - g. Hilangnya sensorik yang menghambat penilaian
 - h. Peningkatan insiden depresi, yang dapat menutupi pelaporan dan penilaian nyeri.
3. Kondisi Staf.
 - a. Kurangnya pengetahuan tentang manajemen gejala di akhir hayat
 - b. Kurangnya pengetahuan dalam penilaian dan manajemen nyeri kanker kronis
 - c. Kurangnya pengetahuan dalam penggunaan obat opioid, titrasi, dan manajemen efek samping
 - d. Ketakutan menggunakan opioid pada lansia

- e. Kurangnya pengetahuan dalam penggunaan teknik nonfarmakologis dan rute pemberian obat

Rekomendasi untuk meningkatkan perawatan akhir hayat di rumah sakit meliputi diantaranya dengan mendidik staf, mengidentifikasi dan menilai orang yang membutuhkan perawatan, menerapkan alur perawatan, dan memastikan akses ke tim perawatan paliatif spesialis. Perawatan tersebut harus memenuhi kebutuhan lansia, yang sering memiliki penyakit komorbid, seperti penyakit kardiovaskular, artritis, demensia, atau kehilangan sensorik dan meninggal karena penyakit selain kanker. Memenuhi berbagai kebutuhan ini di lingkungan rumah sakit menuntut keterampilan dan kerja sama tim yang baik antar spesialis, termasuk dokter geriatri, ahli onkologi, ahli jantung, klinisi perawatan paliatif, apoteker, psikolog, pekerja sosial, ahli gizi, staf perawat, terapis wicara, dan rohaniawan, pada berbagai tahap penyakit (Lombogia et al., 2024).

Tinjauan literatur sistematis menunjukkan bahwa tim perawatan paliatif rumah sakit efektif dalam memperbaiki gejala dan masalah lainnya. Pemahaman farmakologi geriatri sangat penting karena perubahan fisiologis akibat penuaan seperti penurunan cadangan organ, perubahan absorpsi, distribusi, dan metabolisme obat dapat meningkatkan risiko efek samping dan komplikasi serius. Pada lansia, absorpsi obat dapat menurun, sehingga penggunaan obat dengan waktu paruh pendek lebih aman dibandingkan formulasi kerja panjang seperti opioid lepas lambat atau transdermal. Polifarmasi menjadi masalah besar karena lansia mengonsumsi lebih banyak obat dibandingkan populasi muda (Palliative Nursing, 2020). Banyaknya obat meningkatkan risiko interaksi, reaksi merugikan, efek samping yang dapat membatasi terapi serta kondisi komorbid yang kompleks di akhir hayat memperburuk risiko ini. Oleh karena itu, pemilihan obat yang hati-hati, pemantauan mendekat, dan pemahaman interaksi obat sangat penting dalam meningkatkan kenyamanan dan keamanan pasien paliatif lansia.

Perawatan gejala yang umum dialami lansia di akhir hayat, antara lain;

1. Dispnea.

Dispnea merupakan gejala penyakit yang dapat menimbulkan sensasi sesak atau kesulitan bernapas yang berdampak besar pada disabilitas dan kualitas hidup. Perubahan fisiologis akibat penuaan seperti penurunan elastisitas paru, kelemahan otot pernapasan, postur membungkuk, serta penurunan kekuatan diafragma berkontribusi pada munculnya dispnea. Penatalaksanaan dispnea pada pasien lansia meliputi penentuan etiologi seperti efusi pleura, penyelarasan tujuan perawatan sesuai keinginan pasien, serta intervensi farmakologis seperti morfin untuk dispnea dan lorazepam untuk kecemasan. Evaluasi kondisi seperti kelelahan dan anemia dilakukan, sementara keputusan intervensi tambahan

dipertimbangkan berdasarkan manfaat dan beban. Aktivitas fisik diminimalkan melalui dukungan perawatan rumah dan alat bantu, disertai dukungan emosional bagi pasien dan keluarga, termasuk edukasi tentang kondisi akhir hayat. Intervensi nonfarmakologis seperti kipas angin, relaksasi, imajinasi terbimbing, dan musik digunakan untuk mengurangi sesak dan kecemasan (Paliatif Care, 2020).

2. Delirium.

Delirium ditandai kondisi akut, fluktuasi kesadaran, dan biasanya bersifat sementara, sedangkan demensia berlangsung kronis dengan gangguan memori dan fungsi kognitif jangka panjang. Lansia sangat rentan mengalami delirium akibat penyakit akut, efek obat, infeksi, perpindahan rumah sakit, serta perubahan fisiologis terkait usia. Di akhir hayat, delirium sangat umum pada pasien lansia dengan prevalensi tinggi serta etiologi yang sering multifaktorial. Faktor risiko meliputi usia lanjut, gangguan kognitif, malnutrisi, infeksi, polifarmasi, penurunan metabolisme obat, dan perubahan neurologis akibat penuaan atau penyakit otak. Delirium meningkatkan morbiditas, mortalitas, dan beban bagi pasien maupun keluarga, serta dapat menyebabkan jatuh dan komplikasi lain.

3. Demensia

Demensia adalah penyakit terminal progresif tanpa obat, dengan prognosis antara 2 hingga lebih dari 15 tahun dan fase akhir yang berlangsung 23 tahun. Prevalensinya meningkat seiring bertambahnya usia, terutama pada populasi di atas 85 tahun. Seiring perkembangan penyakit, penderita mengalami gangguan kognitif, fungsional, dan fisik yang memburuk secara bertahap. Pada tahun terakhir kehidupan, gejala umum meliputi gangguan kognitif berat, inkontinensia, nyeri, depresi, sembelit, dan hilangnya nafsu makan.

Pengendalian delirium agitasi biasanya menggunakan neuroleptik (misalnya haloperidol; risperidon atau olanzapin), sementara benzodiazepin harus dihindari pada pasien dengan riwayat gangguan psikiatri atau putus alkohol. Respons pengobatan delirium pada lansia sering lebih buruk, terutama pada pasien di atas 70 tahun atau memiliki faktor risiko seperti demensia, metastasis ke sistem saraf pusat, atau hipoksia.

4. Nyeri.

Nyeri dapat diartikan sebagai gambaran pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan aktual maupun potensial, sehingga manajemen nyeri bersifat multidimensi dan dipengaruhi oleh faktor fisik, psikologis, sosial, dan spiritual, sehingga penanganannya membutuhkan pendekatan multidisiplin, terutama dalam pelayanan paliatif. Manajemen nyeri diberikan kepada pasien dengan kondisi progresif seperti PPOK, kanker, stroke,

atau gagal jantung, dan dapat dilakukan sejak awal untuk memberikan dampak positif yang memungkinkan pasien tetap aktif dan keluar-masuk program paliatif sesuai kebutuhan. Pengendalian nyeri bertujuan melakukan deteksi dini, mengurangi nyeri, serta melakukan monitoring dan dokumentasi, disertai edukasi mengenai gejala yang perlu diperhatikan dan cara penanganannya.

Tujuan manajemen gejala nyeri dalam perawatan paliatif adalah meningkatkan kesejahteraan fisik, fungsionalitas, dan kualitas hidup pasien melalui penilaian komprehensif oleh tim interdisipliner yang melibatkan tenaga medis, sosial, dan spiritual. Pendekatan ini mempertimbangkan faktor fisik, emosional, spiritual, dan budaya yang memengaruhi persepsi pasien terhadap penyakit, pelaporan gejala, serta preferensi dan pengambilan keputusan terapi. Selain itu, penggunaan alat penilaian gejala yang tervalidasi diperlukan untuk memantau nyeri, fungsi, kualitas hidup, serta efektivitas pengobatan secara berkelanjutan. Nyeri yang dialami lansia dapat diatasi dengan terapi farmakologis diberikan dengan obat NSAID (Non steroid Anti Imflammatory Drugs,) dan analgesik. Sedangkan non farmakologis dapat diterapkan manajemen nyeri seperti distraksi dan Relaksasi.

F. Perawatan Akhir Kehidupan (End of Life Care)

End of life care adalah perawatan yang diberikan pada fase akhir kehidupan, dimana perawatan ini diberikan saat pasien mengalami prognosis yang buruk. Fokus utama perawatannya adalah memberikan kenyamanan, martabat serta dukungan spiritual dan emosional. *End of life care* merupakan stadium akhir dari sebuah penyakit, dimana harapan hidup <12 bulan dan telah terjadi penurunan kondisi fisik serta psikologis yang cepat disertai peningkatan Gejala (Taher et al, 2023).

Adapun *goals dari end of life care* diantaranya (Setyowati, 2021):

1. Mengurangi penderitaan. Tujuan utama dari EoLC adalah mengurangi penderitaan pasien dengan mengontrol nyeri dan gejala fisik lain seperti sesak, mual, gelisah, konstipasi, gangguan tidur, atau lemah. Perawatan difokuskan pada kenyamanan, bukan penyembuhan, sehingga manajemen gejala menjadi prioritas.
2. Mengoptimalkan kualitas hidup pasien hingga akhir hayat. EoLC berupaya memastikan pasien tetap memiliki kualitas hidup terbaik pada fase akhir, misalnya dengan menjaga kebersihan diri, memberikan nutrisi sesuai kemampuan, menyediakan lingkungan yang nyaman, serta mendukung aktivitas sederhana yang masih bisa dilakukan pasien.
3. Memberikan kenyamanan pada pasien dan mendukung proses kematian yang bermartabat. Pada fase akhir kehidupan, tindakan medis agresif sering tidak

memberikan manfaat signifikan dan justru menambah penderitaan. EoLC fokus menghindari prosedur yang tidak mendukung kenyamanan pasien, seperti tindakan invasif tanpa indikasi kua. EoLC membantu pasien melewati proses menjelang kematian secara tenang, tanpa rasa sakit berlebih, tanpa kecemasan, serta dalam kondisi yang sesuai dengan keinginan pasien⁴ misalnya ingin meninggal di rumah bersama keluarga atau di fasilitas kesehatan.

4. Menghormati nilai, pereferensi dan pilihan pasien. Setiap pasien harus tetap dihormati sebagai individu yang memiliki pilihan dan nilai. EoLC memastikan tindakan keperawatan dilakukan dengan sopan, menghargai privasi, dan tidak memaksakan intervensi yang tidak diinginkan pasien. Dalam pemberian pelayanan tenaga kesehatan menjelaskan kondisi, pilihan perawatan, dan kemungkinan hasilnya sehingga pasien dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai serta harapannya. Termasuk di dalamnya advance care planning, seperti keputusan resusitasi dan perawatan invasif.
5. Menyiapkan emosional pasien dan keluarga menghadapi kehilangan. Keluarga sering mengalami stres, kebingungan, dan kelelahan saat merawat pasien terminal. EoLC memberikan edukasi, informasi perkembangan kondisi, dukungan emosional, serta persiapan menghadapi kematian. Setelah pasien meninggal, keluarga juga mendapat dukungan dalam proses Berduka.
6. Meningkatkan koordinasi antar tim kesehatan dan keluarga. Perawatan pasien dengan kondisi akhir hayat tidak hanya memastikan koordinasi dengan tenaga kesehatan tetapi juga perlunya melibatkan keluarga sebagai komponen inti dalam perencanaan perawatan akhir hayat. EoLC memastikan komunikasi antarprofesi berjalan baik sehingga pelayanan bersifat holistik, konsisten, dan benar-benar sesuai kebutuhan pasien.

Prinsip *End of Life Care*, antara lain:

1. Perawatan Berpusat pada Pasien (*Patient Centered Care*)

Prinsip ini menekankan bahwa setiap keputusan perawatan harus berlandaskan nilai, preferensi, harapan, dan tujuan hidup pasien. Dalam konteks akhir kehidupan, pasien memiliki kebutuhan unik terkait bagaimana ia ingin menghabiskan sisa hidupnya, termasuk pilihan mengenai terapi yang diinginkan atau tidak diinginkan. Perawatan berpusat pada pasien berarti tenaga kesehatan tidak hanya fokus pada kondisi medis, tetapi juga menghormati autonomy pasien dalam pengambilan keputusan. Perawat berperan sebagai advokat pasien, memastikan bahwa suara dan keinginan pasien tetap menjadi panduan utama dalam setiap intervensi yang dilakukan. Prinsip ini membantu pasien merasa dihargai, mendapatkan kontrol atas kehidupannya, serta mengurangi kecemasan selama menghadapi fase terminal.

2. Perawatan Holistik(*Holistic Care*)

End of Life Care tidak hanya memusatkan perhatian pada masalah fisik seperti nyeri atau sesak, tetapi juga mencakup aspek psikologis, sosial, dan spiritual. Perawatan holistik memastikan bahwa pasien dilihat sebagai individu utuh yang memiliki emosi, hubungan sosial, keyakinan, dan kebutuhan spiritual yang harus dipenuhi. Pada fase akhir kehidupan, dimensi-dimensi non-fisik seringkali menjadi sumber distress yang sama beratnya dengan gejala medis. Oleh karena itu, tim kesehatan berkolaborasi untuk memberikan intervensi yang mampu mengurangi kecemasan, memberikan dukungan spiritual, memperkuat hubungan keluarga, serta mendorong penerimaan diri. Pendekatan holistik menjadikan pengalaman akhir hidup pasien lebih bermakna dan manusiawi.

3. Komunikasi Terbuka dan Empatik.

Komunikasi adalah inti dari End of Life Care karena membantu pasien dan keluarga memahami kondisi, prognosis, dan pilihan perawatan yang tersedia. Komunikasi yang baik harus jujur, transparan, tetapi disampaikan dengan empati agar tidak menimbulkan trauma emosional. Perawat memiliki tanggung jawab besar dalam menjelaskan kondisi medis menggunakan bahasa yang mudah dipahami, mengklarifikasi harapan pasien, dan memfasilitasi diskusi terkait keputusan perawatan. Komunikasi empatik membantu mengurangi rasa takut, memberi ruang bagi keluarga untuk mengungkapkan kekhawatiran, dan memperkuat kepercayaan antara pasien, keluarga, dan tim kesehatan. Dengan demikian, keputusan perawatan dapat diambil secara bersama-sama dengan informasi lengkap dan penghargaan terhadap perasaan semua pihak.

4. Keterlibatan Keluarga (*Family Involvement*).

Keluarga adalah bagian penting dalam sistem dukungan pasien menjelang akhir kehidupan. Mereka tidak hanya memberikan dukungan emosional, tetapi juga terlibat dalam pengambilan keputusan dan perawatan harian. Prinsip keterlibatan keluarga memastikan bahwa keluarga diberikan informasi yang jelas, dilibatkan dalam diskusi perawatan, serta didampingi untuk memahami kondisi pasien. Dalam banyak budaya, termasuk di Indonesia, keputusan medis sering diambil secara kolektif oleh keluarga. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu memberikan edukasi, dukungan emosional, serta bimbingan untuk membantu keluarga mempersiapkan diri menghadapi perubahan kondisi pasien, proses menjelang kematian, hingga fase berduka. Pendekatan ini membantu keluarga merasa dihargai, mengurangi penyesalan, dan memperkuat ikatan emosional di akhir kehidupan pasien.

5. Kolaborasi Interdisiplin (*Interdisciplinary Collaboration*).

End of Life Care membutuhkan pendekatan interdisiplin karena kompleksitas kebutuhan pasien tidak dapat ditangani oleh satu profesi saja. Tim EoLC terdiri dari dokter, perawat, psikolog, rohaniawan, pekerja sosial, terapis, dan profesional lain sesuai kebutuhan. Kolaborasi ini memastikan bahwa setiap aspek fisik, emosional, sosial, dan spiritual ditangani secara komprehensif. Perawat berperan penting sebagai koordinator yang menghubungkan pasien, keluarga, dan seluruh anggota tim. Pertemuan tim secara berkala membantu memastikan konsistensi dalam rencana perawatan, menghindari intervensi yang tidak perlu, serta memperkuat integrasi layanan. Dengan kerja sama interdisiplin yang efektif, kualitas perawatan meningkat dan pasien dapat memperoleh pengalaman akhir hidup yang lebih damai dan bermartabat.

Fase End of Life Care ini menggambarkan perjalanan pasien dari awal penyakit terminal hingga setelah kematian. Berikut beberapa fase yang dilewati oleh pasien menurut Lehmann et al (2021):

1. Fase Stabil.

Pada fase ini, pasien memiliki penyakit serius atau terminal namun kondisinya masih relatif stabil dan gejala dapat dikendalikan. Fokus pelayanan adalah memberikan manajemen gejala yang tepat, edukasi mengenai penyakit, serta memulai diskusi mengenai perencanaan perawatan ke depan termasuk keinginan pasien tentang tindakan medis tertentu. Pada tahap ini, tim paliatif membantu pasien dan keluarga memahami perjalanan penyakit sehingga mereka dapat membuat keputusan yang sesuai dengan nilai dan harapan pasien.

2. Fase Unstable.

Fase ini ditandai dengan memburuknya gejala, munculnya komplikasi baru, atau menurunnya respons terhadap terapi yang sebelumnya efektif. Perubahan ini menimbulkan kebutuhan penanganan intensif baik secara medis maupun psikososial. Tim kesehatan harus segera mengevaluasi kondisi pasien, menyesuaikan rencana perawatan, dan memberikan intervensi untuk mengurangi ketidaknyamanan. Selain itu, pasien dan keluarga memerlukan dukungan emosional karena fase ini sering menimbulkan kecemasan dan ketidakpastian mengenai prognosis.

3. Fase Deteriorating (Memburuk).

Pada fase ini, pasien memperlihatkan penurunan kondisi yang signifikan seperti kelemahan berat, penurunan intake makanan dan cairan, serta penurunan kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari. Prognosis biasanya menurun menjadi hitungan minggu hingga beberapa hari. Fokus utama perawatan adalah memaksimalkan kenyamanan pasien, meminimalkan tindakan invasif yang tidak

memberikan manfaat, dan memastikan pasien tetap merasa dihargai serta didukung. Keluarga perlu dipersiapkan secara emosional dan informatif mengenai kemungkinan terjadinya fase terminal.

4. Fase Terminal / Dying Phase (Aktif Menjelang Kematian).

Fase ini merupakan periode terakhir menjelang kematian ketika tubuh menunjukkan tanda-tanda fisiologis penghentian fungsi organ. Gejala umum meliputi napas Cheyne-Stokes, penurunan perfusi, penurunan kesadaran, kulit dingin, dan oliguria atau anuria. Prognosis biasanya berkisar antara beberapa jam hingga beberapa hari. Fokus perawatan adalah menghilangkan rasa sakit, memberikan dukungan emosional dan spiritual intensif, serta menciptakan lingkungan tenang dan nyaman agar pasien dapat meninggal dengan damai dan bermartabat. Keluarga didampingi secara dekat dalam proses ini.

5. Fase Bereavement (Duka Cita).

Fase ini dimulai setelah pasien meninggal dan berfokus pada dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Tim kesehatan membantu keluarga memahami reaksi duka yang normal, menyediakan ruang untuk berekspresi, dan menawarkan bimbingan bila muncul gejala duka yang rumit. Upaya ini penting untuk mencegah gangguan psikologis jangka panjang serta membantu keluarga menyesuaikan diri dengan kehidupan tanpa kehadiran pasien. Layanan dukungan dapat diberikan dalam bentuk konseling, kelompok dukungan, atau kunjungan tindak lanjut.

Perawat memiliki peran yang sangat penting dalam *End of Life Care* karena sebagai tenaga kesehatan yang paling sering berada di samping pasien dan keluarga. Perawat tidak hanya memberikan intervensi klinis, tetapi juga mendampingi secara emosional, menjadi penghubung komunikasi, serta menjamin bahwa proses akhir kehidupan berjalan dengan bermartabat.

Berikut penjelasan rinci mengenai peran perawat dalam EoLC, antara lain:

1. Peran sebagai Advokat.

Pasien Perawat berperan memastikan bahwa hak, nilai, dan keinginan pasien tetap dihormati selama masa akhir hidup. Sebagai advokat, perawat membantu menyuarakan preferensi pasien, terutama ketika pasien tidak dapat lagi mengkomunikasikannya secara jelas. Hal ini meliputi memastikan pilihan terkait resusitasi, intervensi invasif, terapi simptomatik, hingga tempat di mana pasien ingin menghabiskan akhir hidupnya dipertimbangkan dalam rencana perawatan. Dalam situasi dilematis, perawat membantu keluarga dan tim kesehatan mempertimbangkan keputusan berdasarkan prinsip otonomi dan martabat pasien. Perawatan advokasi ini memberikan rasa aman dan kontrol bagi pasien di tengah ketidakpastian kondisi terminal.

2. Edukator bagi Pasien dan Keluarga.

Perawat memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan edukasi terkait kondisi penyakit, prognosis, rencana perawatan, dan tanda-tanda menjelang kematian. Edukasi ini sangat penting agar pasien dan keluarga tidak merasa bingung atau terkejut ketika kondisi berubah. Penjelasan mengenai manajemen nyeri, penggunaan obat, teknik relaksasi, dan cara memberikan perawatan dasar juga membantu keluarga yang merawat pasien di rumah. Dengan edukasi yang jelas, keluarga merasa lebih siap, lebih percaya diri, dan dapat memberikan perawatan dengan benar tanpa rasa cemas berlebihan. Edukasi ini juga mengurangi risiko kesalahpahaman dan konflik dalam pengambilan keputusan.

3. Memberikan Asuhan.

Perawat bertanggung jawab memberikan intervensi klinis yang tepat untuk mengurangi gejala dan meningkatkan kenyamanan pasien. Tindakan ini mencakup manajemen nyeri, pengendalian sesak napas, pengelolaan mual muntah, perawatan kulit, serta pencegahan komplikasi akibat imobilisasi. Selain itu, perawat juga memantau perubahan kondisi pasien secara terus-menerus, melakukan asesmen rutin, dan melaporkan temuan signifikan kepada tim medis. Pendekatan ini memastikan perawatan yang diberikan selalu responsif terhadap perubahan kondisi dan sesuai praktik terbaik. Dalam konteks EoLC, intervensi berfokus pada kenyamanan, bukan pada kuratif, sehingga perawat harus memiliki kepekaan klinis dan pengetahuan mendalam tentang tanda-tanda akhir kehidupan.

4. Komunikator Utama antara Pasien, Keluarga, dan Tim Kesehatan.

Perawat sering menjadi penghubung utama yang memastikan alur komunikasi berjalan efektif. Mereka menyampaikan informasi medis dalam bahasa sederhana, mengklarifikasi pemahaman pasien dan keluarga, serta menerjemahkan istilah medis menjadi informasi yang manusiawi dan mudah dipahami. Selain itu, perawat membantu menggali ekspektasi keluarga, memberikan ruang untuk bertanya, dan mendampingi dalam pengambilan keputusan. Komunikasi empatik ini sangat penting karena membantu mengurangi kecemasan dan konflik, terutama pada momen kritis seperti perubahan kondisi mendadak atau keputusan penghentian terapi. Dengan kemampuan komunikasi yang baik, perawat dapat menciptakan hubungan kepercayaan yang kuat.

5. Pemberi Dukungan Emosional dan Psikologis.

Pasien yang sedang berada di akhir hidup sering mengalami kecemasan, rasa takut, kebingungan, atau depresi. Keluarga pun dapat mengalami distress emosional yang besar. Perawat memainkan peran kunci dalam memberikan dukungan emosional dengan hadir secara terapeutik, mendengarkan aktif, mengakui perasaan pasien, serta memberikan rasa aman dan ketenangan. Perawat membantu pasien dalam proses penerimaan dan memberikan ruang untuk mengekspresikan keinginan atau ketakutan menjelang kematian. Untuk keluarga, perawat memberikan dukungan empatik dengan memvalidasi emosi, memberikan edukasi mengenai kondisi pasien, serta membantu mereka menghadapi proses kedukaan. Interaksi emosional ini tidak hanya memperkuat hubungan perawat-pasien, tetapi juga meningkatkan kualitas akhir hidup pasien.

6. Spiritual Support Provider.

Pada fase akhir kehidupan, kebutuhan spiritual pasien seringkali meningkat, bahkan menjadi pusat perhatian. Perawat tidak harus menjadi pemuka agama, tetapi mereka harus mampu mengidentifikasi kebutuhan spiritual pasien, baik berupa pencarian makna, harapan, pengampunan, atau rekonsiliasi. Perawat juga memfasilitasi akses kepada rohaniawan atau pemuka agama sesuai keyakinan pasien. Selain itu, mereka memberikan ruang untuk ritual spiritual, doa, atau praktik religius pihak keluarga. Dukungan spiritual ini membantu pasien merasakan kedamaian dan mengurangi ketakutan menjelang kematian, serta membantu keluarga melalui masa transisi emosional yang sulit.

7. Fasilitator Perencanaan Lanjutan (*Advance Care Planning Facilitator*).

Advance Care Planning (ACP) adalah proses penting dalam EoLC, dan perawat berperan besar dalam memfasilitasinya. Perawat membantu pasien memahami kondisi dan pilihan intervensi, mendiskusikan keinginan akhir hidup, dan mendokumentasikan keputusan seperti DNR (Do Not Resuscitate), penggunaan ventilator, atau lokasi kematian yang diinginkan. Perawat juga berperan membantu keluarga memahami tujuan Advance Care Planning (ACP) agar keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan nilai, keinginan, dan preferensi pasien. Dengan adanya ACP yang jelas, perawat dapat memandu keluarga sehingga potensi konflik dapat diminimalkan, dan perawatan yang diberikan benar-benar sesuai dengan harapan pasien. Selain memberikan asuhan secara komprehensif, perencanaan keperawatan berkelanjutan juga memerlukan dukungan organisasi pelayanan kesehatan melalui struktur manajemen yang suportif. Lingkungan kerja yang baik akan meningkatkan kepuasan kerja perawat, mengurangi kelelahan atau burnout, serta meningkatkan kualitas pelayanan. Pada akhirnya, seluruh upaya ini akan bermuara pada meningkatnya kepuasan

pasien, hasil klinis yang lebih baik, dan peningkatan keselamatan dalam pemberian perawatan.

8. Pendukung dan Pemandu dalam Fase Duka (*Bereavement Support*).

Peran perawat tidak berhenti saat pasien meninggal, tetapi tetap bertanggung jawab memberikan dukungan kepada keluarga dalam fase duka. Hal ini mencakup memberikan informasi terkait prosedur pascakematian, memberikan konseling singkat, mendengarkan keluhan emosional, dan mengarahkan keluarga ke layanan dukungan lanjutan jika dibutuhkan. Sikap empatik dan penghormatan terhadap keluarga membantu mereka melewati masa berduka dengan lebih sehat secara emosional. Pendampingan ini menjadi bagian penting dari kesinambungan perawatan dan menunjukkan nilai kemanusiaan dalam EoLC.

G. Penutup

Perawatan paliatif adalah pendekatan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup pasien (anak-anak, dewasa dan lansia) beserta keluarga dalam menghadapi penyakit yang mengancam jiwa, dengan cara meringankan penderitaan rasa sakit melalui identifikasi dini, pengkajian yang sempurna, dan penatalaksanaan nyeri serta masalah lainnya baik fisik, psikologis, sosial atau spiritual. Tim perawatan paliatif bertujuan untuk menggunakan pendekatan holistik dalam menangani semua kebutuhan, bukan hanya pada kondisi medis spesifik. Pada pasien lansia, perawatan paliatif dapat diberikan pada penyakit kronis, degeneratif, atau kondisi terminal. Dalam mengoptimalkan kualitas hidup pasien lansia hingga akhir hayat, maka End of Life Care (EoLC) merupakan perawatan yang diberikan pada fase akhir kehidupan, dimana perawatan ini diberikan saat pasien mengalami prognosis yang buruk. Fokus utama perawatannya adalah memberikan kenyamanan, martabat serta dukungan spiritual dan emosional. Fase End of Life Care ini menggambarkan perjalanan pasien dari awal penyakit terminal hingga setelah kematian. Perawat memiliki peran yang sangat penting dalam End of Life Care karena sebagai tenaga kesehatan yang paling sering berada di samping pasien lansia dan keluarga.

Referensi

- American Nurses Association. (2020). Code Of Ethics For Nurses With Interpretive Statements. ANA Publications.
- Cherny, N. I., Fallon, M., Kaasa, S., Portenoy, R. K., & Currow, D. C. (2020). Oxford Textbook Of Palliative Medicine (6th ed.). Oxford University Press.
- Fahmi, M, K., Salmiyati, S., Suratin. (2025). The Relationship of Palliative Care to Quality of Life in the Elderly: A Literature Review. 5(4). <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/JMS/article/view/6804>. 694-696.
- Ferrell, B. R., & Paice, J. A. (2019). The Role Of Palliative Care Nursing In Improving Quality Of Life. *Palliative Nursing Review*, 21(3), 145-158.
- Ferrell, B. R., Paice, J. A. (2020). Spiritual Care In Palliative Nursing. *Journal Of Hospice & Palliative Nursing*, 22(4), 201-209.
- Global Atlas of Palliative Care. (2020). Global Atlas Of Palliative Care (2nd ed.). Worldwide Hospice Palliative Care Alliance.
- Hasrima, Shafwan, A., Yanthi, S., Rahmadania, W, O., Indra, Narmawan, Nazaruddin, |Firman, Kurnia, V., Harmanto, Efendi, S., Pauzi, M. (2022). Keperawatan Paliatif Dan Menjelang Ajal. *Eureka Media Aksara; Jawa Tengah*. 29-76.
- Hearn, J., & Higginson, I. J. (2021). Effective Symptom Management In Palliative Care: Evidence And Practice. *Palliative Medicine Journal*, 35(1), 12-28.
- Hudson, P., & Payne, S. (2020). Family Caregiving And The Needs Of Carers In Palliative Care. *Palliative Care Research Review*, 18(2), 55-68.
- Jerant, A, F., Azari, R, S., Nesbitt, T, S., Meyers, F, J. (2004). The TLC Model of Palliative Care in the Elderly: Preliminary Application in the Assisted Living Setting. 2(1). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1466621/>. 55-57.
- Kaasa, S., & Loge, J. H. (2021). Handbook of palliative care (3rd ed.). Springer. Kent, E. E., Rowland, J. H., Northouse, L., & Litzelman, K. (2021). Caregiver Support And Outcomes In Chronic And Terminal Illness. *Supportive Care in Cancer*, 29(4), 155731570.
- Kabak, E., Utami, D, L., Pratiwi, W, N., Nugraha, M, A., Sari, N, P, W, P., T., Sahreny, S., Andraini, R., Silfia, A., Joeliantina, A., Kulsum, D, U., Hunowu, S, Y., (2025). Keperawatan Paliatif Lanjut Usia. *Eureka Media Aksara; Jawa Tengah*, 3-80.
- Langitan, R, E., Idayanti, Dewi, M., Kanine, E., Sinaga, S, E, N., Kolompoy, R, M, N, J, A., Merentek, G, A., Suwarja, Rofiyati, W., Kristiani, A., Tangka., J, W., Subriah, Sarayar, S, C, P., Maretha, D, E., Fitriani, S., (2024). Gerontik: Menyelami Tantangan Dan Permasalahan Di Usia Lanjut. PT Media

- Pustaka Indo; Jawa Tengah, 83-190.
- Lombogia, M., Wahyudi, T., & Suprpti, T. (2024). Keperawatan Paliatif. PT MEDIA PUSTAKA INDO JL.
- Maulana, I., Ns, M. B., Amanupunnyo, N. A., & Hasan, S. M. (2020). Keperawatan Paliatif dan krotis
- Manurung, S, S., Ritonga, I, L., Damanik, H. (2020). Buku Ajar Keperawatan Gerontik. Deepublish; Yogyakarta, 7-23.
- Riyadi, S., Sumedi, T., Sukrillah, U, A., Kuhu, M, M., Widayanti, E, D., Kuswati, A., (2025). Keperawatan Gerontik. Eureka Media Aksara; Jawa Tengah, 4-23.
- O'Connor, M., & Weir, J. (2021). Psychosocial Support In End-Of-Life Care: Family And Patient Needs. *Journal of Palliative and Supportive Care*, 19(3), 221-230.
- Puchalski, C. M., Vitillo, R., Hull, S. K., & Reller, N. (2020). Spirituality And Health: A Review Of Evidence And Practice. *The Lancet*, 395(10217), 678-687. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15183215/>.
- Payne, S., Hudson, P., & Grande, G. (2020). Social Support In Palliative Care: A Multidimensional Framework. *European Journal of Palliative Care*, 27(5), 232-239. https://www.researchgate.net/publication/286514608_White_paper_on_improving_support_for_family_carers_in_palliative_care_Part_1_Recommendations_from_the_European_association_for_palliative_care_EAPC_task_force_on_family_carers
- Palliative Care. (2020) Palliative Care For Older People: Better Practices. <https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289002240>. WHO: World Health Organization Health.
- Puchalski, C. M., & Ferrell, B. R. (2020). Making Health Care Whole: Integrating Spirituality Into Patient Care (2nd ed.). Templeton Press. <https://pdfs.semanticscholar.org/1ea2/4c6af3696f2a8ab40881226af2d9ba5e461f.pdf>.
- Setyowati, Sihombing, F., Wardhani, I, K., Setiyowati, Y, D., Rochani, S., Hardayati, Y, A., Susilowati, Y, A., Sinawang, G, W., Suprpti, F., Djajanti C, W., Lestarina, N, W., Haeriyah, Y, S., Hardjanti, S, T, M., Indriasari S, W., Barus, L, S., Kristianingsih, Y., Indah, E., Yuliati, S, I., Widayanti, M, R. (2023). Buku Ajar Keperawatan Paliatif (Berdasarkan Kurikulum Pendidikan Ners Indonesia Tahun 2021). Eureka Media Aksara; Jawa Tengah, 23-163.
- Sinulingga, E. (n.d.). BUKU AJAR Keperawatan Paliatif. PT Nuansa Fajar Cemerlang; Jakarta.
- Taher, R., Priliana, W, K., Syaiful, Y., Harkomah, I., Setiawan, D, R., Fibriyanti, E., Chaizuran, M., Ponidjan, T, S., Yan, L, S., Kiling, M, A., Pratidina, E. (2023).

- Keperawatan Paliatif. PT Media Pustaka Indo; Jawa Tengah, 9-120.
- World Health Organization. (2022). Palliative Care: Key Facts And Clinical Guidelines. WHO Press. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care>.
- Zheng, Y., Wang, F., & Liu, S. (2023). Digital Behavioral Interventions For Chronic Disease Prevention: A Systematic Review. *Preventive Medicine Reports*, 33, 102-113.

Glosarium

Absorpsi

Absorpsi: adalah proses penyerapan suatu zat ke dalam zat lain

Advokat

Advokat: adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang

Alzheimer

Alzheimer: adalah gangguan otak progresif yang merusak sel-sel otak secara perlahan, menyebabkan penurunan kemampuan kognitif yang parah.

Anuria

Anuria: adalah kondisi klinis di mana produksi urine hampir tidak ada atau sama sekali tidak ada.

Autonomy

Autonomy: adalah prinsip etika yang menghormati hak pasien untuk mengambil keputusan sendiri mengenai perawatan medisnya.

Beneficence

Beneficence: adalah prinsip etika keperawatan yang menuntut perawat untuk bertindak demi kepentingan terbaik pasien, memberikan manfaat, dan mencegah kesalahan atau bahaya.

Caregiver Fatigue

Caregiver fatigue: adalah kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental yang ekstrem yang dialami oleh seseorang (biasanya keluarga atau teman) saat merawat orang lain yang sakit kronis, disabilitas, atau lansia.

Care Provider

Care provider: adalah kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental yang ekstrem yang dialami oleh seseorang (biasanya keluarga atau teman) saat merawat orang lain yang sakit kronis, disabilitas, atau lansia.

Cheyne-Stokes

Cheyne-Stokes adalah pola pernapasan tidak normal yang ditandai dengan siklus pernapasan cepat dan dalam (hiperventilasi), diikuti oleh pernapasan lambat/dangkal, dan kemudian berhenti bernapas sementara (apnea).

Comfort Measures

Comfort measures: adalah intervensi atau tindakan yang dilakukan untuk meringankan penderitaan, menghilangkan rasa sakit, dan memberikan kenyamanan fisik, emosional, maupun spiritual bagi pasien yang mendekati akhir hayat (paliatif).

Demensia

Demensia (sering disebut pikun): adalah sindrom penurunan fungsi intelektual dan memori yang cukup berat, bersifat progresif (memberat perlahan), dan menetap.

Delirium

Delirium: adalah gangguan fungsi mental (kesadaran) yang terjadi secara mendadak/akut, berfluktuasi, dan biasanya dapat dipulihkan.

Distress Emosional

Distress emosional: adalah reaksi psikologis negatif yang muncul saat seseorang menghadapi tekanan yang terasa berat, mengancam, atau sulit dikendalikan.

Dispnea

Dispnea: adalah istilah medis untuk sesak napas atau kesulitan bernapas

Distraksi

Distraksi: adalah pengalihan perhatian dari satu hal ke hal lain.

Edukasi

Edukasi: adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap, dan perilaku pasien atau keluarga agar mampu mandiri dalam memelihara, meningkatkan, atau memulihkan kesehatannya.

Fisioterapi

Fisioterapi: adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan/atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara fisik (tanpa obat-obatan), seperti latihan fisik, terapi manual, atau penggunaan alat.

Holistik

Holistik: adalah pendekatan penyembuhan yang menyeluruh, memandang manusia sebagai satu kesatuan utuh yang terdiri dari fisik, mental, emosional, sosial, dan spiritual.

Hospitalisasi

Hospitalisasi: adalah proses yang mengharuskan seseorang tinggal di rumah sakit untuk menjalani terapi, perawatan, atau prosedur medis tertentu.

Integrasi

Integrasi: adalah proses neurologis dalam mengorganisir sensasi dari tubuh dan lingkungan agar dapat digunakan secara efektif.

Intensitas Distress

Intensitas distress: adalah ingkat atau kekuatan beban emosional/psikologis yang dirasakan seseorang, seperti kecemasan, ketakutan, rasa sakit, atau stres berat.

Isolasi Sosial

Isolasi sosial: adalah keadaan di mana seseorang mengalami penurunan atau bahkan ketidakmampuan total untuk berinteraksi dengan orang lain atau lingkungan sekitarnya.

Infeksi

Infeksi: adalah masuk dan berkembang biaknya agen infeksius (seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit) di dalam tubuh, yang menyebabkan reaksi peradangan atau kerusakan jaringan

Justice

Justice: adalah prinsip etika dasar yang menuntut perlakuan adil, merata, dan setara kepada semua pasien, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, ras, atau agama.

Konseling

Konseling: adalah proses interaksi pribadi dan profesional antara konselor (ahli) dan klien (pasien/individu) untuk membantu memahami diri sendiri, mengatasi hambatan perkembangan, dan memecahkan masalah.

Kondisi Terminal

Kondisi terminal: adalah merujuk pada penyakit progresif yang tidak dapat disembuhkan atau diobati secara akurat, yang diperkirakan akan menyebabkan kematian dalam waktu dekat (umumnya 6 bulan atau kurang)

Koping Adaptif

Koping adaptif: adalah mekanisme pertahanan diri atau usaha positif yang dilakukan individu untuk mengatasi stres, kecemasan, atau masalah dengan cara yang sehat dan konstruktif.

Komunikasi Terapeutik

Komunikasi terapeutik: adalah komunikasi yang direncanakan secara sadar, bertujuan, dan kegiatannya difokuskan untuk kesembuhan pasien. Ini merupakan perpaduan antara keterampilan komunikasi dan pendekatan psikologis.

Konsultasi Bioetika

Konsultasi bioetika adalah proses diskusi yang melibatkan komite etik atau ahli etika medis untuk membantu menyelesaikan dilema moral atau etika yang terjadi dalam perawatan pasien

Legalitas

Legalitas: adalah perihal keadaan sah atau keabsahan suatu tindakan, dokumen, atau entitas berdasarkan hukum yang berlaku.

Mobilisasi

Mobilisasi: adalah kemampuan individu untuk bergerak secara bebas, mudah, dan teratur dengan tujuan memenuhi kebutuhan aktivitas dan mempertahankan kesehatan

Metabolisme

Metabolisme: adalah serangkaian proses kimia atau reaksi biokimia yang terjadi di dalam sel tubuh makhluk hidup untuk mengubah makanan dan minuman menjadi energi.

Morbiditas

Morbiditas: adalah keadaan sakit atau tingkat penyakit dalam suatu populasi.

Mortalitas

Mortalitas: adalah angka kematian atau tingkat kematian dalam suatu populasi.

Non-maleficence

Non-maleficence: adalah prinsip etika dasar (bioetik) yang berarti "tidak berbuat kejahatan" atau "tidak membahayakan".

Neurodegeneratif

Neurodegeneratif: adalah istilah untuk penyakit yang menyebabkan kerusakan atau penurunan fungsi sel saraf (neuron) di otak atau tulang belakang secara bertahap dan progresif.

Okupasi Terapis

Okupasi terapis: adalah profesional kesehatan yang membantu individu dengan gangguan fisik, mental, atau kognitif untuk meningkatkan kemandirian dalam melakukan aktivitas sehari-hari (okupasi), seperti mandi, makan, bekerja, atau belajar.

Oliguria

Oliguria: adalah kondisi penurunan produksi urine yang abnormal, di mana volume urine sangat sedikit.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO): adalah badan kesehatan dunia yang merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan bertanggung jawab untuk mempromosikan kesehatan global. Paliatif Pelayanan kepada pasien yang penyakitnya sudah tidak bereaksi terhadap pengobatan kuratif, atau tidak dapat disembuhkan secara medis (stadium akhir)

Paliatif

Paliatif: adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para profesional kesehatan dalam memberikan perawatan paliatif kepada pasien

Penyakit Terminal

Penyakit terminal: adalah penyakit yang tidak dapat diobati atau disembuhkan yang dapat mengakibatkan kematian pada penderitanya

Perawat

Perawat: adalah suatu profesi yang difokuskan pada perawatan individu, keluarga, dan komunitas dalam mencapai, memelihara, dan menyembuhkan kesehatan yang optimal dan berfungsi.

Perawatan Paliatif

Perawatan paliatif: adalah pendekatan medis yang bertujuan untuk meringankan penderitaan fisik, emosional, spiritual, dan psikologis pasien yang menghadapi penyakit serius, kronis, atau terminal, dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup.

Perspektif

Perspektif: adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya).

Penyakit Progresif

Penyakit progresif: adalah kondisi medis yang gejalanya terus memburuk, berkembang, atau menyebar dari waktu ke waktu, contohnya termasuk penyakit Alzheimer, Parkinson, multiple sclerosis, atau kanker tertentu, yang memerlukan manajemen jangka panjang

Penyakit Komorbid

Penyakit komorbid (komorbiditas): adalah keberadaan satu atau lebih penyakit/kondisi tambahan yang terjadi bersamaan dengan penyakit utama (penyakit primer) pada satu pasien, misalnya, seseorang yang memiliki diabetes (penyakit primer) dan juga menderita hipertensi (komorbid).

Polifarmasi

Polifarmasi: adalah penggunaan banyak obat sekaligus oleh satu pasien secara bersamaan, umumnya merujuk pada penggunaan lima atau lebih jenis obat.

Preferensi

Preferensi: adalah merujuk pada pilihan, keinginan, atau nilai-nilai pribadi pasien mengenai perawatan atau terapi yang mereka terima.

Prognosis

Prognosis: adalah prediksi atau perkiraan tenaga medis mengenai perkembangan penyakit, kemungkinan hasil akhir, serta peluang kesembuhan pasien

Rehabilitasi

Rehabilitasi: adalah serangkaian upaya komprehensif yang dirancang untuk memulihkan, memaksimalkan, atau memperbaiki fungsi fisik, mental, kognitif, atau sosial seseorang setelah mengalami cedera, operasi, atau penyakit kronis.

Studi Observasional

Studi observasional: adalah metode penelitian medis di mana peneliti mengamati, mencatat, dan menganalisis subjek (pasien/populasi) tanpa memberikan intervensi atau mengubah perilaku mereka, tujuannya untuk mempelajari hubungan antara faktor risiko dan penyakit (contoh: studi cohort atau case-control).

Transendensi

Transendensi (self-transcendence): adalah kemampuan seseorang untuk bangkit melampaui keterbatasan fisik atau situasi sulit (penyakit kronis) untuk menemukan makna hidup, kedamaian, atau tujuan yang lebih tinggi, sering kali melibatkan aspek spiritual.

Terapis Okupasi

Terapis Okupasi (OT): adalah tenaga kesehatan profesional yang membantu orang-orang di semua usia untuk berpartisipasi dalam aktivitas sehari-hari (okupasi) yang bermakna bagi mereka.

Teknik Repositioning

Teknik repositioning: adalah metode yang digunakan oleh terapis atau perawat untuk mengubah posisi tubuh pasien (misalnya di tempat tidur atau kursi roda) secara berkala (minimal setiap 2 jam), dimana tujuannya untuk mencegah luka tekan (pressure ulcers), mengurangi nyeri, menjaga keselarasan tubuh (body alignment), dan meningkatkan kenyamanan.

Upaya Preventif

Upaya preventif: adalah langkah-langkah pencegahan yang dilakukan untuk menghindari timbulnya penyakit atau mencegah kondisi penyakit menjadi lebih parah, contohnya termasuk imunisasi, perubahan gaya hidup sehat,

BAB 4

DUKUNGAN KELUARGA DAN *CAREGIVER BURDEN* DALAM KEPERAWATAN GERONTIK

A. Pendahuluan

Indonesia sedang mengalami transisi demografi yang ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia sebagai dampak dari meningkatnya usia harapan hidup dan menurunnya angka kelahiran. Kondisi ini membawa konsekuensi terhadap meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan, khususnya dalam bidang keperawatan gerontik. Lansia seringkali mengalami penurunan fungsi fisik, psikologis, dan sosial yang memerlukan dukungan berkelanjutan, baik dari sistem pelayanan kesehatan maupun dari keluarga sebagai unit terdekat dalam kehidupan individu. Fenomena ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan, khususnya dalam keperawatan gerontik yang berfokus pada kualitas hidup lansia secara holistik (Nasution et al., 2024).

Dalam konteks masyarakat Indonesia, keluarga memegang peranan sentral dalam perawatan lansia. Sistem kekerabatan yang kuat serta nilai budaya yang menjunjung tinggi penghormatan kepada orang tua menjadikan keluarga sebagai penyedia utama perawatan (*informal caregiver*). Namun demikian, perubahan struktur sosial seperti urbanisasi, meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, serta pergeseran dari keluarga besar ke keluarga inti telah mempengaruhi kemampuan keluarga dalam memberikan perawatan optimal bagi lansia (N. Herawati, n.d.).

Caregiver burden merupakan fenomena multidimensional yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Beban ini seringkali tidak disadari namun berdampak signifikan terhadap kualitas hidup caregiver dan lansia (Yustisia et al., 2023). Peran sebagai caregiver tidak hanya melibatkan aspek fisik, tetapi juga emosional, sosial, dan ekonomi. Tanggung jawab yang berkelanjutan ini berpotensi menimbulkan tekanan yang dikenal sebagai *caregiver burden*. Beban ini dapat berdampak pada kesehatan fisik dan mental caregiver serta kualitas perawatan yang diberikan kepada lansia. Oleh karena itu, pemahaman mengenai dukungan keluarga dan caregiver burden menjadi sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup lansia secara holistik (Anisya et al., 2025).

Peran perawat sangat penting dalam memberikan edukasi, asesmen, dan dukungan kepada caregiver. Pendekatan family-centered care menjadi kunci dalam keperawatan gerontik (Tampubolon & Saputra, 2025). Adapun Strategi komunitas seperti posyandu lansia dan dukungan berbasis masyarakat yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan caregiver dan lansia secara berkelanjutan (Rosnah et al., 2024).

B. Konsep Peran Keluarga dalam Keperawatan keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran fundamental dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan anggotanya. Dalam perspektif keperawatan keluarga, keluarga tidak hanya dipandang sebagai kumpulan individu, tetapi sebagai suatu sistem yang saling berinteraksi dan memiliki fungsi tertentu dalam mempertahankan keseimbangan kesehatan. Oleh karena itu, keperawatan keluarga menempatkan keluarga sebagai fokus utama dalam pemberian asuhan keperawatan, baik sebagai penerima pelayanan maupun sebagai mitra aktif dalam proses perawatan (Maryam et al., 2022).

Konsep peran keluarga dalam keperawatan keluarga berakar pada pemahaman bahwa kesehatan individu sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekatnya, terutama keluarga. Keluarga berperan dalam membentuk perilaku kesehatan, memberikan dukungan emosional, serta menjadi pengambil keputusan utama dalam hal kesehatan. Dalam konteks ini, keluarga memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam menjaga kesehatan anggota keluarga yang sehat, tetapi juga dalam merawat anggota keluarga yang sakit atau mengalami keterbatasan, termasuk lansia (Kristanto et al., 2025).

Secara umum, peran keluarga dalam keperawatan keluarga dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa fungsi utama, yaitu fungsi afektif, fungsi sosialisasi, fungsi perawatan kesehatan, fungsi ekonomi, dan fungsi reproduksi. Fungsi afektif berkaitan dengan kemampuan keluarga dalam memberikan kasih sayang, dukungan emosional, dan rasa aman kepada anggotanya. Fungsi ini sangat penting dalam menjaga kesejahteraan psikologis, terutama bagi anggota keluarga yang mengalami penyakit atau kondisi kronis (Maryam et al., 2022).

Fungsi sosialisasi keluarga berperan dalam membentuk nilai, norma, dan perilaku kesehatan individu. Melalui proses interaksi dalam keluarga, anggota keluarga belajar mengenai pola hidup sehat, cara mengelola stres, serta sikap terhadap penyakit dan perawatan. Dalam konteks keperawatan, fungsi ini menjadi penting karena dapat mempengaruhi kepatuhan terhadap pengobatan dan perilaku pencarian pelayanan kesehatan (Putra et al., 2023).

Fungsi perawatan kesehatan merupakan salah satu peran utama keluarga dalam keperawatan keluarga. Keluarga bertanggung jawab dalam mengenali masalah kesehatan, mengambil keputusan terkait tindakan yang diperlukan, memberikan perawatan dasar, serta memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia. Kemampuan keluarga dalam menjalankan fungsi ini sangat menentukan keberhasilan proses perawatan dan pemulihan anggota keluarga yang sakit (Mulia, 2018).

Selain itu, fungsi ekonomi keluarga juga memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan. Ketersediaan sumber daya finansial mempengaruhi kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan kesehatan, seperti pembelian obat, akses ke fasilitas kesehatan, serta pemenuhan nutrisi yang adekuat. Keterbatasan ekonomi dapat menjadi hambatan dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal (T. Herawati et al., 2020).

Dalam praktik keperawatan keluarga, konsep peran keluarga juga berkaitan dengan kemampuan keluarga dalam melakukan *coping* atau adaptasi terhadap masalah kesehatan. Keluarga yang memiliki kemampuan coping yang baik cenderung lebih mampu menghadapi stres dan tekanan yang muncul akibat penyakit atau kondisi tertentu. Sebaliknya, keluarga dengan kemampuan coping yang rendah lebih rentan mengalami disfungsi yang dapat berdampak pada kesehatan seluruh anggota keluarga (Putra et al., 2023).

Peran keluarga juga sangat dipengaruhi oleh struktur dan dinamika keluarga itu sendiri. Perubahan struktur keluarga, seperti pergeseran dari keluarga besar ke keluarga inti, dapat mempengaruhi distribusi peran dan tanggung jawab dalam perawatan. Selain itu, faktor seperti komunikasi, pola hubungan, serta nilai-nilai yang dianut keluarga turut menentukan efektivitas peran yang dijalankan (Tampubolon & Saputra, 2025).

Dalam konteks keperawatan gerontik, peran keluarga menjadi semakin penting karena lansia seringkali mengalami penurunan fungsi yang memerlukan bantuan dalam aktivitas sehari-hari. Keluarga menjadi caregiver utama yang bertanggung jawab dalam memberikan perawatan jangka panjang. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai konsep peran keluarga menjadi dasar dalam merancang intervensi keperawatan yang efektif dan berkelanjutan (Kristanto et al., 2025).

Perawat memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan keluarga dalam menjalankan perannya, serta memberikan intervensi yang sesuai untuk meningkatkan kapasitas keluarga. Pendekatan yang digunakan harus bersifat holistik dan berfokus pada pemberdayaan keluarga, sehingga keluarga mampu menjalankan perannya secara mandiri dan optimal dalam menjaga kesehatan anggotanya (Putra et al., 2023).

Secara keseluruhan, konsep peran keluarga dalam keperawatan keluarga menegaskan bahwa keluarga merupakan komponen penting dalam sistem pelayanan kesehatan. Keterlibatan aktif keluarga dalam proses perawatan tidak hanya meningkatkan kualitas asuhan, tetapi juga mendukung terciptanya kesehatan yang berkelanjutan bagi seluruh anggota keluarga (Kristanto et al., 2025).

C. Konsep *Caregiver Burden* dalam Perawatan Lansia

Konsep *caregiver burden* merupakan salah satu isu sentral dalam keperawatan gerontik yang semakin mendapat perhatian seiring dengan meningkatnya jumlah lansia yang membutuhkan perawatan jangka panjang. Istilah *caregiver burden* merujuk pada berbagai bentuk tekanan yang dialami oleh individu yang merawat anggota keluarga dengan kondisi ketergantungan, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Dalam praktiknya, beban ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan caregiver, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas perawatan yang diberikan kepada lansia (Retnani et al., 2025).

Secara konseptual, *caregiver burden* dapat dibedakan menjadi dua dimensi utama, yaitu beban objektif (*objective burden*) dan beban subjektif (*subjective burden*). Beban objektif mencakup tuntutan nyata yang harus dipenuhi oleh caregiver, seperti waktu yang dihabiskan untuk merawat, aktivitas fisik yang dilakukan, serta biaya yang dikeluarkan. Sementara itu, beban subjektif berkaitan dengan persepsi individu terhadap pengalaman merawat, termasuk perasaan stres, kelelahan, dan tekanan emosional yang dirasakan (Yustisia et al., 2023).

Dalam konteks perawatan lansia, beban objektif sering kali terlihat dalam aktivitas sehari-hari yang harus dilakukan secara berulang, seperti membantu makan, mandi, berpakaian, serta mobilisasi. Aktivitas ini menjadi lebih kompleks ketika lansia mengalami keterbatasan fisik atau penyakit kronis yang memerlukan perhatian khusus. Intensitas dan frekuensi aktivitas perawatan yang tinggi dapat menyebabkan kelelahan fisik yang signifikan pada caregiver (Andas, 2025).

Di sisi lain, beban subjektif sering kali lebih sulit diidentifikasi karena berkaitan dengan kondisi psikologis caregiver. Perasaan cemas, frustrasi, bahkan depresi dapat muncul sebagai respons terhadap tekanan yang dialami. Dalam beberapa kasus, caregiver juga mengalami konflik emosional, seperti rasa bersalah ketika merasa lelah atau keinginan untuk beristirahat. Kondisi ini menunjukkan bahwa caregiver burden tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh aspek emosional dan psikologis (Yustisia et al., 2023).

Selain itu, caregiver burden juga memiliki dimensi sosial yang tidak kalah penting. Keterbatasan waktu dan energi sering kali membuat caregiver mengurangi

interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Isolasi sosial yang terjadi dapat memperburuk kondisi psikologis dan menurunkan kualitas hidup caregiver. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memicu perasaan kesepian dan kehilangan dukungan sosial yang sangat dibutuhkan (Retnani et al., 2025).

Aspek ekonomi juga menjadi bagian integral dari konsep caregiver burden. Biaya yang dikeluarkan untuk perawatan lansia, seperti pembelian obat, alat kesehatan, serta kebutuhan nutrisi khusus, dapat menjadi beban finansial yang signifikan bagi keluarga. Kondisi ini semakin berat jika caregiver harus mengurangi atau bahkan menghentikan aktivitas pekerjaan untuk fokus pada perawatan lansia (Andas, 2025).

Dalam konteks budaya Indonesia, caregiver burden sering kali tidak diungkapkan secara terbuka. Nilai budaya yang menekankan kewajiban anak untuk merawat orang tua dapat membuat caregiver merasa bahwa beban yang dialami adalah sesuatu yang harus diterima tanpa keluhan. Hal ini menyebabkan caregiver cenderung menekan perasaan negatif dan tidak mencari bantuan, sehingga risiko gangguan kesehatan mental menjadi lebih tinggi (Yustisia et al., 2023).

Perkembangan kondisi lansia juga berpengaruh terhadap dinamika caregiver burden. Pada tahap awal, caregiver mungkin masih mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan perawatan. Namun, seiring dengan memburuknya kondisi lansia, tuntutan tersebut meningkat dan dapat menyebabkan akumulasi beban yang semakin berat. Proses ini seringkali terjadi secara bertahap dan tidak disadari oleh caregiver (Retnani et al., 2025).

Dalam praktik keperawatan, pengukuran caregiver burden menjadi penting untuk mengetahui tingkat beban yang dialami. Instrumen seperti *Zarit Burden Interview* sering digunakan untuk menilai dimensi fisik, emosional, dan sosial dari caregiver burden. Hasil pengukuran ini dapat menjadi dasar dalam merancang intervensi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan caregiver (Yustisia et al., 2023).

Secara keseluruhan, konsep caregiver burden dalam perawatan lansia merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional. Beban yang dialami caregiver tidak hanya berasal dari tuntutan perawatan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor individu, keluarga, dan lingkungan. Oleh karena itu, pendekatan dalam memahami dan mengatasi caregiver burden harus bersifat holistik dan berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai pihak dalam sistem pelayanan kesehatan (Retnani et al., 2025).

D. Faktor yang Mempengaruhi *Caregiver Burden*

Caregiver burden merupakan fenomena kompleks yang tidak muncul secara tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Dalam konteks keperawatan gerontik, pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi beban caregiver menjadi sangat penting, karena dapat membantu tenaga kesehatan, khususnya perawat, dalam merancang intervensi yang tepat dan berkelanjutan. Beban yang dialami caregiver tidak hanya ditentukan oleh kondisi lansia, tetapi juga oleh karakteristik caregiver, dinamika keluarga, serta lingkungan sosial yang melingkupinya (Anisya et al., 2025).

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi caregiver burden adalah kondisi kesehatan dan tingkat ketergantungan lansia. Lansia dengan penyakit kronis, disabilitas fisik, atau gangguan kognitif seperti demensia memerlukan perawatan yang lebih intensif dan berkelanjutan. Tingginya kebutuhan bantuan dalam aktivitas sehari-hari (*activities of daily living*) meningkatkan tuntutan fisik dan emosional bagi caregiver. Semakin tinggi tingkat ketergantungan lansia, semakin besar pula beban yang dirasakan oleh caregiver (Yustisia et al., 2023).

Selain itu, durasi dan intensitas perawatan juga berperan signifikan dalam menentukan tingkat caregiver burden. Caregiver yang merawat lansia dalam jangka waktu lama tanpa jeda cenderung mengalami kelelahan fisik dan mental yang lebih tinggi. Intensitas perawatan yang terus-menerus, terutama pada lansia dengan kondisi kronis atau terminal, dapat menyebabkan akumulasi stres yang berdampak pada kesehatan caregiver (Retnani et al., 2025).

Karakteristik individu caregiver juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi persepsi beban. Usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status pekerjaan, serta kondisi kesehatan caregiver dapat menentukan kemampuan dalam menghadapi tuntutan perawatan. Misalnya, caregiver dengan usia lebih tua atau memiliki penyakit penyerta cenderung lebih rentan mengalami kelelahan. Demikian pula, caregiver yang memiliki tanggung jawab ganda, seperti bekerja atau mengurus keluarga inti, akan menghadapi tekanan yang lebih besar (Pitaloka, 2018).

Faktor hubungan emosional antara caregiver dan lansia juga memiliki pengaruh yang signifikan. Hubungan yang dekat dan penuh kasih sayang dapat menjadi sumber motivasi dalam merawat lansia, namun dalam kondisi tertentu juga dapat meningkatkan tekanan emosional, terutama ketika caregiver menyaksikan penurunan kondisi kesehatan lansia secara bertahap. Perasaan sedih, cemas, dan kehilangan seringkali muncul dan memperberat beban psikologis caregiver (Mulia, 2018)).

Selanjutnya, dukungan sosial yang tersedia menjadi faktor protektif yang sangat penting. Caregiver yang memiliki dukungan dari anggota keluarga lain, teman, atau komunitas cenderung mampu mengatasi stres dengan lebih baik dibandingkan dengan mereka yang merawat secara mandiri. Dukungan sosial dapat berupa bantuan langsung, dukungan emosional, maupun akses terhadap informasi dan layanan kesehatan. Ketidadaan dukungan sosial seringkali menjadi salah satu penyebab utama tingginya caregiver burden (Retnani et al., 2025).

Kondisi ekonomi keluarga juga berkontribusi terhadap tingkat beban yang dialami caregiver. Biaya perawatan lansia, termasuk pengobatan, alat kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari, dapat menjadi tekanan finansial yang signifikan, terutama bagi keluarga dengan sumber daya terbatas. Ketidakstabilan ekonomi dapat meningkatkan stres dan mempengaruhi kemampuan caregiver dalam menyediakan perawatan yang optimal (Kristanto et al., 2025).

Dalam konteks Indonesia, nilai budaya dan norma sosial turut mempengaruhi caregiver burden. Budaya yang menekankan kewajiban anak untuk merawat orang tua dapat menjadi motivasi, namun juga dapat menjadi sumber tekanan. Caregiver mungkin merasa tidak memiliki pilihan lain selain menjalankan peran tersebut, meskipun dalam kondisi yang tidak ideal. Norma ini seringkali membuat caregiver enggan mencari bantuan karena dianggap sebagai bentuk ketidakmampuan atau kurangnya bakti (Andas, 2025).

Selain itu, akses terhadap layanan kesehatan dan sumber daya pendukung juga menjadi faktor yang menentukan. Keterbatasan fasilitas kesehatan, terutama di daerah tertentu, membuat keluarga harus mengandalkan kemampuan sendiri dalam merawat lansia. Kurangnya akses terhadap layanan home care, rehabilitasi, atau konseling dapat memperburuk beban caregiver. Oleh karena itu, penguatan sistem pelayanan kesehatan berbasis komunitas menjadi sangat penting (T. Herawati et al., 2020).

Perkembangan teknologi sebenarnya dapat menjadi peluang dalam mengurangi beban caregiver, namun keterbatasan literasi digital masih menjadi tantangan. Tidak semua caregiver mampu memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan informasi atau dukungan. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi berbasis teknologi perlu disertai dengan edukasi yang memadai agar dapat dimanfaatkan secara optimal (Andas, 2025).

Secara keseluruhan, faktor-faktor yang mempengaruhi caregiver burden menunjukkan bahwa beban tersebut merupakan hasil dari interaksi berbagai aspek yang kompleks. Oleh karena itu, pendekatan dalam mengatasi caregiver burden tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus bersifat holistik dengan mempertimbangkan kondisi individu, keluarga, dan lingkungan. Pemahaman yang

komprehensif terhadap faktor-faktor ini menjadi dasar dalam merancang intervensi keperawatan yang efektif dan berkelanjutan (Yustisia et al., 2023).

E. Dukungan Keluarga Sebagai Strategi Mengurangi *Caregiver Burden*

Dukungan keluarga merupakan salah satu komponen kunci dalam upaya mengurangi *caregiver burden* pada perawatan lansia. Dalam konteks keperawatan gerontik, keluarga tidak hanya berperan sebagai penyedia perawatan utama, tetapi juga sebagai sumber dukungan yang dapat memperkuat kapasitas caregiver dalam menghadapi tuntutan perawatan jangka panjang. Beban yang dialami caregiver sering kali bersifat multidimensional, mencakup aspek fisik, emosional, sosial, dan ekonomi, sehingga memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berbasis sistem keluarga untuk mengatasinya (Kristanto et al., 2025).

Secara konseptual, dukungan keluarga dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk, yaitu dukungan emosional, instrumental, informasional, dan spiritual. Keempat bentuk dukungan ini saling melengkapi dan berperan dalam meningkatkan ketahanan caregiver. Dukungan emosional, misalnya, memberikan rasa dihargai, dipahami, dan tidak sendirian dalam menjalankan peran sebagai caregiver. Perasaan ini sangat penting dalam menjaga stabilitas psikologis dan mencegah terjadinya stres berkepanjangan (Maryam et al., 2022).

Dukungan instrumental merupakan bentuk bantuan nyata yang diberikan oleh anggota keluarga lain, seperti membantu aktivitas perawatan lansia, pekerjaan rumah tangga, atau kebutuhan logistik lainnya. Dalam praktiknya, pembagian tugas yang adil di antara anggota keluarga dapat secara signifikan mengurangi beban fisik caregiver utama. Kondisi ini menunjukkan bahwa perawatan lansia seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya dibebankan pada satu individu (Putra et al., 2023).

Selain itu, dukungan informasional juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan caregiver dalam memberikan perawatan. Informasi yang tepat mengenai kondisi kesehatan lansia, cara perawatan yang benar, serta akses terhadap layanan kesehatan dapat meningkatkan kepercayaan diri caregiver. Dalam hal ini, keluarga dapat berfungsi sebagai sumber informasi maupun sebagai fasilitator dalam mencari informasi yang relevan (Tampubolon & Saputra, 2025).

Dukungan spiritual menjadi dimensi yang tidak kalah penting, terutama dalam konteks budaya Indonesia yang religius. Nilai-nilai spiritual dan keagamaan seringkali menjadi sumber kekuatan bagi caregiver dalam menghadapi tekanan perawatan. Keyakinan bahwa merawat orang tua merupakan bentuk ibadah atau

pengabdian dapat memberikan makna positif terhadap peran caregiver, sehingga membantu dalam mengurangi persepsi beban yang dirasakan (Yustisia et al., 2023).

Dalam praktik keperawatan komunitas, dukungan keluarga juga berkaitan erat dengan konsep *family resilience* atau ketahanan keluarga. Keluarga yang memiliki komunikasi yang baik, hubungan yang harmonis, serta kemampuan adaptasi yang tinggi cenderung lebih mampu menghadapi tantangan dalam merawat lansia. Ketahanan keluarga ini menjadi faktor protektif yang dapat menurunkan risiko caregiver burden secara signifikan (N. Herawati, n.d.).

Namun demikian, tidak semua keluarga memiliki sistem dukungan yang optimal. Dalam beberapa kasus, caregiver justru menghadapi konflik internal dalam keluarga, seperti ketidakseimbangan pembagian peran atau kurangnya keterlibatan anggota keluarga lain. Kondisi ini dapat memperburuk beban yang dialami caregiver dan berdampak pada kualitas perawatan lansia. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang dapat memperkuat fungsi keluarga sebagai sistem pendukung (Kristanto et al., 2025).

Perawat memiliki peran penting dalam memfasilitasi dukungan keluarga melalui pendekatan *family-centered care*. Melalui pendekatan ini, perawat dapat membantu keluarga dalam mengidentifikasi peran masing-masing anggota, meningkatkan komunikasi, serta mendorong keterlibatan aktif dalam perawatan lansia. Intervensi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas perawatan, tetapi juga untuk menjaga kesejahteraan caregiver (Putra et al., 2023).

Selain itu, penguatan dukungan keluarga juga dapat dilakukan melalui pendekatan berbasis komunitas. Keterlibatan kader kesehatan, kelompok masyarakat, serta organisasi sosial dapat memperluas jaringan dukungan bagi caregiver. Dalam konteks ini, keluarga tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari sistem sosial yang lebih luas dalam mendukung perawatan lansia (Retnani et al., 2025).

Perkembangan teknologi juga membuka peluang baru dalam memperkuat dukungan keluarga. Penggunaan media komunikasi digital, seperti grup pesan instan, dapat menjadi sarana untuk berbagi informasi, pengalaman, serta dukungan emosional antar anggota keluarga maupun caregiver lainnya. Meskipun sederhana, pendekatan ini dapat membantu mengurangi perasaan isolasi dan meningkatkan akses terhadap dukungan (Tampubolon & Saputra, 2025).

Penting untuk dipahami bahwa dukungan keluarga bukan hanya tentang kuantitas bantuan yang diberikan, tetapi juga kualitas interaksi yang terjadi. Dukungan yang diberikan secara tulus, empatik, dan berkelanjutan akan memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan bantuan yang bersifat sporadis. Oleh karena

itu, penguatan nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian dalam keluarga menjadi aspek yang sangat penting (Kristanto et al., 2025).

Secara keseluruhan, dukungan keluarga merupakan strategi yang efektif dalam mengurangi caregiver burden dan meningkatkan kualitas hidup caregiver serta lansia. Pendekatan yang mengintegrasikan aspek emosional, instrumental, informasional, dan spiritual akan memberikan hasil yang lebih optimal. Dengan dukungan yang memadai, caregiver tidak hanya mampu menjalankan perannya dengan baik, tetapi juga tetap menjaga kesejahteraan dirinya secara menyeluruh (T. Herawati et al., 2020).

F. Peran Perawat dalam Mendukung Keluarga dan *Caregiver*

Perawat memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendukung keluarga dan *caregiver* dalam konteks keperawatan gerontik. Dalam praktik pelayanan kesehatan modern, perawat tidak hanya berfokus pada kondisi klinis lansia sebagai individu, tetapi juga harus mampu melihat keluarga sebagai bagian integral dari sistem perawatan. Pendekatan ini dikenal sebagai *family-centered care*, yaitu pendekatan yang menempatkan keluarga sebagai mitra aktif dalam proses asuhan keperawatan. Keterlibatan keluarga dalam perawatan lansia menjadi sangat penting karena sebagian besar kebutuhan harian lansia dipenuhi di lingkungan rumah, sehingga kualitas dukungan keluarga akan sangat mempengaruhi kualitas hidup lansia secara keseluruhan (T. Herawati et al., 2020).

Dalam praktiknya, perawat berperan sebagai edukator bagi keluarga yang merawat lansia. Banyak anggota keluarga yang menjalankan peran sebagai *caregiver* tanpa memiliki pengetahuan yang cukup mengenai proses penuaan maupun perawatan penyakit kronis yang dialami lansia. Kondisi tersebut sering menyebabkan keluarga merasa cemas dan tidak percaya diri dalam memberikan perawatan. Melalui pendidikan kesehatan, perawat dapat membantu keluarga memahami perubahan fisiologis pada lansia, tanda bahaya yang perlu diwaspadai, penggunaan obat yang benar, serta teknik perawatan dasar yang aman. Edukasi yang diberikan secara berkelanjutan terbukti dapat meningkatkan kemampuan keluarga dalam menjalankan perawatan secara mandiri di rumah (Mulia, 2018).

Selain sebagai pendidik, perawat juga berperan sebagai konselor yang memberikan dukungan psikologis kepada caregiver. Peran merawat lansia sering kali menimbulkan tekanan emosional yang tidak ringan. Caregiver dapat mengalami stres, kelelahan, rasa bersalah, bahkan depresi akibat tuntutan perawatan jangka panjang. Dalam kondisi seperti ini, perawat perlu hadir sebagai tenaga profesional yang mampu mendengarkan, memahami, dan membantu caregiver menemukan

cara yang sehat dalam menghadapi tekanan tersebut. Dukungan emosional dari perawat dapat memberikan rasa dihargai bagi caregiver sehingga mereka tidak merasa menjalani beban perawatan seorang diri (Yustisia et al., 2023).

Perawat juga memiliki peran penting dalam melakukan asesmen terhadap kondisi caregiver. Selama ini, perhatian dalam pelayanan kesehatan sering kali lebih banyak tertuju kepada pasien lansia, sementara kondisi caregiver kurang mendapat perhatian. Padahal, caregiver yang mengalami kelelahan fisik dan mental dapat mempengaruhi kualitas perawatan yang diberikan kepada lansia. Oleh karena itu, perawat perlu menilai kondisi fisik, emosional, sosial, dan spiritual caregiver secara berkala. Instrumen seperti *Zarit Burden Interview* dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat beban caregiver sehingga intervensi yang sesuai dapat direncanakan sejak dini (Pitaloka, 2018).

Dalam konteks komunitas, perawat berperan sebagai fasilitator yang membantu keluarga mengakses sumber daya kesehatan yang tersedia. Banyak keluarga tidak mengetahui adanya layanan yang dapat membantu mereka dalam merawat lansia, seperti posyandu lansia, pelayanan home care, rehabilitasi, maupun kelompok pendukung caregiver. Perawat komunitas memiliki tanggung jawab untuk menghubungkan keluarga dengan layanan tersebut agar caregiver memperoleh dukungan yang lebih luas. Dengan demikian, perawat tidak hanya berperan pada tingkat individual, tetapi juga sebagai penghubung antara keluarga dan sistem pelayanan kesehatan yang lebih besar (Kristanto et al., 2025).

Peran advokasi juga merupakan bagian penting dari fungsi perawat dalam mendukung keluarga. Dalam beberapa situasi, keluarga mungkin menghadapi hambatan dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh lansia, baik karena keterbatasan ekonomi, kurangnya akses layanan, maupun kurangnya pemahaman terhadap hak pasien. Dalam kondisi ini, perawat berperan sebagai advokat yang memperjuangkan kebutuhan lansia dan caregiver agar mendapatkan pelayanan yang layak. Advokasi yang dilakukan perawat dapat berupa membantu keluarga memahami prosedur pelayanan, menjelaskan pilihan terapi, hingga mendorong kebijakan yang lebih ramah terhadap kebutuhan lansia dan keluarga (Putra et al., 2023).

Perawat juga memiliki tanggung jawab dalam membantu keluarga membangun strategi koping yang adaptif. Tidak semua caregiver mampu menyesuaikan diri dengan perubahan peran yang terjadi ketika harus merawat anggota keluarga lanjut usia. Sebagian caregiver mengalami konflik peran, terutama jika mereka juga memiliki tanggung jawab pekerjaan atau mengurus anggota keluarga lain. Dalam kondisi seperti ini, perawat dapat membantu keluarga mengembangkan mekanisme koping yang sehat, seperti manajemen waktu, pembagian tugas antaranggota

keluarga, serta pentingnya *self-care* bagi caregiver. Pendekatan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan lansia dan kesejahteraan caregiver (Retnani et al., 2025).

Dalam pelayanan gerontik, perawat juga berperan dalam meningkatkan pemberdayaan keluarga. Pemberdayaan keluarga berarti membantu keluarga agar memiliki kemampuan untuk mengenali masalah, mengambil keputusan, dan melaksanakan tindakan perawatan secara mandiri. Keluarga yang diberdayakan akan memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi dalam merawat lansia, sehingga ketergantungan terhadap tenaga kesehatan dapat dikurangi tanpa mengurangi kualitas perawatan. Pemberdayaan ini menjadi salah satu pendekatan penting dalam pelayanan kesehatan primer yang berorientasi pada keberlanjutan perawatan di rumah (Nasution et al., 2024).

Lebih jauh lagi, perawat memiliki peran penting dalam membangun hubungan terapeutik dengan keluarga. Hubungan terapeutik yang baik ditandai dengan komunikasi yang terbuka, saling percaya, dan saling menghormati antara perawat dan keluarga. Melalui hubungan yang positif, keluarga akan lebih nyaman menyampaikan kesulitan yang mereka hadapi dalam merawat lansia. Kondisi ini memungkinkan perawat untuk memberikan intervensi yang lebih tepat sesuai kebutuhan nyata caregiver. Hubungan terapeutik yang baik juga dapat meningkatkan kepatuhan keluarga terhadap anjuran kesehatan yang diberikan (Mulia, 2018).

Pada akhirnya, peran perawat dalam mendukung keluarga dan caregiver bukan hanya sebagai pelaksana tindakan keperawatan, tetapi juga sebagai pendidik, konselor, fasilitator, advokat, dan pemberdaya keluarga. Kompleksitas kebutuhan lansia menuntut perawat untuk memiliki kemampuan interpersonal dan profesional yang tinggi dalam bekerja sama dengan keluarga. Dengan dukungan yang tepat dari perawat, keluarga dapat menjalankan peran caregiving dengan lebih efektif, sehingga kesejahteraan lansia maupun caregiver dapat terjaga secara optimal dalam menghadapi tantangan penuaan populasi di Indonesia (T. Herawati et al., 2020).

G. Strategi Adaptif dalam Mengatasi *Caregiver Burden*

Upaya menurunkan *caregiver burden* merupakan bagian integral dalam praktik keperawatan gerontik, terutama dalam konteks perawatan berbasis keluarga. Beban yang dialami caregiver tidak hanya berdampak pada individu yang merawat, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kualitas asuhan yang diberikan kepada lansia. Oleh karena itu, diperlukan strategi intervensi keperawatan yang komprehensif,

berkelanjutan, dan kontekstual, dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi keluarga di Indonesia (N. Herawati, n.d.).

Salah satu strategi utama adalah intervensi edukatif yang terstruktur. Edukasi kesehatan kepada caregiver terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri dalam merawat lansia. Materi edukasi meliputi pemahaman tentang penyakit kronis, teknik perawatan dasar, manajemen obat, serta pencegahan komplikasi. Edukasi yang diberikan secara berkelanjutan dan berbasis kebutuhan individu caregiver akan lebih efektif dibandingkan pendekatan satu kali pertemuan (Nasution et al., 2024).

Selain edukasi, intervensi psikososial juga memiliki peran penting dalam mengurangi beban caregiver. Pendekatan ini mencakup konseling, terapi suportif, serta penguatan mekanisme koping. Caregiver yang mendapatkan dukungan psikologis cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan kemampuan adaptasi yang lebih baik terhadap tuntutan perawatan. Intervensi ini menjadi sangat penting terutama bagi caregiver yang merawat lansia dengan kondisi kronis atau gangguan kognitif (Mulia, 2018).

Strategi berikutnya adalah pembentukan dan penguatan kelompok dukungan (*support group*). Kelompok ini memberikan ruang bagi caregiver untuk berbagi pengalaman, informasi, dan strategi coping dengan individu lain yang memiliki kondisi serupa. Interaksi dalam kelompok dukungan dapat mengurangi perasaan isolasi sosial serta meningkatkan rasa memiliki dan dukungan emosional. Dalam konteks komunitas, kelompok ini dapat difasilitasi oleh perawat melalui kegiatan di puskesmas atau posyandu lansia (Aulia & Putrikita, 2024).

Intervensi respite care atau layanan istirahat sementara juga menjadi strategi penting dalam menurunkan caregiver burden. Layanan ini memberikan kesempatan bagi caregiver untuk beristirahat sejenak dari tanggung jawab perawatan tanpa mengabaikan kebutuhan lansia. Meskipun implementasi *respite care* di Indonesia masih terbatas, konsep ini dapat diadaptasi secara sederhana melalui dukungan keluarga besar atau komunitas yang berbagi peran dalam perawatan lansia (T. Herawati et al., 2020).

Selanjutnya, pendekatan berbasis keluarga (*family-centered intervention*) perlu dioptimalkan. Dalam pendekatan ini, perawatan lansia tidak hanya dibebankan pada satu individu, tetapi didistribusikan secara proporsional di antara anggota keluarga. Perawat berperan dalam memfasilitasi komunikasi keluarga, membantu pembagian tugas, serta mendorong keterlibatan aktif seluruh anggota keluarga dalam proses perawatan. Pendekatan ini terbukti efektif dalam mengurangi beban individu caregiver utama (Pitaloka, 2018).

Intervensi lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan literasi kesehatan caregiver. Literasi kesehatan yang baik memungkinkan caregiver untuk memahami informasi medis, mengambil keputusan yang tepat, serta mengakses layanan kesehatan secara optimal. Perawat dapat memfasilitasi hal ini melalui pendidikan kesehatan yang sistematis, penggunaan media edukasi, serta pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi kesehatan atau grup edukasi berbasis pesan instan (Nasution et al., 2024).

Dalam konteks pelayanan kesehatan primer, penguatan peran puskesmas dan layanan komunitas menjadi strategi yang sangat relevan. Program seperti posyandu lansia dapat dikembangkan tidak hanya sebagai tempat pemantauan kesehatan lansia, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan dukungan bagi caregiver. Keterlibatan kader kesehatan dan tokoh masyarakat dapat memperluas jangkauan intervensi serta memperkuat dukungan sosial di tingkat komunitas (Kasim & Rosnah, 2025).

Selain itu, intervensi berbasis teknologi mulai menjadi alternatif yang menjanjikan dalam mendukung caregiver. Penggunaan telehealth, konsultasi daring, serta platform edukasi digital memungkinkan caregiver untuk mendapatkan informasi dan dukungan tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan. Meskipun masih menghadapi tantangan dalam akses dan literasi digital, pendekatan ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan di masa depan (Andas, 2025).

Tidak kalah penting adalah penerapan strategi self-care bagi caregiver. Perawat perlu menekankan bahwa menjaga kesehatan diri sendiri merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai caregiver. Aktivitas seperti olahraga ringan, manajemen stres, istirahat yang cukup, serta menjaga hubungan sosial perlu didorong sebagai bagian dari intervensi keperawatan. Caregiver yang sehat secara fisik dan mental akan lebih mampu memberikan perawatan yang optimal (Mulia, 2018).

Secara keseluruhan, strategi intervensi keperawatan dalam menurunkan caregiver burden harus dilakukan secara multidimensional dan terintegrasi. Kombinasi antara edukasi, dukungan psikososial, pemberdayaan keluarga, serta penguatan sistem pelayanan kesehatan menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi permasalahan ini. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan caregiver tidak hanya mampu menjalankan perannya dengan baik, tetapi juga tetap memiliki kualitas hidup yang optimal (Yustisia et al., 2023).

H. Penutup

Peningkatan jumlah lansia menuntut penguatan sistem dukungan bagi caregiver. Kolaborasi antara keluarga, tenaga kesehatan, dan masyarakat menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas hidup lansia.

Fenomena penuaan populasi di Indonesia menuntut adanya adaptasi dalam sistem pelayanan kesehatan, khususnya dalam keperawatan gerontik. Keluarga sebagai caregiver utama memiliki peran yang sangat penting, namun juga menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan.

Caregiver burden merupakan realitas yang seringkali tersembunyi, tetapi memiliki dampak signifikan terhadap kualitas hidup caregiver dan lansia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam mengatasi permasalahan ini, melalui penguatan dukungan keluarga, peningkatan peran tenaga kesehatan, serta pengembangan sistem pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan lansia dan caregiver.

Dengan pendekatan yang holistik dan kontekstual, diharapkan kualitas hidup lansia dapat meningkat tanpa mengabaikan kesejahteraan caregiver sebagai pilar utama dalam perawatan.

Referensi

- Andas, A. M. (2025). *Buku Ajar Masalah Kesehatan dan Sistem Perawatan Lansia di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Anisya, Z., Zahra, M., Marianti, L., Najib, M. J., & Naufal, M. S. (2025). Analisis Peran Keluarga Sebagai Caregiver Lansia Dengan Dimensia. *CONS-IEDU*, 5(2), 325–338.
- Aulia, R., & Putrikita, K. A. (2024). Support Group dalam Menurunkan Tingkat Stres pada Caregiver Skizofrenia. *Psychopolytan: Jurnal Psikologi*, 8(1), 60–72.
- Herawati, N. (n.d.). *Harmoni dalam Perbedaan: Pemberdayaan Psikologis Keluarga dengan Anggota Berkebutuhan Khusus dan Lansia*. Penerbit Adab.
- Herawati, T., Krisnatuti, D., Pujihasvuty, R., & Latifah, E. W. (2020). Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan fungsi keluarga di Indonesia. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 13(3), 213–227.
- Kasim, S. S., & Rosnah, R. (2025). Optimalisasi Layanan Posyandu Lanjut Usia (Lansia) Berbasis Edukasi Kesehatan: Studi di Kelurahan Kasupute Kabupaten Konawe. *PAMARENDA: Public Administration and Government Journal*, 5(1), 156–164.
- Kristanto, B., La Ramba, H., Orizani, C. M., Handayani, P. A., Ramadhani, D. Y., & Sovianti, V. (2025). *Asuhan Keperawatan Keluarga dan Komunitas: Menyongsong Tantangan Kesehatan Masa Kini*. Penerbit NEM.
- Maryam, S., Mahyiddin, Z., & Faudiah, N. (2022). *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*. Syiah Kuala University Press.
- Mulia, M. (2018). Pelaksanaan Tugas Keluarga Di Bidang Kesehatan: Mengambil Keputusan Mengenai Tindakan Kesehatan Yang Tepat Terhadap Kejadian Hipertensi Pada Lansia Di Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Kesehatan Panca Bhakti Lampung*, 6(2), 101–107.
- Nasution, F., Rambe, I. M., Ramadani, S. V., Tanjung, N. A., Anjani, N., & Fanani, W. A. (2024). Batasan Usia Dewasa Akhir (Lansia) dan Keadaan Penduduk Lansia di Indonesia. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 1972–1980.
- Pitaloka, D. (2018). *Keperawatan Lansia Komprehensif Dengan Pendekatan Teori Family Centered Nursing Dan Functional Consequences Dalam Pencegahan Pengabaian Lansia Dalam Keluarga*. Universitas Airlangga.
- Putra, I. G. Y., Suardana, I. W., Nurlela, L., Sya'diyah, H., Achjar, K. A. H., Januarti, L. F., Silvanasari, I. A., Sari, N. M. C. C., Putra, I. K. A. D., & Rachmawati, D. S. (2023). *Keperawatan keluarga: Teori & studi kasus*. PT. Sonpedia

Publishing Indonesia.

- Retnani, C. T., Kep, M., Arneliwati, N., Kep, M., & Wilda, L. O. (2025). *Keluarga Sebagai Caregiver Dan Masalah Kesehatan Lansia*. Nuansa Fajar Cemerlang.
- Rosnah, R., Kasim, S. S., & Faturrahman, T. (2024). Peran Posyandu Lansia dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup lanjut usia: Studi di Desa Lakalamba, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat. *Kisi Berkelanjutan: Sains Medis Dan Kesehatan*, 1(4).
- Tampubolon, S. D. L., & Saputra, C. (2025). Asuhan Keperawatan Keluarga dengan Penerapan Peer Group Support Berbasis Family Centered Nursing terhadap Kualitas Hidup Keluarga Lansia dengan Masalah Keperawatan Ketidakefektifan Manajemen Kesehatan Keluarga di Desa Sari Galuh. *Medic Nutricia: Journal Ilmu Kesehatan*, 18(2), 111–120.
- Yustisia, N., Aprilatutini, T., & Utama, T. A. (2023). *Family Burden pada Lansia dengan Penyakit Kronis*. Penerbit NEM.

BAB 5

MODEL PELAYANAN GERONTIK BERBASIS KOMUNITAS

A. Pendahuluan

Peningkatan jumlah penduduk lansia merupakan fenomena global yang terjadi di hampir seluruh negara. Kemajuan di bidang kesehatan, peningkatan kesejahteraan, serta perbaikan kondisi sosial telah menyebabkan meningkatnya angka harapan hidup. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya proporsi populasi lansia dalam struktur demografi masyarakat. Perubahan demografi tersebut membawa konsekuensi terhadap meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi lansia.

Lansia sering mengalami berbagai perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang dapat memengaruhi kualitas hidup mereka. Selain itu, lansia juga memiliki risiko lebih tinggi terhadap penyakit kronis, penurunan fungsi, serta masalah kesehatan mental. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan bagi lansia dilakukan secara komprehensif dengan penekanan pada upaya pemeliharaan fungsi, pencegahan disabilitas, serta peningkatan kualitas hidup menjadi sangat penting.

Salah satu pendekatan yang banyak dikembangkan adalah pelayanan gerontik berbasis komunitas, yaitu sistem pelayanan yang menyediakan dukungan kesehatan dan sosial bagi lansia di lingkungan tempat tinggal mereka. Pendekatan ini menekankan pelayanan yang terintegrasi, mudah diakses, dan melibatkan berbagai pihak seperti keluarga, kader, tenaga kesehatan, serta masyarakat dalam mendukung kesejahteraan lansia.

Bab ini membahas berbagai model pelayanan gerontik berbasis komunitas yang diterapkan di berbagai negara. Pembahasan mencakup konsep dasar pelayanan gerontik komunitas serta beberapa model pelayanan yang berkembang secara global, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai pendekatan pelayanan lansia yang efektif dan potensi penerapannya dalam pengembangan pelayanan gerontik di Indonesia.

B. Konsep Pelayanan Gerontik Berbasis Komunitas

1. Pengertian Pelayanan Gerontik Berbasis Komunitas

Pelayanan gerontik berbasis komunitas merupakan pendekatan pelayanan kesehatan yang menekankan penyediaan layanan bagi lansia di lingkungan tempat

tinggal mereka dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia melalui pelayanan kesehatan yang komprehensif, berkelanjutan, serta berorientasi pada kebutuhan individu lansia dalam konteks sosial dan lingkungan tempat mereka hidup (World Health Organization [WHO], 2017; Potter et al., 2024). Dalam pendekatan ini, pelayanan tidak hanya berfokus pada penanganan penyakit, tetapi juga pada upaya mempertahankan fungsi, kemandirian, serta kesejahteraan lansia secara menyeluruh. Konsep ini dikenal dengan istilah *aging in place*, yaitu kemampuan lansia untuk tetap tinggal secara mandiri dan aman di lingkungan tempat tinggal mereka dengan dukungan layanan kesehatan dan sosial yang memadai.

Pelayanan gerontik di komunitas biasanya dilaksanakan melalui berbagai bentuk layanan seperti pelayanan kesehatan primer, kunjungan rumah, layanan rehabilitasi komunitas, serta dukungan sosial dari keluarga dan masyarakat. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya penilaian geriatri komprehensif (*comprehensive geriatric assessment*) yang mencakup aspek medis, psikologis, sosial, dan fungsional lansia. Penilaian multidimensional tersebut penting karena kondisi kesehatan lansia seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Selain itu, pelayanan gerontik berbasis komunitas juga melibatkan kolaborasi antara berbagai tenaga profesional kesehatan dan sektor sosial. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan bersifat terkoordinasi, berkelanjutan, serta mampu memenuhi kebutuhan lansia secara menyeluruh (Heckman et al., 2025).

Dengan demikian, pelayanan gerontik berbasis komunitas dapat dipahami sebagai sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi, komprehensif, dan berpusat pada lansia dengan tujuan mempertahankan fungsi, kemandirian, serta kualitas hidup lansia di lingkungan komunitas.

2. Prinsip Pelayanan Gerontik Berbasis Komunitas

Pelayanan gerontik berbasis komunitas dikembangkan berdasarkan sejumlah prinsip dasar yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan lansia serta mampu meningkatkan kualitas hidup mereka.

- a. Pendekatan berpusat pada individu (*person-centered care*), yaitu pendekatan yang menempatkan lansia sebagai pusat dari proses pelayanan kesehatan. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap lansia memiliki kebutuhan, preferensi, serta kondisi kesehatan yang berbeda sehingga pelayanan harus disesuaikan dengan karakteristik individu tersebut

- b. Pendekatan holistik dan multidimensional. Lansia tidak hanya menghadapi masalah kesehatan fisik, tetapi juga berbagai masalah psikologis, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan bagi lansia harus mempertimbangkan seluruh aspek tersebut agar intervensi yang diberikan lebih komprehensif dan efektif
 - c. Kontinuitas pelayanan (*continuity of care*). Lansia sering mengalami penyakit kronis yang memerlukan pemantauan jangka panjang dan pelayanan berkelanjutan. Oleh karena itu, sistem pelayanan kesehatan perlu memastikan adanya koordinasi antara berbagai tingkat pelayanan kesehatan, mulai dari pelayanan primer hingga pelayanan rujukan
 - d. Kolaborasi multidisiplin. Pelayanan bagi lansia melibatkan berbagai profesi kesehatan seperti dokter, perawat, fisioterapis, ahli gizi dan tenaga kesehatan lainnya. Pendekatan tim multidisiplin memungkinkan penanganan masalah kesehatan lansia secara lebih komprehensif
 - e. Pemberdayaan keluarga dan komunitas. Dalam banyak masyarakat, keluarga merupakan penyedia utama perawatan bagi lansia. Oleh karena itu, pemberdayaan keluarga serta keterlibatan komunitas menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelayanan gerontik berbasis komunitas. Keterlibatan komunitas dapat meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan serta memperkuat dukungan sosial bagi lansia
 - f. Aksesibilitas dan keberlanjutan layanan. Pelayanan kesehatan bagi lansia harus mudah diakses oleh seluruh lansia tanpa memandang kondisi sosial ekonomi. Sistem pelayanan yang berbasis komunitas memungkinkan layanan kesehatan lebih dekat dengan masyarakat sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan oleh lansia
3. Pendekatan Pelayanan Terintegrasi pada Lansia

Pendekatan pelayanan terintegrasi merupakan salah satu strategi penting dalam pelayanan gerontik berbasis komunitas. Lansia sering mengalami kondisi kesehatan yang kompleks, termasuk multimorbiditas, yaitu keberadaan beberapa penyakit kronis secara bersamaan. Kondisi tersebut memerlukan koordinasi pelayanan antara berbagai penyedia layanan kesehatan dan sosial agar kebutuhan lansia dapat terpenuhi secara optimal.

Organisasi Kesehatan Dunia mengembangkan pendekatan *Integrated Care for Older People (ICOPE)* sebagai strategi global untuk meningkatkan kualitas pelayanan lansia. Pendekatan ini menekankan pentingnya pelayanan yang terintegrasi dan berpusat pada individu dengan tujuan mempertahankan kapasitas intrinsik serta kemampuan fungsional lansia.

Pendekatan pelayanan terintegrasi mencakup koordinasi antara layanan kesehatan primer, layanan rumah sakit, serta pelayanan sosial berbasis komunitas. Integrasi tersebut memungkinkan lansia mendapatkan pelayanan yang berkelanjutan dan terkoordinasi sepanjang perjalanan penyakit mereka. Selain itu, pelayanan terintegrasi juga menekankan penggunaan penilaian geriatri komprehensif untuk mengidentifikasi kebutuhan kesehatan lansia secara menyeluruh. Penilaian tersebut menjadi dasar dalam penyusunan rencana perawatan individual yang melibatkan berbagai tenaga profesional kesehatan serta dukungan dari keluarga dan komunitas.

Melalui pendekatan pelayanan terintegrasi, pelayanan gerontik berbasis komunitas diharapkan mampu memberikan layanan yang lebih efektif, efisien, serta berkelanjutan bagi lansia. Pendekatan ini juga mendukung upaya global dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan lansia serta memungkinkan lansia untuk tetap hidup mandiri di komunitas mereka.

Dalam praktiknya, pelayanan gerontik berbasis komunitas mencakup berbagai intervensi yang dilakukan di luar fasilitas kesehatan institusional seperti rumah sakit atau panti. Pelayanan ini dapat dilaksanakan di rumah lansia, pusat layanan kesehatan primer, maupun fasilitas komunitas lainnya. Pendekatan ini memungkinkan lansia untuk tetap tinggal di lingkungan yang familiar bagi mereka atau yang sering disebut sebagai konsep *aging in place*, yaitu proses menua secara sehat dan mandiri di lingkungan tempat tinggal sendiri.

Pelayanan gerontik berbasis komunitas melibatkan penilaian geriatri komprehensif (*comprehensive geriatric assessment*) yang dilakukan secara multidimensional, meliputi aspek medis, psikologis, sosial, dan fungsional lansia. Pendekatan multidimensional ini penting karena kondisi kesehatan lansia seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, termasuk penyakit kronis, kondisi psikologis, dukungan sosial, dan lingkungan tempat tinggal. Selain itu, pelayanan gerontik komunitas juga menekankan koordinasi layanan antara berbagai tenaga profesional kesehatan dan sektor sosial. Kolaborasi antara tenaga kesehatan, pekerja sosial, keluarga, serta komunitas menjadi faktor penting dalam memastikan pelayanan yang berkelanjutan dan efektif bagi lansia.

C. Community-Based Elderly Care

1. Pengertian Community-Based Elderly Care

Community-Based Elderly Care adalah model pelayanan lansia yang menyediakan layanan kesehatan, sosial, dan dukungan kesejahteraan langsung di lingkungan komunitas tempat tinggal lansia. Model ini dirancang agar lansia dapat tetap mandiri dan tinggal di rumah serta lingkungan sosialnya melalui sistem

pelayanan yang terintegrasi. Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya jumlah lansia dan kebutuhan akan sistem perawatan jangka panjang yang lebih berkelanjutan dibandingkan perawatan institusional. Pelayanan ditujukan bagi lansia yang tinggal di masyarakat (*community-dwelling older adults*) dan diselenggarakan melalui koordinasi antara layanan kesehatan primer, dukungan keluarga, dan sumber daya komunitas. Sistem ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, membantu aktivitas sehari-hari, memberikan dukungan sosial, serta membuka kesempatan bagi lansia untuk tetap berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (Ding et al., 2024; Che & Cheung, 2024).

2. Prinsip Community-Based Elderly Care

Model ini didasarkan pada beberapa prinsip penting. Salah satunya adalah *aging in place*, yaitu upaya memungkinkan lansia tinggal secara aman dan mandiri di rumah atau lingkungan komunitasnya selama mungkin dengan dukungan layanan yang memadai. Selain itu, pendekatan ini menekankan integrasi layanan kesehatan dan sosial, dimana layanan kesehatan seperti pemeriksaan rutin, manajemen penyakit kronis, dan rehabilitasi dikombinasikan dengan dukungan sosial, kegiatan komunitas, serta bantuan dalam aktivitas sehari-hari. Prinsip lainnya adalah pendekatan multidisiplin, yang melibatkan dokter, perawat, tenaga kesehatan lainnya dan relawan komunitas untuk memberikan pelayanan yang holistik, mencakup kesehatan fisik, mental, maupun sosial lansia.

3. Komponen Layanan Community-Based Elderly Care

Pelayanan berbasis komunitas meliputi beberapa komponen yang saling terintegrasi yaitu 1) pelayanan kesehatan primer, mencakup pemeriksaan rutin, pengelolaan penyakit kronis, dan program promosi Kesehatan; 2) dukungan aktivitas sehari-hari, seperti bantuan mobilitas, pemenuhan kebutuhan dasar, dan rehabilitasi bagi lansia dengan keterbatasan fungsi; 3) dukungan sosial dan kegiatan komunitas, termasuk kelompok lansia, aktivitas rekreasi, edukasi kesehatan, dan dukungan emosional, yang membantu menjaga fungsi kognitif dan meningkatkan kesejahteraan psikososial; 4) dukungan bagi keluarga dan *caregiver*, meliputi edukasi perawatan, koordinasi layanan kesehatan, dan sistem rujukan ke fasilitas kesehatan lebih lanjut jika diperlukan. Integrasi layanan kesehatan dan sosial memungkinkan lansia menerima pelayanan berkelanjutan tanpa meninggalkan komunitas tempat tinggalnya.

4. Tujuan *Community-Based Elderly Care*

Tujuan utama model ini adalah meningkatkan kualitas hidup lansia melalui layanan yang mudah diakses di tingkat komunitas. Pendekatan ini bertujuan mempertahankan fungsi fisik dan mental, mencegah komplikasi penyakit kronis, serta mengurangi ketergantungan pada perawatan institusional yang lebih mahal.

Selain itu, pelayanan berbasis komunitas juga memperkuat dukungan sosial lansia dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kesejahteraan kelompok usia lanjut. Dengan demikian, *Community-Based Elderly Care* memungkinkan lansia menjalani kehidupan yang sehat, mandiri, bermakna, dan tetap terlibat dalam lingkungan sosialnya.

D. Integrated Care for Older People (ICOPE)

1. Konsep dan Tujuan ICOPE

Integrated Care for Older People (ICOPE) merupakan pendekatan pelayanan kesehatan yang dikembangkan oleh World Health Organization untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi lansia melalui sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan berpusat pada individu. Pendekatan ini diperkenalkan sebagai bagian dari strategi global untuk mendukung penuaan yang sehat (*healthy ageing*) dengan menekankan pemeliharaan kapasitas fungsional lansia sepanjang siklus kehidupan.

Konsep utama ICOPE berfokus pada upaya mempertahankan kapasitas intrinsik (*intrinsic capacity*) lansia, yaitu kombinasi kemampuan fisik dan mental yang memungkinkan individu menjalani kehidupan secara mandiri. Kapasitas intrinsik mencakup beberapa aspek penting seperti fungsi kognitif, kemampuan mobilitas, status nutrisi, kesehatan mental, fungsi sensorik, dan kapasitas vital. Penurunan pada salah satu komponen tersebut dapat mempengaruhi kemampuan lansia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari serta menurunkan kualitas hidup mereka (World Health Organization, 2017; Liu et al., 2024).

Tujuan utama ICOPE adalah untuk mencegah penurunan fungsi pada lansia melalui deteksi dini, intervensi yang tepat, serta koordinasi pelayanan kesehatan yang berkelanjutan. Pendekatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia dengan memastikan bahwa mereka memperoleh pelayanan kesehatan yang komprehensif, terkoordinasi, dan mudah diakses di tingkat komunitas.

Selain itu, ICOPE juga menekankan pentingnya pendekatan pelayanan kesehatan yang berpusat pada individu (*person-centred care*). Dalam pendekatan ini, lansia tidak hanya dipandang sebagai penerima pelayanan kesehatan, tetapi juga sebagai individu yang memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan mereka. Pendekatan tersebut terbukti dapat meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan serta kepuasan pasien terhadap layanan yang diberikan.

2. Komponen Utama Layanan ICOPE

Model pelayanan *ICOPE* terdiri dari beberapa komponen utama yang dirancang untuk mendukung pemeliharaan kapasitas intrinsik lansia secara komprehensif.

- a. Penilaian kapasitas intrinsik secara terintegrasi. Penilaian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara dini adanya penurunan fungsi pada lansia, seperti gangguan mobilitas, gangguan kognitif, depresi, gangguan penglihatan atau pendengaran, serta masalah nutrisi
- b. Perencanaan perawatan yang berpusat pada individu. Setelah dilakukan penilaian, tenaga kesehatan menyusun rencana perawatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan lansia. Rencana perawatan ini biasanya melibatkan berbagai intervensi seperti rehabilitasi fisik, konseling nutrisi, dukungan kesehatan mental, serta intervensi sosial yang mendukung kesejahteraan lansia
- c. Koordinasi pelayanan kesehatan dan sosial. Dalam model *ICOPE*, pelayanan kesehatan tidak hanya dilakukan oleh satu tenaga kesehatan, tetapi melibatkan tim multidisiplin yang terdiri dari dokter, perawat, tenaga rehabilitasi, serta tim Kesehatan lainnya. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada lansia bersifat komprehensif dan berkelanjutan
- d. Dukungan bagi keluarga dan *caregiver*. Dalam banyak kasus, keluarga merupakan pihak yang memberikan perawatan utama kepada lansia. Oleh karena itu, model *ICOPE* juga menekankan pentingnya memberikan edukasi, dukungan, serta pelatihan kepada keluarga agar mereka mampu memberikan perawatan yang optimal bagi lansia
- e. Pemanfaatan sistem informasi kesehatan dan teknologi digital untuk memantau kondisi kesehatan lansia serta meningkatkan koordinasi pelayanan kesehatan. Penggunaan teknologi ini memungkinkan pemantauan kondisi kesehatan lansia secara lebih efektif dan mendukung pengambilan keputusan klinis yang lebih tepat

3. Implementasi *ICOPE* pada Pelayanan Kesehatan Primer

Pelayanan kesehatan primer merupakan salah satu komponen utama dalam implementasi model *ICOPE*. Pendekatan ini menempatkan fasilitas pelayanan kesehatan primer sebagai titik awal dalam deteksi dini, penilaian, serta intervensi terhadap masalah kesehatan lansia. Pelayanan kesehatan primer memiliki peran penting karena berada paling dekat dengan masyarakat sehingga lebih mudah diakses oleh lansia.

Dalam implementasinya, tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan primer melakukan skrining awal untuk mengidentifikasi penurunan kapasitas intrinsik pada lansia. Skrining ini dapat mencakup pemeriksaan fungsi mobilitas, penilaian kognitif, penilaian status nutrisi, serta evaluasi kondisi psikologis lansia. Jika ditemukan adanya penurunan fungsi, maka tenaga kesehatan dapat memberikan intervensi awal atau merujuk lansia ke layanan kesehatan yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan mereka.

Selain itu, implementasi *ICOPE* juga menekankan pentingnya kerja sama antara pelayanan kesehatan primer dengan layanan kesehatan lain seperti rumah sakit, layanan rehabilitasi, serta layanan sosial berbasis komunitas. Integrasi antara berbagai layanan tersebut memungkinkan lansia mendapatkan pelayanan yang berkelanjutan dan terkoordinasi sepanjang perjalanan penyakit mereka.

Implementasi model *ICOPE* pada pelayanan kesehatan primer juga dapat memperkuat peran tenaga kesehatan komunitas dalam memberikan pelayanan bagi lansia. Perawat komunitas, misalnya, memiliki peran penting dalam melakukan kunjungan rumah, memberikan edukasi kesehatan, serta memantau kondisi kesehatan lansia secara berkelanjutan di komunitas.

Dengan demikian, penerapan model *ICOPE* dalam pelayanan kesehatan primer dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan lansia melalui pendekatan yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan berpusat pada individu. Pendekatan ini juga mendukung upaya global dalam menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan populasi lansia yang terus meningkat.

E. *Chronic Care Model*

1. Konsep *Chronic Care Model*

Chronic Care Model (CCM) merupakan kerangka kerja yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi individu dengan penyakit kronis melalui pendekatan pelayanan yang terintegrasi, berkesinambungan, dan berpusat pada pasien. Model ini berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya prevalensi penyakit kronis yang memerlukan sistem pelayanan kesehatan yang

lebih terkoordinasi dibandingkan pendekatan pelayanan kesehatan tradisional yang berfokus pada penyakit akut (Goh et al., 2022; Al-Qahtani, 2024).

Pendekatan *CCM* menekankan bahwa pengelolaan penyakit kronis memerlukan interaksi yang produktif antara tim pelayanan kesehatan yang proaktif dan pasien yang terinformasi serta mampu berperan aktif dalam mengelola kesehatannya. Model ini mengintegrasikan berbagai komponen sistem pelayanan kesehatan untuk mendukung manajemen penyakit kronis jangka panjang, termasuk penguatan sistem pelayanan kesehatan, dukungan pengambilan keputusan klinis, serta pemberdayaan pasien dalam manajemen diri.

Dalam konteks pelayanan lansia, penerapan *CCM* menjadi semakin penting karena populasi lansia umumnya mengalami multimorbiditas, yaitu keberadaan dua atau lebih penyakit kronis secara bersamaan. Kondisi ini menuntut pendekatan pelayanan kesehatan yang komprehensif, terkoordinasi, dan berorientasi pada kebutuhan individu lansia. Sistem pelayanan kesehatan yang tidak terintegrasi dapat menyebabkan fragmentasi pelayanan, duplikasi intervensi, serta peningkatan risiko komplikasi pada lansia dengan penyakit kronis.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi *CCM* dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memperbaiki hasil klinis pasien dengan penyakit kronis. Intervensi berbasis *CCM* terbukti dapat meningkatkan kontrol penyakit kronis, memperbaiki koordinasi pelayanan kesehatan, serta meningkatkan kualitas hidup pasien melalui pendekatan pelayanan yang lebih terstruktur dan kolaboratif (Goh et al., 2022). Selain itu, pengembangan model manajemen penyakit kronis berbasis tim multidisiplin juga menunjukkan potensi dalam meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan serta keberlanjutan sistem pelayanan kesehatan (Kadree et al., 2025).

Dengan demikian, *CCM* memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi lansia dengan penyakit kronis melalui integrasi antara sistem pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, pasien, serta sumber daya komunitas.

2. Komponen Model dalam Pengelolaan Penyakit Kronis Lansia

Chronic Care Model terdiri dari enam komponen utama yang saling terintegrasi untuk mendukung pengelolaan penyakit kronis secara efektif.

a. *Health System Organization*

Health System Organization mendukung penyediaan pelayanan berkualitas bagi pasien dengan penyakit kronis. Sistem pelayanan kesehatan perlu memiliki kepemimpinan yang kuat, kebijakan yang mendukung manajemen penyakit kronis, serta sistem peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara berkelanjutan. Dalam pelayanan lansia, organisasi kesehatan

perlu mengembangkan sistem pelayanan yang terintegrasi antara pelayanan primer, rumah sakit, serta layanan kesehatan berbasis komunitas untuk memastikan kesinambungan perawatan.

b. *Delivery System Design*

Delivery System Design menekankan pembagian peran yang jelas dalam tim kesehatan serta perencanaan pelayanan yang bersifat proaktif. Pelayanan kesehatan tidak hanya diberikan ketika pasien datang ke fasilitas kesehatan, tetapi juga melalui pemantauan kesehatan secara berkala serta perencanaan perawatan jangka panjang. Dalam pelayanan lansia, desain sistem pelayanan dapat mencakup manajemen kasus, kunjungan rumah, serta koordinasi pelayanan kesehatan antarprofesi untuk mengelola kondisi kesehatan lansia secara komprehensif.

c. *Decision Support*

Decision support merupakan dukungan pengambilan keputusan klinis melalui penggunaan pedoman praktik klinis berbasis bukti. Tenaga kesehatan perlu menggunakan pedoman tersebut dalam praktik pelayanan untuk memastikan bahwa intervensi yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan terbaik. Dalam pelayanan geriatri, pedoman klinis sangat penting untuk mengelola berbagai kondisi kronis yang sering terjadi pada lansia seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit kardiovaskular.

d. *Clinical Information Systems*

Clinical information systems merupakan sistem informasi yang memungkinkan tenaga kesehatan memantau kondisi pasien secara sistematis melalui penggunaan registri pasien, rekam medis elektronik, serta sistem pemantauan kesehatan berbasis teknologi. Sistem ini membantu tenaga kesehatan dalam mengidentifikasi pasien dengan penyakit kronis, memantau perkembangan kondisi kesehatan pasien, serta meningkatkan koordinasi pelayanan Kesehatan.

e. *Self-Management Support*

Self-management support merupakan dukungan yang diberikan kepada pasien agar mampu berperan aktif dalam mengelola kondisi kesehatannya. Pendekatan ini meliputi edukasi kesehatan, pelatihan keterampilan pengelolaan penyakit, serta dukungan psikososial bagi pasien dan keluarga. Pada lansia dengan penyakit kronis, dukungan self-management sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan, menjaga pola hidup sehat, serta mencegah komplikasi penyakit kronis.

f. *Community Resources and Policies*

Komponen terakhir adalah pemanfaatan sumber daya komunitas dan kebijakan kesehatan untuk mendukung pengelolaan penyakit kronis. Kolaborasi antara sistem pelayanan kesehatan dan komunitas dapat meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan serta memperkuat program promosi kesehatan di masyarakat. Program berbasis komunitas seperti kelompok aktivitas lansia, program edukasi kesehatan, serta dukungan sosial dapat membantu lansia mempertahankan kesehatan fisik dan mental serta meningkatkan kualitas hidup mereka.

F. *Home-Based Care Model*

1. Konsep Pelayanan Perawatan Lansia di Rumah

Home-based care merupakan pendekatan pelayanan kesehatan yang memberikan perawatan medis, keperawatan, rehabilitasi, serta dukungan sosial kepada lansia di lingkungan rumah mereka. Pendekatan ini berkembang seiring meningkatnya populasi lansia dan tingginya prevalensi penyakit kronis yang memerlukan pelayanan kesehatan berkelanjutan namun tidak selalu memerlukan perawatan di rumah sakit. Model pelayanan ini memungkinkan lansia untuk tetap tinggal di rumah (*aging in place*) dengan mempertahankan kemandirian dan kualitas hidup mereka (Yu et al., 2024).

Pelayanan kesehatan berbasis rumah umumnya mencakup berbagai layanan seperti pemantauan kondisi kesehatan, manajemen penyakit kronis, rehabilitasi fisik, edukasi kesehatan, serta dukungan psikososial. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan yang mempengaruhi kesejahteraan lansia. Studi sistematis menunjukkan bahwa integrasi layanan kesehatan dengan layanan sosial dalam *home-based care* dapat meningkatkan efektivitas perawatan serta mendukung lansia untuk tetap hidup secara mandiri di komunitas (Curioni et al., 2023).

Selain itu, perkembangan konsep *aging in place* juga menekankan pentingnya modifikasi lingkungan rumah agar lebih aman dan mendukung aktivitas lansia. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa adaptasi lingkungan rumah, seperti peningkatan aksesibilitas dan keamanan rumah, merupakan komponen penting dalam keberhasilan program *home-based care* bagi lansia (Cha, 2025).

2. Peran Keluarga dan Tenaga Kesehatan

Implementasi *home-based care* memerlukan kolaborasi yang kuat antara keluarga dan tenaga kesehatan. Dalam banyak kasus, keluarga berperan sebagai caregiver utama yang memberikan perawatan sehari-hari kepada lansia, termasuk

membantu aktivitas kehidupan sehari-hari, memantau kondisi kesehatan, serta memastikan kepatuhan terhadap pengobatan. Dukungan keluarga terbukti menjadi faktor penting dalam keberhasilan perawatan lansia di rumah.

Tenaga kesehatan memiliki peran dalam memberikan pelayanan profesional serta memastikan bahwa lansia mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan kesehatannya. Tim pelayanan *home-based care* biasanya terdiri dari dokter, perawat, fisioterapis, ahli gizi, dan tenaga kesehatan lainnya yang bekerja secara kolaboratif dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi lansia.

Perawat memiliki peran strategis dalam model ini karena mereka sering menjadi tenaga kesehatan yang paling dekat dengan lansia di lingkungan rumah. Perawat bertanggung jawab dalam melakukan penilaian kondisi kesehatan, memberikan perawatan langsung, serta memberikan edukasi kepada keluarga mengenai pengelolaan penyakit kronis pada lansia. Pendekatan interdisipliner dalam pelayanan *home-based care* terbukti dapat meningkatkan koordinasi pelayanan serta memberikan hasil kesehatan yang lebih baik bagi lansia dengan kondisi penyakit kronis.

3. Manfaat *Home-Based Care* bagi Lansia

Home-based care memberikan berbagai manfaat bagi lansia, baik dari aspek kesehatan, psikologis, maupun sosial. Salah satu manfaat utama dari pendekatan ini adalah memungkinkan lansia tetap tinggal di lingkungan yang familiar sehingga dapat mempertahankan rasa aman, kemandirian, serta kualitas hidup mereka. Penelitian menunjukkan bahwa layanan *home-based care* dapat meningkatkan akses lansia terhadap pelayanan kesehatan sekaligus mengurangi kebutuhan rawat inap di rumah sakit. Pendekatan ini juga terbukti efektif dalam meningkatkan manajemen penyakit kronis serta memperbaiki hasil kesehatan pada lansia dengan kondisi kesehatan kompleks.

Selain itu, intervensi berbasis rumah juga dapat memberikan dampak positif terhadap fungsi kognitif dan kesejahteraan psikologis lansia. Program intervensi kesehatan yang dilakukan di rumah, seperti aktivitas fisik, stimulasi kognitif, dan edukasi kesehatan, terbukti dapat membantu mempertahankan fungsi kognitif serta meningkatkan kualitas hidup lansia dengan gangguan kognitif ringan.

Dari perspektif sistem pelayanan kesehatan, *home-based care* juga memberikan manfaat ekonomi karena dapat mengurangi biaya perawatan rumah sakit dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya kesehatan. Oleh karena itu, banyak negara mulai mengembangkan layanan kesehatan berbasis rumah sebagai bagian dari strategi pelayanan kesehatan bagi populasi lansia yang terus meningkat (Zhou et al., 2025).

G. Intergenerational Care Model

1. Konsep Pelayanan Lintas Generasi

Intergenerational care model merupakan pendekatan pelayanan sosial dan kesehatan yang mengintegrasikan interaksi antara kelompok usia yang berbeda, khususnya antara lansia dan generasi yang lebih muda seperti anak-anak, remaja, atau dewasa muda. Pendekatan ini bertujuan membangun hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antar generasi serta meningkatkan kesejahteraan sosial dan psikologis bagi semua pihak yang terlibat (Canedo-García et al., 2023).

Konsep pelayanan lintas generasi didasarkan pada asumsi bahwa interaksi sosial antar generasi dapat memperkuat kohesi sosial, meningkatkan pemahaman antar kelompok usia, serta mengurangi stereotip negatif terhadap lansia. Dalam konteks pelayanan gerontik, program lintas generasi menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan keterlibatan sosial lansia sekaligus mencegah isolasi sosial yang sering dialami oleh populasi lanjut usia (Park, 2024).

Selain itu, pendekatan lintas generasi juga sejalan dengan konsep *active ageing* yang menekankan pentingnya partisipasi sosial, kesehatan, dan keamanan bagi lansia. Melalui keterlibatan dalam aktivitas bersama generasi muda, lansia memiliki kesempatan untuk tetap berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat. Keterlibatan tersebut dapat membantu mempertahankan fungsi kognitif, meningkatkan kesehatan mental, serta memperkuat peran sosial lansia dalam komunitas (Mariano et al., 2024).

2. Bentuk Program Lintas Generasi di Komunitas

Program lintas generasi dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk kegiatan di tingkat komunitas yang melibatkan interaksi langsung antara lansia dan generasi muda. Salah satu bentuk program yang banyak dikembangkan adalah program pendidikan lintas generasi, di mana lansia berbagi pengalaman hidup, pengetahuan, maupun keterampilan kepada generasi muda melalui kegiatan pembelajaran informal atau aktivitas komunitas (Canedo-García et al., 2023). Selain itu, kegiatan sosial dan rekreasi bersama seperti olahraga ringan, seni, musik, maupun kegiatan budaya juga dapat menjadi sarana interaksi antara lansia dan generasi muda. Aktivitas bersama ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan sosial, tetapi juga memperkuat hubungan emosional antar generasi.

Beberapa komunitas juga mengembangkan program layanan sosial berbasis lintas generasi seperti program relawan muda yang membantu lansia dalam aktivitas sehari-hari, penggunaan teknologi digital, maupun kegiatan kesehatan di tingkat komunitas. Program tersebut tidak hanya memberikan dukungan bagi

lansia, tetapi juga meningkatkan empati dan kesadaran sosial generasi muda terhadap kebutuhan kelompok lansia.

Di beberapa negara, pendekatan lintas generasi juga diterapkan melalui integrasi layanan pendidikan dan layanan bagi lansia, misalnya pusat layanan yang menggabungkan taman kanak-kanak dengan pusat aktivitas lansia. Model ini memungkinkan interaksi sosial yang lebih intensif antar generasi serta memberikan manfaat perkembangan bagi anak-anak sekaligus meningkatkan kesejahteraan emosional lansia.

3. Dampak terhadap Kesejahteraan Lansia dan Masyarakat

Implementasi program lintas generasi memberikan berbagai dampak positif terhadap kesejahteraan lansia maupun masyarakat secara luas. Bagi lansia, keterlibatan dalam program lintas generasi dapat meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan emosional melalui peningkatan interaksi sosial serta pengurangan perasaan kesepian dan isolasi sosial. Interaksi dengan generasi muda juga memberikan stimulasi kognitif melalui komunikasi, pembelajaran bersama, serta partisipasi dalam aktivitas sosial yang bermakna. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan dalam program lintas generasi dapat membantu mempertahankan fungsi kognitif, meningkatkan rasa tujuan hidup, serta meningkatkan kualitas hidup lansia.

Dari perspektif masyarakat, program lintas generasi juga berkontribusi dalam memperkuat solidaritas sosial serta meningkatkan hubungan antar generasi dalam komunitas. Interaksi yang positif antara generasi muda dan lansia dapat mengurangi stereotip negatif terhadap lansia serta meningkatkan penghargaan terhadap pengalaman dan kontribusi mereka dalam kehidupan sosial. Selain itu, pendekatan lintas generasi dapat mendukung terciptanya komunitas yang lebih inklusif dan ramah lansia. Melalui kolaborasi lintas generasi, masyarakat dapat membangun lingkungan sosial yang mendukung penuaan yang sehat serta meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Dengan demikian, model lintas generasi merupakan salah satu pendekatan pelayanan gerontik yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan lansia sekaligus memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat melalui interaksi yang bermakna antara generasi yang berbeda.

H. Analisis Kelebihan dan Keterbatasan Model

1. Perbandingan Model Pelayanan Gerontik

Beberapa model pelayanan gerontik yang berkembang secara global meliputi Integrated Care for Older People (ICOPE), Chronic Care Model (CCM), Community-

Based Elderly Care, Home-Based Care, dan Intergenerational Care. Kelima model tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan kualitas hidup lansia melalui pelayanan yang terintegrasi, namun memiliki fokus pendekatan yang berbeda.

Model ICOPE menekankan pelayanan kesehatan terintegrasi yang berfokus pada pemeliharaan kapasitas intrinsik lansia serta deteksi dini penurunan fungsi. Chronic Care Model berfokus pada pengelolaan penyakit kronis secara sistematis melalui koordinasi pelayanan kesehatan dan dukungan manajemen diri pasien. Community-Based Elderly Care menekankan penyediaan layanan kesehatan dan sosial di tingkat komunitas dengan melibatkan keluarga, tenaga kesehatan, dan sumber daya masyarakat. Home-Based Care menempatkan rumah sebagai lokasi utama pelayanan kesehatan bagi lansia, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas. Sementara itu, Intergenerational Care menekankan interaksi antara lansia dan generasi muda untuk meningkatkan kesejahteraan psikososial serta kohesi sosial masyarakat.

2. Kelebihan Model

Setiap model memiliki keunggulan tertentu. *ICOPE* unggul dalam pendekatan preventif dan pemeliharaan kapasitas fungsi lansia. *Chronic Care Model* efektif dalam pengelolaan penyakit kronis secara terstruktur. *Community-Based Elderly Care* memperkuat akses layanan kesehatan dan dukungan sosial di tingkat masyarakat. *Home-Based Care* meningkatkan kenyamanan dan akses pelayanan bagi lansia melalui perawatan di rumah. Sementara *Intergenerational Care* meningkatkan kesejahteraan psikososial lansia melalui interaksi sosial antar generasi.

3. Keterbatasan Implementasi

Meskipun memiliki berbagai kelebihan, masing-masing model juga memiliki keterbatasan. *ICOPE* memerlukan sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan tenaga kesehatan dengan kompetensi geriatri. *Chronic Care Model* membutuhkan perubahan sistem pelayanan kesehatan yang cukup kompleks. *Community-Based Elderly Care* memerlukan dukungan sumber daya komunitas serta koordinasi lintas sektor. *Home-Based Care* sering menghadapi kendala keterbatasan tenaga kesehatan, biaya pelayanan, serta kesiapan keluarga. Sementara *Intergenerational Care* memerlukan dukungan kebijakan dan partisipasi masyarakat agar program dapat berkelanjutan.

Secara umum, penerapan model pelayanan gerontik perlu disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, serta sistem pelayanan kesehatan di masing-masing negara atau komunitas agar dapat memberikan manfaat optimal bagi lansia.

I. Implikasi bagi Pengembangan Pelayanan Lansia di Indonesia

1. Relevansi Model Global dengan Konteks Indonesia

Perkembangan berbagai model pelayanan gerontik global seperti Community-Based Elderly Care, Integrated Care for Older People (ICOPE), Chronic Care Model, Home-Based Care, dan Intergenerational Care Model memberikan kerangka konseptual penting dalam pengembangan sistem pelayanan kesehatan lansia di berbagai negara, termasuk Indonesia. Model-model tersebut menekankan pendekatan pelayanan yang terintegrasi, berkelanjutan, serta berpusat pada individu untuk meningkatkan kualitas hidup lansia.

Pendekatan Community-Based Elderly Care menekankan penyediaan layanan kesehatan dan dukungan sosial bagi lansia di tingkat komunitas melalui integrasi antara pelayanan kesehatan primer, keluarga, dan sumber daya masyarakat. Model ini bertujuan mempertahankan kemandirian lansia serta memungkinkan mereka tetap tinggal di lingkungan sosialnya melalui dukungan layanan kesehatan, sosial, dan aktivitas komunitas yang terkoordinasi. Pendekatan ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang memiliki sistem pelayanan kesehatan berbasis masyarakat serta jaringan dukungan sosial yang kuat di tingkat komunitas (Crocker et al., 2024; Wang et al., 2024).

Pendekatan yang dikembangkan oleh World Health Organization melalui model ICOPE menekankan pemeliharaan kapasitas intrinsik lansia melalui deteksi dini penurunan fungsi serta intervensi berbasis komunitas. Pendekatan ini relevan dengan kondisi Indonesia yang menghadapi peningkatan jumlah lansia serta tingginya prevalensi penyakit kronis pada populasi lanjut usia (World Health Organization, 2017; Liu et al., 2024).

Selain itu, Chronic Care Model juga memiliki relevansi dengan kondisi pelayanan kesehatan di Indonesia karena banyak lansia mengalami penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan penyakit kardiovaskular. Pendekatan manajemen penyakit kronis yang terstruktur dalam model ini dapat membantu meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan bagi lansia melalui koordinasi pelayanan yang lebih baik (Goh et al., 2022; Al-Qahtani, 2024).

Model Home-Based Care juga sangat relevan dengan konteks sosial budaya di Indonesia yang masih menempatkan keluarga sebagai sumber utama dukungan bagi lansia. Pelayanan kesehatan berbasis rumah dapat memperkuat peran keluarga dalam perawatan lansia sekaligus meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi lansia yang memiliki keterbatasan mobilitas (Yu et al., 2024).

Sementara itu, Intergenerational Care Model juga sejalan dengan nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi hubungan kekeluargaan dan

solidaritas antar generasi. Interaksi antara lansia dan generasi yang lebih muda dapat meningkatkan partisipasi sosial lansia sekaligus memperkuat kohesi sosial dalam komunitas (Gualano et al., 2023).

Dalam konteks sistem kesehatan Indonesia, berbagai pendekatan tersebut memiliki kesesuaian dengan pengembangan pelayanan kesehatan berbasis komunitas melalui Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) yang menerapkan pendekatan siklus hidup. Pendekatan ini memungkinkan pelayanan kesehatan dilakukan secara terpadu bagi seluruh kelompok usia, sehingga memberikan ruang integrasi pelayanan lansia dalam sistem pelayanan kesehatan komunitas yang lebih komprehensif.

2. Peluang Integrasi dalam Pelayanan Kesehatan Primer

Pelayanan kesehatan primer memiliki peran strategis dalam pengembangan pelayanan kesehatan lansia di Indonesia. Dalam kerangka penguatan pelayanan kesehatan primer, Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) dikembangkan dengan pendekatan siklus hidup yang mencakup pelayanan bagi seluruh kelompok usia mulai dari bayi, anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Pendekatan ini memberikan peluang untuk mengintegrasikan berbagai model pelayanan gerontik global dalam sistem pelayanan kesehatan berbasis komunitas.

Model *Community-Based Elderly Care* menekankan penyediaan layanan kesehatan dan dukungan sosial bagi lansia di lingkungan komunitas melalui kolaborasi tenaga kesehatan, keluarga, dan sumber daya masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan karakteristik pelayanan kesehatan primer di Indonesia yang berbasis masyarakat, sehingga pemantauan kesehatan, edukasi, dan dukungan sosial lansia dapat dilakukan melalui kegiatan komunitas.

Prinsip *ICOPE* yang menekankan deteksi dini penurunan kapasitas intrinsik dapat diterapkan melalui kegiatan skrining kesehatan lansia, pemantauan kondisi kesehatan secara berkala, serta upaya promotif dan preventif yang dilakukan di tingkat komunitas. Integrasi ini dapat membantu menjaga kapasitas fungsional lansia serta mencegah terjadinya disabilitas yang lebih berat.

Selain itu, prinsip *Chronic Care Model* dapat diterapkan melalui penguatan manajemen penyakit kronis pada lansia, pemantauan kondisi kesehatan secara berkelanjutan, serta koordinasi pelayanan antara fasilitas kesehatan dan keluarga. Pendekatan ini penting mengingat sebagian besar lansia mengalami penyakit kronis yang memerlukan pengelolaan jangka panjang.

Pendekatan *Home-Based Care* juga dapat dikembangkan sebagai bagian dari pelayanan kesehatan primer melalui pemantauan kesehatan lansia di lingkungan tempat tinggal serta pemberdayaan keluarga dalam proses perawatan. Strategi ini

dapat meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi lansia yang memiliki keterbatasan mobilitas atau kondisi kesehatan tertentu.

Di sisi lain, pendekatan *intergenerational care* juga memiliki peluang untuk dikembangkan melalui kegiatan komunitas dalam Posyandu ILP yang berbasis siklus hidup. Kegiatan pelayanan kesehatan, edukasi kesehatan, maupun aktivitas sosial yang melibatkan berbagai kelompok usia dapat menjadi sarana interaksi antara lansia dan generasi yang lebih muda. Interaksi ini tidak hanya mendukung partisipasi sosial lansia, tetapi juga memperkuat dukungan sosial serta solidaritas antar generasi di tingkat komunitas.

Dengan demikian, integrasi berbagai model pelayanan gerontik global dalam sistem pelayanan kesehatan primer berbasis komunitas dapat menjadi strategi penting dalam pengembangan pelayanan lansia di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif, berkelanjutan, serta sesuai dengan kebutuhan lansia dalam konteks kehidupan masyarakat.

J. Penutup

Berbagai model pelayanan gerontik yang telah dibahas, seperti *Integrated Care for Older People (ICOPE)*, *Chronic Care Model*, *Home-Based Care*, dan *Intergenerational Care Model*, menunjukkan bahwa pelayanan lansia memerlukan pendekatan yang terintegrasi, komprehensif, dan berpusat pada kebutuhan individu. Model ICOPE yang dikembangkan oleh World Health Organization menekankan pemeliharaan kapasitas intrinsik lansia melalui pelayanan kesehatan yang terkoordinasi, sementara *Chronic Care Model* berfokus pada pengelolaan penyakit kronis secara sistematis. Di sisi lain, *Home-Based Care* menempatkan rumah sebagai pusat pelayanan kesehatan dengan dukungan keluarga dan tenaga kesehatan, sedangkan *Intergenerational Care Model* menekankan pentingnya interaksi sosial antar generasi dalam komunitas.

Secara keseluruhan, berbagai pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan lansia tidak hanya mencakup aspek medis, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial, psikologis, dan lingkungan. Oleh karena itu, pengembangan pelayanan lansia perlu mengintegrasikan berbagai pendekatan tersebut dalam sistem pelayanan berbasis komunitas guna mendukung peningkatan kualitas hidup lansia secara berkelanjutan.

Referensi

- Al-Qahtani, A. A. (2024). Improving Outcomes of Type 2 Diabetes Mellitus Patients In Primary Care With Chronic Care Model: A Narrative Review. *Journal of General and Family Medicine*, 25(4), 171–178. DOI: <https://doi.org/10.1002/jgf2.659>
- Barajas-Nava, L. A., Garduño-Espinosa, J., Mireles-Dorantes, J. M., Medina-Campos, R., & García-Peña, M. C. (2022). Models of Comprehensive Care For Older Persons With Chronic Diseases: A Systematic Review With A Focus on Effectiveness. *BMJ Open*, 12(8), e059606. DOI: <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-059606>
- Cha, S. M. (2025). A Systematic Review of Home Modifications For Aging In Place In Older Adults. *Healthcare*, 13(7), 752. <https://doi.org/10.3390/healthcare13070752>.
- Che, R.-P., & Cheung, M.-C. (2024). Factors Associated With Intended Utilization of Home-Based Long-Term Care Among Older Adults In China. *The Journals of Gerontology: Series B*, 79(9), gbae146. <https://doi.org/10.1093/geronb/gbae146>
- Crocker, T. F., Ensor, J., Lam, N., Jordão, M., Bajpai, R., Bond, M., Forster, A., Riley, R. D., Andre, D., & Brundle, C. (2024). Community-Based Complex Interventions to Sustain Independence In Older People: Systematic Review And Network Meta-Analysis. *BMJ*, 384, e077764. <https://doi.org/10.1136/bmj-2023-077764>
- Curioni, C., Silva, A. C., Damião, J., Castro, A., Huang, M., Barroso, T., Araújo, D., & Guerra, R. (2023). The Cost-Effectiveness of Homecare Services for Adults And Older Adults: A Systematic Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(4), 3373. <https://doi.org/10.3390/ijerph20043373>
- Ding, Z., Li, Y., Zhang, H., & Liu, Q. (2024). Long-Term Care for Community-Dwelling Older Adults: A Systematic Review of Clinical Practice Guidelines. *Geriatric Nursing*, 56, 64–72. <https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2024.05.016>
- Goh, L. H., Siah, C. J. R., Tam, W. W. S., Tai, E. S., & Young, D. Y. L. (2022). Effectiveness of The Chronic Care Model For Adults With Type 2 Diabetes In Primary Care: A Systematic Review And Meta-Analysis. *Systematic Reviews*, 11, 273. DOI: <https://doi.org/10.1186/s13643-022-02117-w>
- Heckman, G. A., Gimbel, S., Mensink, C., Kroetsch, B., Jones, A., Nasim, A., Northwood, M., Elliott, J., & Morrison, A. (2025). The Integrated Care Team: A Primary Care-Based Approach To Support Older Adults With Complex Health

- Needs. *Healthcare Management Forum*, 38(3), 192–199. <https://doi.org/10.1177/08404704241293051>.
- Kamei, T., Kawada, A., Minami, K., Takahashi, Z., Ishigaki, Y., Yamanaka, T., Yamamoto, N., Yamamoto, Y., Suzuki, Y., & Watanabe, T. (2024). Effectiveness of An Interdisciplinary Home Care Approach For Older Adults With Chronic Conditions: A Systematic Review And Meta-Analysis. *Geriatrics & Gerontology International*. <https://doi.org/10.1111/ggi.14931>
- Liu, A., Zhang, Y., Zhao, Y., Zhu, W., Mei, Y., & He, P. (2024). Integrated Care For Older People Improved Intrinsic Capacity In Elderly Patients: A Case-Control Study. *BMC Geriatrics*, 24, 898. <https://doi.org/10.1186/s12877-024-05509-w>.
- Ng, H. L., Wu, X. V., Yap, S. Y., Yeo, S. N. B., Dino, M. J., & Jiang, Y. (2024). Exploring The Experiences of Older Adults And Their Caregivers In Home-Based Palliative Care: A Systematic Review And Meta-Synthesis. *Seminars in Oncology Nursing*. <https://doi.org/10.1016/j.soncn.2024.151753>.
- Peters, R., Ee, N., Ward, S. A., Kenning, G., Radford, K., Goldwater, M., Xu, Y., Hamilton, M., Lautenschlager, N. T., & Rockwood, K. (2021). Intergenerational Programmes Bringing Together Community-Dwelling Non-Familial Older Adults And Children: A Systematic Review. *Archives of Gerontology and Geriatrics*, 94, 104356. <https://doi.org/10.1016/j.archger.2021.104356>
- Potter, C. M., Malli, M., & Harper, S. (2024). Community-Based Person-Centred Integrated Care Networks For Healthy Ageing In Place: A Scoping Review Protocol. *BMJ Open*, 14(5), e083077. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2023-083077>
- Qin, W. (2024). Coordinated Care Experiences Among Middle-Aged And Older Adults With Multiple Chronic Cond Itions. *The Gerontologist*, 64(6), gnae024. DOI: <https://doi.org/10.1093/geront/gnae024>
- Savino, M., De Luca, L., Nocentini, A., & Menesini, E. (2025). Intergenerational Interventions And Their Impact on Active Aging: A Systematic Review. *Psychogeriatrics International*. <https://doi.org/10.1016/j.inpsyc.2025.100142>
- Webster, M., Norwood, K., Waterworth, J., & Leavey, G. (2024). Effectiveness Of Intergenerational Exchange Programs Between Adolescents And Older Adults: A Systematic Review. *Journal of Intergenerational Relationships*, 22(4), 603–644. <https://doi.org/10.1080/15350770.2023.2267532>
- World Health Organization. (2017). *Integrated Care For Older People: Guidelines On Community-Level Interventions To Manage Declines In Intrinsic Capacity*.

WHO.

<https://www.who.int/publications/i/item/9789241550109>.

World Health Organization. (2023). *Integrated Care For Older People (ICOPE)*.
<https://www.who.int/initiatives/icope>

Yu, Y., Zhang, J., Petrovic, M., Zhang, X., & Zhang, W. H. (2024). Utilization Of Home- And Community-Based Services Among Older Adults Worldwide: A Systematic Review And Meta-Analysis. *International Journal of Nursing Studies*, 155, 104774.
<https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2024.104774>.

Zhou, W., Zhang, X., & Lyu, X. (2025). Monitoring Utilisation Patterns Of Home- And Community-Based Services For Healthy Ageing: A Cross-Sectional Study. *BMC Geriatrics*, 25, 291. <https://doi.org/10.1186/s12877-025-05918-5>.

Zou, C., Amos-Richards, D., Jagannathan, R., et al. (2024). Effect Of Home-Based Lifestyle Interventions On Cognition In Older Adults With Mild Cognitive Impairment: A Systematic Review. *BMC Geriatrics*, 24, 200.
<https://doi.org/10.1186/s12877-024-04798-5>

Glosarium

A

Aging in place adalah Kemampuan lansia untuk tetap tinggal secara aman, mandiri, dan nyaman di rumah atau komunitasnya meskipun terjadi penurunan kondisi akibat penuaan.

Active ageing adalah Proses mengoptimalkan peluang kesehatan, partisipasi, dan keamanan guna meningkatkan kualitas hidup seiring bertambahnya usia.

C

Community-dwelling older adults adalah lansia yang tinggal di masyarakat atau di rumah mereka sendiri (baik sendiri maupun bersama keluarga) dan tidak tinggal di institusi perawatan jangka Panjang

Caregiver adalah Individu yang memberikan perawatan dan dukungan kepada lansia dalam konteks layanan kesehatan di komunitas.

H

Healthy ageing adalah proses mengembangkan dan mempertahankan kemampuan fungsional yang memungkinkan kesejahteraan pada lansia, menekankan bahwa lansia tetap dapat menjalani kehidupan yang bermakna, mandiri, dan produktif meskipun mengalami perubahan biologis akibat penuaan.

I

Inklusif adalah bersifat terbuka dan melibatkan semua individu tanpa membedakan latar belakang atau kondisi.

P

Penilaian multidimensional adalah pengkajian menyeluruh terhadap aspek fisik, fungsional, psikologis, sosial, dan lingkungan lansia untuk menentukan kebutuhan dan rencana perawatan yang tepat.

Person-centred care adalah pendekatan pelayanan yang menempatkan individu sebagai pusat perawatan dengan menghargai kebutuhan, preferensi, dan nilai-nilainya.

PROFIL PENULIS



Fenti Hasnani, S.Kep., Ners., M.A.Kes.

Penulis adalah seorang akademisi dan praktisi di bidang keperawatan yang memiliki minat khusus pada keperawatan gerontik dan kesehatan lansia. Aktif dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup lanjut usia. Memiliki pengalaman dalam penyusunan karya ilmiah, modul pembelajaran, serta keterlibatan dalam berbagai program pemberdayaan keluarga dan komunitas lansia. Penulis mendedikasikan hidupnya bagi dunia pendidikan kesehatan, kemanusiaan, dan pendampingan pasien. Ia merupakan lulusan Program Studi Keperawatan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dan melanjutkan pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Di luar dunia akademik, ia aktif terlibat dalam berbagai kegiatan Family Supporting Group di yayasan yang bergerak di bidang perawatan pasien dengan kanker. Sejak tahun 2003, ia secara konsisten mendampingi pasien kanker, khususnya ibu dan anak—sebuah peran yang memperkaya kepekaan empati serta perspektif kemanusiaannya dalam praktik kesehatan, terutama keperawatan.

Pengalaman panjang sebagai pendidik, peneliti, pendamping pasien, dan pegiat sosial membentuk cara pandangnya tentang pentingnya etika, empati, dan sensitivitas budaya dalam pelayanan kesehatan. Melalui karya-karyanya, penulis mengajak pembaca memahami bahwa

Email: fenti.hasnani@poltekkesjakarta1.ac.id

Motto: "Dari perubahan demografi menuju kekuatan bangsa: lansia adalah aset, bukan sekadar angka."

PROFIL PENULIS



Dr. Iskim Luthfa, S.Kep., Ns., M.Kep.

Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 lulus pada tahun 2007 dan Ners tahun 2009 di Universitas Muhammadiyah Semarang. Penulis melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Padjadjaran dan lulus pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan studi S3 di Universitas Airlangga dan lulus tahun 2024. Riwayat pekerjaan sejak tahun 2009 sampai sekarang sebagai Dosen Program Studi Fakultas Ilmu Keperawatan Departemen Keperawatan Komunitas, Universitas Islam Sultan Agung. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Penulis telah menerbitkan 7 Buku Ajar dan 7 Buku referensi. Pada tahun 2025 penulis mendapatkan penghargaan sebagai Penulis Buku Ajar Terproduktif Tingkat Nasional. Artikel yang dihasilkan dari penelitian telah diterbitkan di berbagai Jurnal baik di SINTA maupun di Scopus. Penulis juga aktif dalam organisasi profesi sebagai pengurus IPEGRI dan IPPKI Jawa Tengah. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: iskimluthfa@unissula.ac.id. ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-5216-5356>. Scopus ID: 58164747300. Motto: "Hidup adalah perjalanan, jadi nikmati setiap langkahnya"

PROFIL PENULIS



Dr. Donny Hendra, S.Kep., Ns., M.Kep.

Merupakan seorang akademisi dan praktisi di bidang keperawatan yang memiliki minat khusus pada keperawatan komunitas dan keperawatan gerontik. Saat ini, penulis aktif sebagai dosen pada Program Studi D.III Keperawatan di Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru, serta terlibat dalam berbagai kegiatan tridarma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis menyelesaikan pendidikan

di bidang keperawatan dan terus mengembangkan kompetensi melalui berbagai pelatihan, seminar, serta kegiatan ilmiah yang relevan dengan perkembangan ilmu keperawatan. Fokus keilmuan penulis meliputi keperawatan komunitas, keperawatan gerontik, serta promosi kesehatan, khususnya dalam upaya peningkatan kualitas hidup kelompok rentan seperti lansia dan pasien dengan penyakit kronis. Dalam bidang penelitian, penulis aktif melakukan kajian terkait intervensi keperawatan berbasis komunitas, termasuk topik mengenai aktivitas fisik, kualitas hidup, serta manajemen penyakit kronis pada kelompok usia lanjut. Salah satu karya ilmiah yang dikembangkan adalah penelitian mengenai Efektivitas *Walking Exercise* terhadap peningkatan kualitas hidup wanita menopause dengan diabetes mellitus di wilayah kerja puskesmas di Kota Pekanbaru.

Selain kegiatan akademik, penulis juga aktif dalam pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program edukasi kesehatan, pendampingan lansia, serta penguatan peran keluarga dalam perawatan kesehatan. Penulis percaya bahwa pendekatan berbasis keluarga dan komunitas merupakan kunci dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Melalui penulisan buku ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu keperawatan, khususnya dalam menghadapi tantangan penuaan populasi di Indonesia. Penulis juga berkomitmen untuk terus berkarya dan berinovasi dalam bidang pendidikan dan pelayanan keperawatan demi terciptanya masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.

Penulis dapat dihubungi melalui institusi tempat penulis mengabdikan untuk keperluan akademik dan kolaborasi ilmiah. Email: [Dodondhendra80@gmail.com](mailto:Dodonhendra80@gmail.com)

MOTTO : *"Merawat dengan ilmu, mengabdikan dengan hati, dan memuliakan lansia dengan empati."*

PROFIL PENULIS



Dr. Ni Made Riasmini, S.Kp., M.Kes., Sp.Kom.

Lahir di Bali, 03 Mei 1962. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan-Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan lulus tahun 1992. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Spesialis Keperawatan Komunitas pada Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2004. Dilanjutkan menempuh Pendidikan S3 Keperawatan pada Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2013. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1985 sebagai dosen Akper Depkes RI., tahun 2001-2024 sebagai dosen Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta III dan mulai tahun 2025 sebagai dosen Prodi Keperawatan Bogor Poltekkes Kemenkes Bandung. Penulis juga pernah menjabat sebagai Wakil Direktur II di Poltekkes Kemenkes Jakarta III (2018-2024). Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Bandung mengampu mata kuliah Keperawatan Komunitas, Keperawatan Keluarga dan Keperawatan Gerontik. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, pembicara dalam seminar, workshop dan pelatihan. Penulis merupakan asesor LAM-PTKes, Asesor BKD, Reviewer Nasional Penelitian dosen di lingkungan Poltekkes. Penulis juga menjadi Reviuwer Jurnal Keperawatan Indonesia (JKI) FIK-UI, Health and Social Care in the Community dan Frontier in Aging. Penulis juga aktif dalam Ikatan Perawat Gerontik Indonesia (IPEGRI) sebagai Ketua Bidang Diklat, sebagai anggota Kolegium Pengampu Cabang Disiplin Ilmu Keperawatan Gerontik dan sebagai Core Team Project kerjasama IPEGRI dengan National Colledge of Nursing Japan (NCNJ). Pernah mengikuti Training Course in Curriculum Development/Geriatric Nursing at the Japanese Red Cross Kyushu International College of Nursing tahun 2014 dan 2016 serta poster presentation di Jepang tahun 2017 serta mengikuti The Spring Program Maternity Nursing ang Gerontologycal Nursing at Osaka University tahun 2023. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: maderiasmini@gmail.com.

Motto : *“Advancing Healthy Aging Through Community Empowerment”*

PROFIL PENULIS



Ns. Mela Hayani, S.Kep., M.Kep.

Penulis lahir di Bireuen 19 Oktober 1987 merupakan staf pengajar aktif di program studi S1 Keperawatan Universitas Bina Bangsa Getsempena Banda Aceh Penulis merupakan tamatan dari Sekolah Menengah Atas No 1 Di Bireuen Aceh pada tahun 2004 Melanjutkan pendidikan di D.III Keperawatan Universitas Sumatera Utara dan selesai pada Tahun 2007 Kemudian menyelesaikan pendidikan S1 Keperawatan di Universitas Sumatera Utara tahun 2009 selesai Profesi Ners di Universitas Sumatera Utara pada tahun 2011 dan penulis meraih gelar Magister Keperawatan Bidang Komunitas di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh pada tahun 2019. Penulis pernah bekerja sebagai pengajar Prodi S1 Keperawatan di Sekolah Tinggi Kesehatan Seuramo Barat Meulaboh, Aceh Barat sejak tahun 2011-2012 pernah aktif sebagai pengajar di Sekolah D.III. Keperawatan Teungku Fakinah dari tahun 2015 - 2018 dan saat ini penulis aktif sebagai tim pengajar pada prodi Sarjana Keperawatan di Universitas Bina Bangsa Getsempena Banda Aceh dari tahun 2022 hingga sekarang serta Penulis sebagai anggota organisasi Ikatan Perawat Maternitas serta aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis pernah ikut serta dalam penulisan buku yang berjudul Buku Referensi Kesehatan Holistik Lintas Profesi: Pendekatan Terpadu Untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Sinopsis

Buku referensi ini membahas peran keperawatan gerontik dalam merespons penuaan populasi di Indonesia yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan, perawatan jangka panjang, serta dukungan keluarga dan komunitas. Pembahasan diawali dengan demografi penuaan untuk menjelaskan tren pertambahan lansia dan implikasinya terhadap sistem kesehatan. Selanjutnya, buku menempatkan konsep *healthy aging* sebagai kerangka utama promosi kesehatan lansia—menjaga kapasitas fungsional, mencegah disabilitas, dan memperkuat kemandirian.

Pada aspek klinis, buku menguraikan asuhan keperawatan lansia dengan multimorbiditas, termasuk pengkajian holistik, penetapan prioritas, keselamatan pasien, serta tantangan polifarmasi dan penurunan fungsi. Isu penting lainnya adalah gangguan kognitif dan demensia, mencakup deteksi dini, pendekatan komunikasi, dan dukungan aktivitas sehari-hari. Buku ini juga menekankan perawatan paliatif dan *end-of-life care* yang berfokus pada kenyamanan, kontrol gejala, dan pengambilan keputusan bersama pasien-keluarga.

Dalam konteks sosial-budaya Indonesia, buku membahas dukungan keluarga dan beban caregiver, serta strategi edukasi dan penguatan kapasitas perawat keluarga. Sebagai penutup, disajikan model pelayanan gerontik berbasis komunitas yang menekankan kesinambungan perawatan, pemberdayaan lansia, dan kolaborasi layanan primer. Buku ini ditujukan bagi mahasiswa, dosen, perawat, dan pengelola program sebagai rujukan praktis untuk meningkatkan mutu asuhan gerontik di Indonesia.

Buku referensi ini membahas peran keperawatan gerontik dalam merespons penuaan populasi di Indonesia yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan, perawatan jangka panjang, serta dukungan keluarga dan komunitas. Pembahasan diawali dengan demografi penuaan untuk menjelaskan tren pertumbuhan lansia dan implikasinya terhadap sistem kesehatan. Selanjutnya, buku menempatkan konsep healthy aging sebagai kerangka utama promosi kesehatan lansia—menjaga kapasitas fungsional, mencegah disabilitas, dan memperkuat kemandirian.

Pada aspek klinis, buku menguraikan asuhan keperawatan lansia dengan multimorbiditas, termasuk pengkajian holistik, penetapan prioritas, keselamatan pasien, serta tantangan polifarmasi dan penurunan fungsi. Isu penting lainnya adalah gangguan kognitif dan demensia, mencakup deteksi dini, pendekatan komunikasi, dan dukungan aktivitas sehari-hari. Buku ini juga menekankan perawatan paliatif dan end-of-life care yang berfokus pada kenyamanan, kontrol gejala, dan pengambilan keputusan bersama pasien-keluarga.

Dalam konteks sosial-budaya Indonesia, buku membahas dukungan keluarga dan beban caregiver, serta strategi edukasi dan penguatan kapasitas perawat keluarga. Sebagai penutup, disajikan model pelayanan gerontik berbasis komunitas yang menekankan kesinambungan perawatan, pemberdayaan lansia, dan kolaborasi layanan primer. Buku ini ditujukan bagi mahasiswa, dosen, perawat, dan pengelola program sebagai rujukan praktis untuk meningkatkan mutu asuhan gerontik di Indonesia.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



ISBN 978-634-7556-98-1 (PDF)



9

786347

556981